Perfil V3 · código por código

# Enfermedades Respiratorias

Los 83 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Enfermedades Respiratorias, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

## Situaciones clínicas 38 códigos

### 1.05.1.001 Absceso pulmonar

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

#### QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso pulmonar: cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo, >85% por aspiración de flora oral (alcohol, epilepsia, sedantes, trastorno deglutorio + sepsis dental).
- Clínica subaguda de semanas: fiebre vespertina, sudoración, baja de peso y vómica purulenta y fétida; simula TBC o cáncer. Ubicación en segmentos dependientes (posterior de lóbulos superiores, apical de inferiores).
- Confirmación: radiografía y TAC de tórax. Polimicrobiano con anaerobios (Fusobacterium, Prevotella, Peptostreptococcus): todo esquema debe cubrirlos.
- Tratamiento médico (85-90% cura): ampicilina/sulbactam 1,5-3 g c/6 h EV y luego amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/8-12 h VO, 4 a 6 semanas en total, hasta el cierre de la cavidad.
- Mayor de 50 años, fumador o desdentado sin factores de aspiración: fibrobroncoscopía para descartar carcinoma (epidermoide cavitado, pared >15 mm) o cuerpo extraño.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar. Cirugía o drenaje solo si >6 cm, refractario o hemoptisis masiva; rotura a pleura (pioneumotórax) exige tubo pleural.

#### PREGUNTAS (2)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 165**

Un paciente alcohólico, fumador de 10 paquetes año, presenta, desde hace 7 días, un cuadro de tos, con expectoración purulenta y fiebre hasta 38°C. Ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas. Al examen físico está febril, con apremio respiratorio. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: **El examen más adecuado para proseguir el estudio es:**

**A)** Broncoscopía
**B)** Videotoracoscopía
**C)** TAC de tórax
**D)** PET-TC
**E)** Resonancia magnética nuclear de tórax

Respuesta C. La radiografía mostraba un absceso pulmonar gigante. La TAC de tórax lo caracteriza mejor y ayuda a descartar un cáncer subyacente. La broncoscopía viene después, si hay riesgo de cáncer o falla el tratamiento.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 45 años, bebedor excesivo, con mala dentadura, consulta por 3 semanas de fiebre nocturna, baja de peso de 4 kg y tos con expectoración abundante, verde oscura y de olor pestilente. Radiografía: cavidad de 4,5 cm con nivel hidroaéreo horizontal en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Está estable. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** Lobectomía superior derecha
**B)** Ampicilina/sulbactam EV y luego amoxicilina/clavulánico oral, 4 a 6 semanas en total
**C)** Drenaje percutáneo del absceso guiado por TAC
**D)** Ciprofloxacino oral por 7 días y control
**E)** Esquema RHZE por 6 meses

Respuesta B. Absceso pulmonar primario por aspiración (alcohol, mala dentadura, esputo fétido, cavidad con nivel en segmento dependiente). El tratamiento es médico, con cobertura anaerobia, por 4 a 6 semanas: 85–90% cura sin procedimientos. Cirugía y drenaje quedan para la falla médica; el ciprofloxacino no cubre anaerobios.

### 1.05.1.002 Asma bronquial grave

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

#### QUÉ HAY QUE SABER

- Asma grave: no controlada pese a corticoide inhalado en dosis alta + LABA (escalones 4-5 GINA), o que requiere esa terapia para mantener el control.

- Antes de rotularla, confirmar el diagnóstico con espirometría y corregir lo corregible: técnica inhalatoria (aerocámara), adherencia, tabaco, rinosinusitis, reflujo y obesidad; la mayoría del asma «difícil» no es grave.
- Marcadores de mal pronóstico: crisis graves o intubación previa, ≥2 cursos de corticoide oral al año, uso excesivo de SABA, mala percepción de la disnea.
- Manejo inicial en APS: CI dosis alta/LABA con estrategia MART, plan de acción escrito y cursos cortos de prednisona en exacerbaciones; evitar el corticoide oral crónico por su toxicidad.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar para fenotipificar (eosinófilos, IgE) y agregar tiotropio o biológicos (anti-IgE, anti-IL5).

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta de práctica**

Mujer de 35 años con asma desde la adolescencia, en tratamiento con budesonida/formoterol en dosis alta más tiotropio. Se verificó adherencia y técnica inhalatoria correctas, y se trataron su rinosinusitis y su reflujo. Aun así tuvo 3 cursos de prednisona oral en el último año. Eosinófilos en sangre 480/$\mu$L, IgE total elevada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Mantener prednisona oral 20 mg/día indefinidamente
**B)** Agregar teofilina como única medida
**C)** Cambiar a salbutamol en horario cada 4 horas
**D)** Suspender el corticoide inhalado por falta de respuesta
**E)** Derivar a broncopulmonar para evaluar terapia biológica

Respuesta E. Asma grave: no controlada pese a corticoide inhalado en dosis alta con LABA, habiendo corregido adherencia, técnica y comorbilidades. Con fenotipo eosinofílico corresponde derivar a especialista para biológicos (anti-IL5 o anti-IgE). El corticoide oral crónico es la última opción por su toxicidad.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 42 años con asma, en tratamiento con fluticasona/salmeterol en dosis media. Refiere síntomas diurnos casi diarios, despertares nocturnos semanales y 2 crisis en el año. Al observarlo usar su inhalador presurizado, dispara sin coordinar con la inspiración y no hace apnea. Retira sus inhaladores en forma irregular. **Antes de catalogarlo como asma grave y subir de escalón, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Agregar prednisona oral en dosis bajas permanentes
**B)** Corregir la técnica inhalatoria (por ejemplo, con aerocámara) y reforzar la adherencia
**C)** Derivar de inmediato para terapia biológica
**D)** Agregar montelukast y teofilina
**E)** Cambiar a salbutamol nebulizado en horario

Respuesta B. La mayoría del asma 'difícil' no es grave: es mala técnica, mala adherencia o comorbilidades no tratadas. Antes de subir de escalón o hablar de asma grave hay que corregir la técnica (aerocámara con el presurizado), reforzar la adherencia y reevaluar en semanas.

## 1.05.1.003 Asma bronquial leve y moderada

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Diagnóstico: síntomas variables (sibilancias, disnea, opresión, tos) + espirometría con respuesta broncodilatadora (VEF1 sube >12% y >200 mL). Espirometría normal no descarta: variabilidad del PEF >10% o metacolina (caída del VEF1 >20%).
- Control GINA en las últimas 4 semanas: síntomas diurnos >2/semana, despertar nocturno, rescate >2/semana, limitación de actividad. 0 = controlada; 1-2 = parcial; 3-4 = no controlada.
- Nunca SABA en monoterapia (más crisis graves y muerte): todo asmático recibe corticoide inhalado desde el primer escalón.
- Escalones 1-2: budesonida/formoterol 160/4,5 mcg 1 puff a demanda; escalón 3: CI/formoterol diario dosis baja + rescate (MART). Vía alternativa: CI diario + salbutamol SOS.
- Si no hay control, revisar técnica, adherencia y comorbilidades antes de subir un escalón; si está controlado ≥3 meses, intentar bajar.
- Seguimiento completo en APS: controles periódicos con evaluación del control, técnica inhalatoria, plan de acción y vacunas (influenza, neumococo); derivar si llega a escalón 4-5.

**PREGUNTAS (12)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 76**

Paciente de 45 años, fumadora activa de 40 paquetes año, consulta por tos irritativa asociada a disnea y crisis de sibilancias que aparecen en relación a la actividad física e infecciones respiratorias. Se realiza una espirometría que muestra: Basal: VEF1/CVF: 62% VEF1: 2,4L (62% del valor teórico) CVF: 4,9L (92% del valor teórico) Post-Salbutamol VEF1/CVF: 74% VEF1: 3,6L (89% del valor teórico) CVF: 5,0L (95% del valor teórico) **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Asma
**B)** EPOC
**C)** Fibrosis pulmonar
**D)** Bronquiectasias
**E)** Bronquitis crónica

Respuesta A. Patrón obstructivo (VEF1/CVF 62%) que revierte con broncodilatador: el VEF1 sube 1,2 L (50%) y la relación se normaliza a 74%. Es una obstrucción reversible, es decir, asma, aunque la paciente fume.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 19**

Una paciente con antecedente de rinitis alérgica y asma consulta por disnea frecuente, asociada a respiración sibilante y tos, que aparece con frecuencia luego de exponerse a los alergenos, en la noche, cuando cursa con alguna infección respiratoria alta o después de realizar ejercicio. Al examen físico tiene FR: 13 rpm, satura 96% a FiO2 ambiental y en su examen pulmonar destacan sibilancias espiratorias bilaterales. **¿Cuál es la conducta más adecuada con ella?**

**A)** Evitar los alergenos por 3 meses
**B)** Iniciar salmeterol 2 puff cada 12 horas
**C)** Iniciar salbutamol 2 puff cada 6 horas
**D)** Iniciar fluticasona 2 puff cada 12 horas
**E)** Iniciar terapia de desensibilización a los alergenos

Respuesta D. Asma con síntomas frecuentes, incluidos nocturnos: necesita tratamiento antiinflamatorio de mantención con corticoide inhalado, con un broncodilatador de rescate. El salbutamol en horario y el LABA solo no tratan la inflamación.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 32 años con asma, en tratamiento solo con salbutamol inhalado a demanda. En el último mes tuvo síntomas diurnos 4 días a la semana, despertó 2 veces por tos y usa salbutamol casi todos los días. No refiere limitación de actividad. Espirometría: VEF1 72% con respuesta broncodilatadora positiva. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Mantener salbutamol a demanda y citar en 3 meses
**B)** Indicar salbutamol en horario cada 6 horas
**C)** Iniciar corticoide inhalado en dosis baja con LABA, o budesonida/formoterol
**D)** Prednisona oral 40 mg al día por 1 mes
**E)** Derivar para terapia biológica anti-IgE

Respuesta C. Tres criterios GINA (síntomas diurnos > 2/semana, despertar nocturno, rescate > 2/semana): asma no controlada, en monoterapia con SABA, que está proscrita. Hay que iniciar tratamiento antiinflamatorio de mantención: CI en dosis baja + LABA, o budesonida/formoterol según la vía preferida.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 27 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.928cc 100% 6.106cc 103% VEF1 4.163cc 76% 5.040cc 92% VEF1/CVF 65% 73% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

**A)** Asma bronquial
**B)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**C)** Bronquiectasias
**D)** Bronquitis crónica
**E)** Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta A. Diagnóstico: Asma bronquial (opción A). Tiene un cuadro clínico y espirometría (patrón obstructivo que mejora con BD) compatibles con asma.. La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es una mezcla de manifestaciones de artritis reumatoide (artritis), lupus (úlceras orales, rash malar, pericarditis, lupus cutáneo subagudo), esclerodermia (fenómeno de Raynaud, disfagia, esclerodactilia) y mios

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 17 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 43 años, ex fumadora de 8 paquetes año, consulta por disnea, aso- ciada a tos con expectoración mucosa y respiración sibilante, que aparecen después de realizar ejercicio o presentar infecciones virales. Al examen físico presenta disminu- ción del murmullo pulmonar, sibilancias espiratorias y aumento del diámetro antero- posterior toráxico. Se realiza una radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO El tratamiento inicial más adecuado es:

**A)** Salmeterol inhalado
**B)** Ipratropio inhalado
**C)** Budesonida inhalado
**D)** Salbutamol inhalado
**E)** Tiotropio inhalado

Respuesta D. Es un asma y lo más correcto es iniciar salbutamol SOS, más un corticoide inhala- do (budesonida en este caso). Por tanto es una mala pregunta. Si fuerzan a elegir el tra- tamiento “inicial”, yo creo que la respuesta es salbutamol.

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar**

años de evolución. En ocasiones, los síntomas aumentan significativamente, especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador POE l 5.928cc 100% 6.106cc 103% MEF] ao0o 504000 VEFYCVE jes l [78% l Su radiografía de tórax se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): El diagnóstico más probable es:

**A)** Asma bronquial
**B)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**C)** Bronquiectasias
**D)** Bronquitis crónica
**E)** Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta A. Tiene un asma, por tener un patrón obstructivo (VEF1/CVF menor a 70%), que mejora con broncodilatador (sube más de 15% en cualquiera de los parámetros. Nota: no son 15 puntos porcentuales, sino 15%. Ejemplo, 76% a 92% hay 16 puntos porcentuales, pero subió 21%, ya que 16/76 = 0,21). La radiografía es normal. 10 paquetes-año ya aumenta el riesgo de EPOC y cáncer, pero lo habitual es que estas enfer

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 63 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 62 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.810cc 98% 5.870cc 99% VEF1 3.835cc 70% 4.696cc 91% VEF1/CVF 66% 80% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

**A)** Asma bronquial
**B)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**C)** Bronquiectasias
**D)** Bronquitis crónica
**E)** Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta A. Aunque por la edad y por el tabaquismo podría ser un EPOC, la verdad es que lo habitual es que el EPOC tenga más de 15 paquetes-año y, lo más importante, en este caso la espirometría es un patrón obstructivo que mejora con BD, por lo que está confirmado el diagnóstico de asma.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 146 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 24 años presenta tos frecuente y disnea, asociada a sibilancias, que son mayores en la noche y que aumentan con el ejercicio, cuando fuma y en la primavera. Al examen físico presenta espiración prolongada y examen pulmonar con sibilancias bilaterales inspiratorias y espiratorias. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

**A)** Evitar la exposición a desencadenantes
**B)** Salbutamol inhalado cada 6 horas
**C)** Budesonida inhalada cada 12 horas
**D)** Salmeterol inhalado cada 12 horas
**E)** Desensibilizar para los alérgenos

Respuesta C. [Pregunta disputada] Es una pregunta técnicamente mala, ya que debe recibir corticoides inhalados (C) más broncodilatadores de corta acción (B) y, dada la abundancia de síntomas, probablemente también de larga acción (D). Además, obviamente debe dejar de fumar (A). De las opciones, tengo la impresión de que la respuesta podría ser C, porque los corticoides son los que previenen la aparición de sín

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 22 años con episodios de disnea y sibilancias. Radiografía de tórax PA y lateral: hiperinsuflación bilateral, horizontalización de costillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

**A)** Asma bronquial
**B)** Neumotórax espontáneo
**C)** Derrame pleural bilateral
**D)** Neumonía bilateral
**E)** Fibrosis quística

Respuesta A. Hiperinsuflación en radiografía de tórax durante crisis de disnea con sibilancias en joven = asma bronquial. El atrapamiento aéreo produce la imagen de hiperinsuflación.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 127 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 38 años, con antecedente de asma bronquial en tratamiento con flu8casona inhalada, 1 puff de 250 mcg cada 12 horas, y salbutamol, 1 puff en caso de necesidad, y rini8s alérgica en tratamiento con loratadina 10 mg al día, presenta aumento de su sintomatología en primavera, requiriendo uso frecuente de salbutamol 2 a 3 veces al día. Al examen Fsico está en buenas condiciones, eupneico y en su examen pulmonar se auscultan sibilancias bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

**A)** Aumentar la dosis de flu2casona inhalada
**B)** Indicar salbutamol en horario
**C)** Prohibir la ac2vidad :sica al aire libre
**D)** Agregar inhibidor del receptor de leucotrienos
**E)** Mantener tratamiento

Respuesta A. Es una pregunta discuGble, más aún si tomamos en cuenta que disGntas guías sobre el tratamiento de asma dicen cosas diferentes. A conGnuación, el resumen de lo recomendado por la guía GINA: El régimen de elección (Track 1) uGliza MART (“Terapia de Mantención And Rescate”), a base de formoterol + corticoides (budesonida) - Paso 1: MART SOS. - Paso 2: Agregar MART 1 puff al día horario (aceptable man

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 15 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 30 años con tos nocturna y disnea de esfuerzo. Espirometría basal normal. Se realiza test de provocación con metacolina: caída del VEF1 del 22% con dosis de 8 mg/mL. ¿Cuál es el diagnóstico?

**A)** Asma bronquial
**B)** EPOC
**C)** Bronquiectasias
**D)** Fibrosis pulmonar
**E)** Bronquiolitis obliterante

Respuesta A. Caída del VEF1 ≥20% con metacolina = hiperreactividad bronquial = test positivo para asma. Es el gold standard cuando la espirometría basal es normal.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 17 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 25 años con tos y sibilancias recurrentes. Espirometría muestra VEF1/CVF 68% (< 70%), VEF1 72% del predicho. Post broncodilatador: VEF1 aumenta 15% y 220 mL. ¿Cuál es el diagnóstico?

**A)** Asma bronquial
**B)** EPOC leve
**C)** Bronquiectasias
**D)** Fibrosis pulmonar idiopática
**E)** Traqueomalacia

Respuesta A. Obstrucción espirométrica + prueba broncodilatadora positiva (aumento VEF1 ≥12% y ≥200 mL) = asma bronquial. La reversibilidad distingue asma de EPOC.

## 1.05.1.004 Bronquiectasias

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

### QUÉ HAY QUE SABER

- Bronquiectasias: dilatación bronquial permanente por ciclo infección-inflamación; causas: secuela de TBC e infecciones infantiles (sarampión, coqueluche), fibrosis quística, discinesia ciliar, inmunodeficiencias.
- Sospecha: tos crónica con broncorrea purulenta abundante, peor en la mañana, de años; infecciones respiratorias a repetición, hemoptisis recurrente, crépitos y acropaquia.

- Confirmación con TACAR: signo del anillo de sello (bronquio más ancho que su arteria), riel de tranvía, falta de afilamiento periférico. En el joven, buscar la causa (test del sudor).
- Manejo inicial: kinesioterapia respiratoria y drenaje de secreciones, antibiótico en exacerbaciones según cultivo de expectoración, vacuna influenza y neumococo, cesación tabáquica.
- Seguimiento: control periódico en APS con cultivo en exacerbaciones; derivar si hay hemoptisis significativa, exacerbaciones frecuentes o Pseudomonas. Hemoptisis masiva: decúbito sobre el lado que sangra y embolización.

**PREGUNTAS (7)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 119**

Un paciente de 26 años de edad presenta un cuadro de tos con expectoración de algunos años de evolución, mayor en las mañana y que ha presentado hemoptisis. Su examen físico presenta acropaquias y a la auscultación pulmonar hay crepitaciones y estertores bilaterales. **El diagnóstico más probable es:**

**A)** Bronquiectasias
**B)** Cáncer pulmonar
**C)** Tuberculosis pulmonar
**D)** Asma
**E)** EPOC

Respuesta A. Paciente joven con tos y expectoración de años, mayor en la mañana, hemoptisis, acropaquia y estertores bilaterales: bronquiectasias. La edad y los años de evolución alejan el cáncer y el EPOC.

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 87**

Paciente con infecciones respiratorias recurrentes y expectoración matinal de 200 mL al día. **¿Cuál es el examen de elección para el estudio?**

**A)** Broncoscopía con lavado broncoalveolar
**B)** Espirometría con test de reversibilidad
**C)** TAC de tórax de alta resolución
**D)** Radiografía de tórax seriada
**E)** Cultivo de esputo

Respuesta C. Broncorrea matinal abundante con infecciones recurrentes: sospecha de bronquiectasias. El examen de elección para confirmarlas es la TACAR (signo del anillo de sello).

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 57**

Un paciente de 22 años, que desde la infancia tiene infecciones respiratorias a repetición, que requerían uso de antibiótico. Al examen físico, es mesomorfo, con FC: 72x', PA:120/80 mmHg, su examen físico presenta crepitaciones y estertores bilateral. Se solicita radiografía de tórax que muestra múltiples imágenes de dilataciones bronquiales bilaterales, compatibles con bronquiectasias. **¿Cuál es el examen para proseguir el estudio?**

**A)** Broncoscopía con biopsia bronquial
**B)** Prueba de provocación bronquial con metacolina
**C)** Espirometría
**D)** Test del sudor
**E)** Baciloscopías de expectoración

Respuesta D. Adulto joven con infecciones desde la infancia y bronquiectasias bilaterales ya visibles: el siguiente paso es buscar la causa. La fibrosis quística, una de las causas principales de bronquiectasias, se estudia con test del sudor.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 9 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 40 años, con antecedente de neumonías a repe8ción y consumo de tabaco de 5 paquetes-año, consulta por tos frecuente y produc8va, mayor durante las mañanas, con expectoración mucosa y, en ocasiones, hemoptoica. Al examen Fsico presenta dedos en palillo de tambor (acropaquias), frecuencia cardíaca 75 lpm y presión arterial 110/70 mmHg. La auscultación cardiopulmonar revela ritmo regular en dos tonos sin soplos, murmullo pulmonar presente y simétrico, con auscultación de crepitaciones y estertores bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

**A)** Bronqui2s crónica
**B)** Bronquiectasias
**C)** Carcinoma broncogénico
**D)** Tuberculosis pulmonar
**E)** Insuficiencia cardíaca conges2va

Respuesta B. Tiene un cuadro compaGble con bronquiectasias. Se debe revisar el resumen de semiología respiratoria. El diagnóstico se confirma con TAC de tórax de alta resolución.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 107 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 45 años, con antecedente de infecciones respiratorias a repetición en la infancia, presenta broncorrea de cerca de 300cc al día, mayor en la mañana, asociada a disnea de esfuerzos y tos con expectoración. Además, refiere cuadros de exacerbación de sus síntomas que ocurren varias veces al año, por lo que usa antibióticos. Al examen físico tiene signos vitales dentro de rango normal y, en la auscultación pulmonar se objetiva espiración prolongada, además de auscultarse estertores y sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.sciencephoto.com): ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el diagnóstico?

**A)** Recuento de inmunoglobulina A, G y M
**B)** TAC de tórax
**C)** Baciloscopías y cultivo para micobacterias
**D)** Lavado bronquioalveolar
**E)** Broncoscopía

Respuesta B. Diagnóstico: TAC de tórax (opción B). El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 32 años, presenta infecciones respiratorias recurrentes, desde su infancia, que en varias ocasiones han requerido de antibióticos, asociado a disnea de esfuerzos. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,5°C y al examen pulmonar se auscultan múltiples crépitos y sibilancias bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Fuente: http://www.lungindia.com/ El examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico es:

**A)** Fibrobroncoscopía
**B)** Cuantificación de inmunoglobulinas
**C)** TAC de tórax
**D)** Test del sudor
**E)** Espirometría

Respuesta D. Tiene imágenes sugerentes de bronquiectasias bilaterales. El resto del cuadro clínico es compatible con una FQ, a pesar de la edad (neumonías bacterianas a repetición: habitualmente por S. aureus y P. aureginosa).

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 18 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 23 años, que desde la infancia tiene tos frecuente, con expectoración abundante, mayor en la mañana, que en ocasiones es hemoptoica. Además una o dos veces al año, se exacerba los síntomas, con necesidad de uso de antibióticos. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (radiografía de tórax AP con afectación en ambas bases, en patrón broncointersticial). ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

**A)** Recuento de inmunoglobulinas
**B)** Test del sudor
**C)** Resonancia magnética de tórax
**D)** TAC de tórax
**E)** Baciloscopías de expectoración

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (TAC de tórax). La clínica es de bronquiectasias, que se diagnostican preferentemente con un TAC de tórax.. El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

## 1.05.1.005 Bronquitis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

### QUÉ HAY QUE SABER

- Bronquitis aguda: tos con o sin expectoración (incluso purulenta) tras un cuadro viral, sin signos de neumonía; casi siempre viral y autolimitada.
- Diagnóstico clínico: afebril o febrícula, signos vitales normales y examen pulmonar sin focalización (roncus aislados, sin crépitos). No requiere radiografía salvo sospecha de neumonía.
- Pedir radiografía si hay fiebre persistente, taquipnea, taquicardia, hipoxemia, crépitos focales o adulto mayor con compromiso del estado general.
- Tratamiento sintomático: hidratación, paracetamol, miel; salbutamol si hay broncoespasmo. Sin antibióticos: el color del esputo no indica infección bacteriana.

- Educar que la tos puede durar 2-3 semanas. Tos >3 semanas: reevaluar (coqueluche, asma, TBC); >8 semanas es tos crónica.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 40 años, sin comorbilidades, consulta por tos con expectoración amarillenta de 10 días, posterior a un cuadro de coriza. Está afebril, con FC 80 por minuto, FR 16 por minuto y saturación 97%; al examen pulmonar hay roncus aislados, sin crépitos. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

**A)** Amoxicilina por 7 días por la expectoración amarilla
**B)** Corticoides orales
**C)** Radiografía de tórax y levofloxacino
**D)** Manejo sintomático, sin antibióticos, explicando que la tos puede durar hasta 3 semanas
**E)** Azitromicina por 5 días

Respuesta D. Es una bronquitis aguda: tos, con o sin expectoración incluso purulenta, tras una infección viral, sin signos de neumonía (afebril, signos vitales normales, sin focalización). Es mayormente viral y autolimitada, y la tos puede durar 2 a 3 semanas. No requiere radiografía ni antibióticos; el color del esputo no indica infección bacteriana.

## 1.05.1.006 Bronquitis crónica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Bronquitis crónica: tos productiva al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos, descartadas otras causas; típica del fumador, con expectoración mucosa matinal.
- Confirmación: definición clínica + espirometría. Si VEF1/CVF post-BD ≥0,70 es bronquitis crónica sin EPOC; si <0,70, es EPOC con fenotipo bronquítico.
- Radiografía de tórax para descartar cáncer, TBC y bronquiectasias; baciloscopía si hay síntomas respiratorios prolongados.
- Tratamiento: cesación tabáquica (la medida clave), vacuna influenza anual y antineumocócica; broncodilatador si hay disnea; antibiótico solo en exacerbaciones con esputo purulento.
- Seguimiento en APS con espirometría periódica para detectar progresión a EPOC y reforzar la abstinencia tabáquica.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 155**

Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Cáncer de pulmón
**B)** Tuberculosis pulmonar
**C)** Fibrosis pulmonar
**D)** EPOC
**E)** Bronquitis crónica

Respuesta E. Fumador con tos y expectoración crónicas, mayores en la mañana: bronquitis crónica. No es EPOC porque la espirometría es normal: la EPOC exige VEF1/CVF < 0,70 post-BD.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 155**

Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año, presenta tos con expectoración mucosa de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana, y presenta 2 infecciones respiratorias al año que requieren antibióticos. Su radiografía de tórax y su espirometría son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Cáncer de pulmón
**B)** Tuberculosis pulmonar
**C)** Fibrosis pulmonar
**D)** EPOC
**E)** Bronquitis crónica

Respuesta E. La bronquitis crónica es tos productiva al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos, descartadas otras causas. Sin obstrucción en la espirometría (VEF1/CVF post broncodilatador sobre 0,7) no puede diagnosticarse EPOC, y la radiografía normal hace improbables cáncer, TBC y fibrosis. Lo clave es dejar de fumar.

## 1.05.1.007 Cáncer bronquial primario

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en fumador (85-90% de los casos) >40-50 años con tos nueva o que cambia, hemoptisis, baja de peso, neumonía que no resuelve, acropaquia o disfonía.
- No microcítico (85%): adenocarcinoma (periférico, el más frecuente, también en no fumadores), epidermoide (central, cavita, hipercalcemia por PTHrP), células grandes. Microcítico (15%): central, SIADH, Cushing ectópico, Lambert-Eaton.
- Invasión local: Pancoast (dolor C8-T1 + Horner), síndrome de vena cava superior, parálisis recurrencial o frénica, derrame pleural.
- Estudio inicial: radiografía y TAC de tórax; luego biopsia (fibrobroncoscopía o punción) y etapificación con PET-CT y RM cerebral.
- Tratamiento lo define el especialista: no microcítico I-II lobectomía con linfadenectomía; microcítico nunca cirugía de entrada (cisplatino + etopósido + radioterapia).
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología; el médico general maneja síntomas (hipercalcemia: suero fisiológico + bifosfonato) y apoya la cesación tabáquica.

### PREGUNTAS (8)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 11**

Un paciente de 76 años, jubilado de la minería y fumador de 20 paquetes año consulta por tos y disnea de 2 meses de evolución, asociada a expectoración mucosa, que a veces tiene estrías de sangre. Ha bajado 4 kilogramos de peso y presenta astenia. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar conservado, bilateral, con escasos crépitos y sibilancias, mayores en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: [radiografía: nódulo pulmonar]. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?**

**A)** TAC de tórax
**B)** Broncoscopía
**C)** Baciloscopías
**D)** PET
**E)** Resonancia magnética de tórax

Respuesta A. Lo primero es revisar las radiografías previas; luego, la TAC es el examen de elección para enfrentar el nódulo pulmonar. El PET-CT es útil, pero viene después de la TAC; la biopsia por broncoscopía, al final.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 29**

Imagen radiográfica de tórax PA en hombre de 62 años, fumador, que muestra masa hiliar derecha irregular con atelectasia del lóbulo superior derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Carcinoma espinocelular (epidermoide) de pulmón
**B)** Derrame pleural
**C)** Neumotórax espontáneo
**D)** Neumonía por aspiración
**E)** Adenocarcinoma periférico

Respuesta A. Masa hiliar central en fumador con atelectasia lobar: carcinoma epidermoide, de localización central, que obstruye el bronquio y colapsa el lóbulo distal. El adenocarcinoma es periférico.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 71 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 66 años, hipertenso, fumador de 40 paquetes-año consulta por un cuadro de tos, de 2 meses de evolución, con expectoración mucosa o mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica asociados a baja de peso. Al examen físico, tiene disminución del murmullo pulmonar bilateral, mayor a derecha, con crepitaciones pulmonar en el lado derecho. Se palpan adenopatías supraclaviculares bilaterales y se constata hipocratismo digital. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 29%, hemoglobina: 9,5 g/dl, leucocitos: 11.000 por mm3, plaquetas: 140.000 por mm3. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.medicinainternaaldia.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

**A)** Neumonía multifocal
**B)** Quiste hidatídico
**C)** Atelectasia
**D)** Derrame pleural
**E)** Cáncer pulmonar

Respuesta E. Cáncer de Pulmón: El cuadro clínico y la radiografía sugerían un cáncer de pulmón, pero ninguna de las opciones del Eunacom real tenían dicha respuesta. Así es el Eunacom y no se puede reclamar. Para efectos de subirlo a la plataforma, incluimos la opción.

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 90 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente fumador con baja de peso, hemoptisis ocasional y dolor costal. Radiografía con masa pulmonar. ¿Diagnóstico más probable?

**A)** Tuberculosis pulmonar cavitada
**B)** Cáncer pulmonar
**C)** Absceso pulmonar
**D)** Sarcoidosis pulmonar
**E)** Linfoma pulmonar primario

Respuesta B. Diagnóstico: Cáncer pulmonar (opción B). Cáncer pulmonar. Esta clase diferencia la fiebre sin foco (FSF) de la fiebre de origen desconocido (FOD). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 144 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 63 años, con antecedente de diabetes e hipertensión mal controladas, fumadora de 40 paquetes años y alcohólica activa, consulta por dolor torácico izquierdo, que aumenta con los movimientos respiratorios, asociado a tos con expectoración mucosa, que, en ocasiones es hemoptoica. Ha bajado de peso y refiere disnea de esfuerzos desde hace algunos meses. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 65x', PA: 150/98 mmHg, saturación de oxígeno por pulsometría: 95% a FiO2 ambiental, examen pulmonar con murmullo vesicular simétrico, con escasos crépitos a izquierda y, además, refiere dolor a la palpación de quinto arco costal izquierdo. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

**A)** Absceso pulmonar
**B)** Neumonía neumocócica
**C)** Tuberculosis pulmonar
**D)** Disección aórtica
**E)** Cáncer pulmonar

Respuesta E. Diagnóstico: Cáncer pulmonar (opción E). Esta clase diferencia la fiebre sin foco (FSF) de la fiebre de origen desconocido (FOD). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 60 años, hipertenso, fumador de 25 paquetes-año, consulta por tos de algunos meses de evolución. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza radiografía que se muestra a continuación. NOTA: la foto original no mostraba nada categórico. Era similar a la que se muestra, pero no tenía flecha.

**A)** Cáncer
**B)** Tuberculosis pulmonar
**C)** Fibrosis pulmonar
**D)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**E)** Cardiopatía hipertensiva

Respuesta A. La radiografía no mostraba mucho (en la Rx original no había flecha y se veía, usando la imaginación, un engrosamiento bronquial o mediastínico derecho). Casi se veía normal. Pero tos en alguien muy fumador, con examen físico normal, pensar en Cáncer (no tenía secreción como para pensar en bronquitis crónica por cigarrillo).

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 9 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 55 años, fumador de 20 paquetes años, consulta por tos de 3 meses de evolución, asociado a disnea y expectoración mucosa. Al examen físico se ausculta murmullo pulmonar conservado, sin ruidos agregados. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

**A)** Asma bronquial
**B)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**C)** Cáncer bronquial
**D)** Hidatidosis pulmonar
**E)** Enfermedad pulmonar intersticial

Respuesta C. Es un cáncer bronquial o pulmonar clásico, tanto por la clínica, como por la imagen. Revisar el resumen de semiología respiratoria.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 7 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 60 años, fumador de 40 paquetes años, consulta por disnea de 3 meses de evolución, asociado a tos con expectoración mucosa. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x' y a la auscultación pulmonar se constatan escasos crépitos y algunas sibilancias, que son mayores en el campo pulmonar izquierdo. Se realiza una radiografía, que se muestra a continuación: Fuente: radiopaedia.org ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

**A)** Biopsia pulmonar por fibrobroncoscopía
**B)** TAC de tórax
**C)** Fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar
**D)** Biopsias por videotoracoscopía
**E)** Resonancia magnética nuclear de tórax

Respuesta B. Tiene un tumor pulmonar izquierdo y la clínica sugiere cáncer. Luego de la RxTx se recomienda una TAC, antes de proceder a la biopsia (por broncoscopía, en este caso), ya que que permite ver la ubicación, características y estado de diseminación, además de ayudar a detectar otros diagnósticos diferenciales.

## 1.05.1.008 Corazón pulmonar crónico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

### QUÉ HAY QUE SABER

- Cor pulmonale crónico: hipertrofia y falla del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar con hipoxemia crónica, sobre todo EPOC.
- Clínica: disnea progresiva, edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia y reflujo hepatoyugular, con función izquierda conservada.
- Confirmación: ecocardiograma con cavidades derechas dilatadas/hipertróficas y PSAP elevada; ECG con signos de sobrecarga derecha; gases arteriales con hipoxemia; poliglobulia.
- Oxigenoterapia ≥15 h/día: única medida que mejora la sobrevida; indicada con PaO2 ≤55 mmHg, o 56-59 mmHg con cor pulmonale o hematocrito >55%.
- Manejo inicial: optimizar la enfermedad de base, diuréticos para el edema, cesación tabáquica; la digoxina no se indica salvo FA.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar para evaluar oxígeno domiciliario (GES) y estudio de hipertensión pulmonar.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 70 años con EPOC grave presenta edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular y hepatomegalia. El ecocardiograma muestra dilatación del ventrículo derecho y presión de arteria pulmonar estimada de 55 mmHg, con FEVI normal. Gases arteriales en reposo: PaO2 52 mmHg. **¿Cuál es la intervención que ha demostrado mejorar la sobrevida en esta condición?**

**A)** Digoxina
**B)** Oxigenoterapia crónica domiciliaria más de 15 horas al día
**C)** Betabloqueadores
**D)** Anticoagulación oral
**E)** Sildenafil en todos los casos

Respuesta B. El cor pulmonale por EPOC con hipoxemia crónica (PaO2 ≤55 mmHg, o 56-59 con cor pulmonale o poliglobulia) tiene indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria más de 15 horas al día, única intervención que mejora la sobrevida al revertir la vasoconstricción hipóxica. Los diuréticos alivian el edema; la digoxina no se indica salvo FA.

## 1.05.1.009 Daño pulmonar secundario a drogas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar daño pulmonar por fármacos ante disnea progresiva y tos seca con crépitos en usuario de amiodarona, metotrexato, bleomicina o nitrofurantoína crónica.
- Patrón de enfermedad intersticial: crépitos tipo velcro, infiltrados bilaterales en radiografía y vidrio esmerilado o fibrosis en TACAR; disminución de la DLCO.
- Diferenciar de insuficiencia cardíaca (no hay congestión ni edema) y de infección; descartar otras causas de EPID.
- Manejo inicial: suspender el fármaco sospechoso (lo más importante); los corticoides los indica el especialista en casos moderados-severos.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar con TACAR y pruebas funcionales; vigilar función pulmonar en usuarios crónicos de amiodarona.

### PREGUNTAS (3)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 106**

Una paciente de 68 años, con antecedente de hipertensión y cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con losartán y clortalidona, que, además, tiene fibrilación auricular crónica, en tratamiento con amiodarona y rivaroxabán, consulta por un cuadro de disnea progresiva que se ha instalado en los últimos meses, que actualmente es de medianos esfuerzos y se asocia a tos seca, mayor en la noche. Al examen físico tiene pulso regular a 74x', PA: 130/80 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales, examen cardiaco: RR2T sin soplos, con abdomen y extremidades sin alteraciones. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Iniciar salbutamol
**B)** Agregar espironolactona
**C)** Suspender el rivaroxabán
**D)** Suspender la amiodarona
**E)** Agregar furosemida

Respuesta D. Disnea progresiva de meses, tos seca y crepitaciones bilaterales en usuaria de amiodarona, sin signos de congestión: toxicidad pulmonar intersticial por amiodarona. La conducta es suspender el fármaco.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 98 · texto original del banco, sin revisar**

Mujer de 56 años cardiópata y con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con espironolactona, isosorbide, hidralazina, amiodarona y anticoagulante oral. Inicia hace 6 meses un cuadro de disnea y tos seca. A la exploración pulmonar tiene crépitos bibasales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

**A)** Suspender amiodarona
**B)** Solicitar TAC de tórax
**C)** Aumentar diurético
**D)** Solicitar ecocardiograma
**E)** Solicitar fibrobroncoscopia

Respuesta A. Si bien es imposible ver bien la radiografía, la historia sugería mucho una fibrosis pulmonar por amiodarona, por lo que se debe suspender.

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 93 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente usuario de amiodarona con disnea progresiva y tos; radiografía con infiltrados bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

**A)** Suspender amiodarona
**B)** Iniciar corticoides sistémicos
**C)** Agregar antibiótico de amplio espectro
**D)** Solicitar broncoscopía diagnóstica
**E)** Aumentar dosis de amiodarona y agregar corticoide

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender amiodarona (opción A). Suspender amiodarona. Tratamiento: penicilina endovenosa; en forma respiratoria ciprofloxacino + clindamicina. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

## 1.05.1.010 Derrame pleural neoplásico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

### QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame neoplásico: exudado linfocítico con ADA bajo (<40 U/L), a menudo serohemático, en paciente mayor de 50-60 años con baja de peso. Causas: adenocarcinoma pulmonar, mama, linfoma y mesotelioma (asbesto).
- Confirmación: citología del líquido (60% en la 1.ª muestra, 80-85% con la 2.ª). Si es negativa con sospecha alta, biopsia pleural por videotoracoscopía, no repetir citologías indefinidamente.
- Clasificar primero con criterios de Light (proteínas pleura/suero >0,5, LDH pleura/suero >0,6 o LDH >2/3 del límite superior sérico); colesterol pleural alto también orienta a exudado.
- Manejo inicial: toracocentesis evacuadora para aliviar la disnea; es enfermedad avanzada (M1a), el objetivo es paliativo.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología para pleurodesis con talco o catéter pleural tunelizado y tratamiento del tumor primario.

### PREGUNTAS (5)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 87**

Un paciente de 56 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disnea progresiva de 2 meses de evolución, asociada a tos irritativa y compromiso del estado general. Sus signos vitales son FC: 88x', PA: 130/80 mmHg, saturación 93% a FiO2 ambiental y al examen pulmonar presenta matidez y crépitos en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, a derecha, el que se confirma con la TAC de tórax. Se realiza toracocentesis, que da salida a un líquido pleural opalescente, con LDH: 700 UI/L, mayor a 0,6 en relación a la LDH plasmática y proteínas mayores a 0,5, en relación a las proteínas plasmáticas, con 40 células por mm3, 90% de mononucleares, ADA: 24 UI/L y citología negativa. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

**A)** Biopsia pulmonar por videotoracoscopía
**B)** Broncoscopía con biopsia pulmonar
**C)** PET-TC
**D)** Biopsia pleural por videotoracoscopía
**E)** Broncoscopía con lavado bronquioalveolar

Respuesta D. Exudado (cumple los criterios de Light), mononuclear, con ADA baja y citología negativa: sugerente de cáncer. Sin tumor pulmonar visible, se biopsia la pleura, idealmente por videotoracoscopía.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 116**

Un paciente de 68 años presenta tos de 4 meses de evolución, y disnea de esfuerzos. Al examen pulmonar tiene disminución del murmullo pulmonar a derecha, más matidez en la base derecha. Punción pleural con líquido claro, pH: 7,47, células: 70 por mm3, 80% mononucleares, ADA: 20 UI/L, LDH: 167 UI/L, colesterol: 119 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Insuficiencia cardíaca
**B)** Tuberculosis pleural
**C)** Empiema
**D)** Cáncer bronquial
**E)** Derrame secundario a artritis reumatoide

Respuesta D. Aunque la LDH es baja, el colesterol mayor de 40 mg/dL lo clasifica como exudado. Exudado mononuclear con ADA bajo en un adulto mayor: cáncer. La insuficiencia cardíaca da un transudado; la tuberculosis y la artritis reumatoide dan exudados mononucleares con ADA alto; el empiema es un exudado polimorfonuclear.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 20**

Un paciente de 60 años, fumador de 5 cigarrillos al día, consulta por disnea de esfuerzos que ha aumentado en el último tiempo. Ha bajado de peso cerca de 6 kilogramos en los últimos 3 meses. Como antecedente, trabajó durante 30 años en una fábrica de producción de pizarras de asbesto para la construcción. Al examen físico presenta signos vitales normales, edema de extremidades inferiores, yugulares visibles al decúbito y examen pulmonar con MP presente, disminuido a derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra derrame pleural marcado en el lado derecho, por lo que se realiza punción pleural, que da salida a líquido con 300 células por mm3, con 90% de mononucleares, ADA: 22 UI/L, proteínas: 6 g/dL, estudio citológico negativo, pH: 7,37, lactato: 3 mmol/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Carcinoma pavimentoso
**B)** Adenocarcinoma
**C)** Tuberculosis pleural
**D)** Mesotelioma
**E)** Silicosis

Respuesta D. Exudado mononuclear con ADA bajo: derrame neoplásico. El antecedente de 30 años de exposición a asbesto se relaciona fuertemente con mesotelioma. La citología negativa no lo descarta.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 120 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 65 años de edad, fumador de 40 paquetes/año, consulta por disnea progresiva asociada a tos con expectoración escasa mucosa. Al examen físico se aprecia disminución de murmullo pulmonar en base pulmonar izquierda Se solicita radiografía de tórax que muestra derrame pleural en lado izquierdo, el cual se punciona mostrando LDH 250 mg/dL, 300 leucocitos (95% mononucleares) y ADA en 25. El diagnóstico más probable es:

**A)** Insuficiencia Cardiaca
**B)** Derrame pleural maligno
**C)** Tuberculosis
**D)** Tromboembolismo pulmonar
**E)** Enfermedad del tejido conectivo

Respuesta B. Diagnóstico: Derrame pleural maligno (opción B). Exudado mononuclear con ADA baja. Es cáncer. Esta clase aborda la diferenciación entre amigdalitis bacteriana y viral, junto con la difteria y las anginas infecciosas. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 45 años consulta por disnea de 2 meses de evolución que ha ido en aumento y se ha asociado a dolor torácico en el hemitórax izquierdo, además de tos seca. Como antecedente, refiere haber vivido gran parte de su infancia junto a una fábrica de fibrocemento. En su examen Fsico presenta frecuencia cardíaca 82 la8dos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg, frecuencia respiratoria 22 por minuto; el examen pulmonar muestra abolición del murmullo pulmonar del hemitórax izquierdo y ma8dez a la percusión en esa zona. Se solicita una radiograFa de tórax, que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

**A)** Derrame pleural tuberculoso
**B)** Tromboembolismo pulmonar crónico
**C)** Carcinoma broncogénico
**D)** Silicosis pulmonar
**E)** Mesotelioma maligno

Respuesta E. La radiografía muestra un derrame pleural extenso a izquierda. El antecedente de exposición a asbesto (fibrocemento) orienta al mesotelioma como causa del derrame. Fuente imagen: Radiopaedia.

## 1.05.1.011 Derrame pleural paraneumónico complicado

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

### QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame paraneumónico complicado: neumonía con derrame que no resolverá solo con antibiótico (fase fibrinopurulenta). Empiema: pus macroscópico o Gram/cultivo positivo.
- Todo derrame >10 mm en decúbito lateral se punciona. Complicado si pH <7,20 (mejor predictor), glucosa <40-60 mg/dL, LDH >1.000 U/L, tabiques o >½ hemitórax.
- Sospechar ante neumonía que sigue febril a las 72 h de antibiótico adecuado: repetir radiografía/ecografía.
- Conducta inicial: tubo pleural 24-28 Fr a trampa de agua de inmediato, sin esperar respuesta al antibiótico, más antibiótico EV con cobertura anaerobia.
- Esquemas: ampicilina/sulbactam 1,5-3 g c/6 h EV o ceftriaxona 2 g/día + metronidazol 500 mg c/8 h, por 2 a 4 semanas.
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax; si está tabicado, fibrinolíticos intrapleurales o VATS; decorticación solo si hay coraza pleural.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 58 años, tabáquico y con mala dentadura, hospitalizado por neumonía basal derecha en tratamiento con ceftriaxona 2 g/día EV. Al 4.º día persiste febril (38,6 °C), con más dolor pleurítico y disnea. Rx: derrame derecho que ocupa el tercio inferior del hemitórax. Toracocentesis: líquido turbio y espeso, pH 7,12, glucosa 28 mg/dL, LDH 2.450 U/L, Gram con diplococos grampositivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Mantener ceftriaxona y repetir la toracocentesis en 48 horas
**B)** Tubo de drenaje pleural a trampa de agua y agregar cobertura anaerobia
**C)** Toracotomía con decorticación de urgencia
**D)** Cambiar a ciprofloxacino oral y control ambulatorio
**E)** Fibrinolíticos intrapleurales como primera medida, sin tubo

Respuesta B. pH < 7,20, glucosa < 40 mg/dL, LDH > 1.000 U/L y Gram positivo: derrame complicado que ya es empiema. Indicación inmediata de pleurostomía con tubo a trampa de agua, ajustando el antibiótico con cobertura anaerobia (agregar metronidazol o cambiar a ampicilina/sulbactam).

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 156 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y fiebre de hasta 38,7°C. El examen físico muestra disminución del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax muestra signos de condensación en el lado derecho y derrame pleural de tamaño moderado Se inicia tratamiento con ceftriaxona 2g al día y se realiza toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural con 2.000 células/mm3, 85% de polimorfonucleares, colesterol: 70 mg/dL, LDH: 220 U/L, pH: 7.26 y lactato de 6.1 mmol/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

**A)** Realizar drenaje completo del derrame pleural
**B)** Agregar metronidazol al tratamiento
**C)** Solicitar TAC de tórax
**D)** Solicitar baciloscopías de expectoración
**E)** Realizar broncoscopia y biopsia

Respuesta A. Neumonía con Derrame Paraneumónico: El manejo de una neumonía con derrame paraneumónico complicado (por el lactato pleural > 5 mmol/L) incluye drenaje completo del derrame pleural (medida más importante), tubo pleural y metronidazol para cubrir bacterias anaerobias.

## 1.05.1.012 Derrame pleural paraneumónico simple

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

### QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame paraneumónico simple: derrame estéril en fase exudativa, presente hasta en 40% de las neumonías hospitalizadas.
- Confirmación: toracocentesis si mide >10 mm en decúbito lateral; líquido claro, pH >7,20, glucosa >60 mg/dL, LDH <1.000 U/L, Gram y cultivo negativos.

- Tratamiento: solo el antibiótico de la neumonía (ej. ceftriaxona EV si está hospitalizado), sin tubo pleural.
- Vigilancia clínica y ecográfica: si persiste la fiebre a las 72 h o crece el derrame, repuncionar para descartar evolución a complicado.
- Seguimiento completo: control clínico y radiológico hasta la resolución del derrame y de la neumonía (radiografía a las 6-8 semanas en mayores o fumadores).

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 138**

Un paciente de 50 años presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está se auscultan crepitaciones basales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra más abajo: NOTA: la radiografía mostraba infiltrados en la base izquierda, que ocupaban el lóbulo inferior izquierdo, pero que permitían ver la cúpula diafragmática, con un pequeño derrame pleural, limitado al ángulo costofrénico. Se punciona el derrame pleural, que muestra un lactato: 2,4 mmol/L, pH: 7,34, con 350 células, 90% de polimorfonucleares. **¿Qué antibiótico debe dejar?**

**A)** Claritromicina
**B)** Clindamicina
**C)** Ceftriaxona
**D)** Azitromicina
**E)** Amoxicilina

Respuesta C. Neumonía con derrame paraneumónico simple (pH > 7,20, derrame pequeño): no requiere tubo. Se maneja hospitalizado, con antibiótico endovenoso: ceftriaxona.

## 1.05.1.013 Derrame pleural por tuberculosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR · Tema 3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Pleuritis tuberculosa: reacción de hipersensibilidad a un foco caseoso subpleural; típica en joven con fiebre, dolor pleurítico, tos seca y baja de peso.
- Líquido: exudado unilateral con >50% de linfocitos (a menudo >80%), escasas células mesoteliales y ADA ≥40 U/L (sensibilidad y especificidad >90%).
- La baciloscopía del líquido es positiva en <5-10% (paucibacilar): no descarta. Biopsia pleural con aguja muestra granulomas caseificantes en >80% si hay duda o ADA limítrofe.
- Exudado linfocítico con ADA alto en un joven basta para iniciar tratamiento: esquema 2 RHZE / 4 RH, directamente observado, 6 meses.
- Notificar y estudiar contactos según el Programa de Control de TBC; buscar TBC pulmonar asociada (baciloscopía y cultivo de expectoración).
- Seguimiento completo: controles mensuales con adherencia, reacciones adversas (hepatotoxicidad, neuritis óptica por etambutol) y evolución radiológica.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 28 años con 4 semanas de fiebre vespertina, tos seca, dolor pleurítico derecho y baja de 4 kg. Radiografía: derrame pleural derecho moderado. Toracocentesis: exudado con 85 % de linfocitos, glucosa 70 mg/dL, ADA 78 U/L y escasas células mesoteliales. Baciloscopía del líquido negativa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Antibióticos para neumonía y control en 2 semanas
**B)** Esperar el cultivo de Koch del líquido, de 6 a 8 semanas
**C)** Pleurodesis con talco
**D)** Iniciar tratamiento antituberculoso
**E)** Toracoscopía con biopsia pleural antes de tratar

Respuesta D. Exudado linfocitario con ADA alto (sobre 60 U/L) en un adulto joven es diagnóstico de pleuresía tuberculosa y basta para iniciar tratamiento. La baciloscopía y el cultivo del líquido suelen ser negativos porque es una forma paucibacilar. La biopsia pleural se reserva para ADA dudoso o sospecha de cáncer.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 34 años con 3 semanas de fiebre vespertina, dolor pleurítico derecho y baja de 2 kg. Radiografía: derrame pleural derecho. Toracocentesis: exudado con 85 % de linfocitos, glucosa 72 mg/dL, ADA 58 U/L. Baciloscopía del líquido negativa. **¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar el diagnóstico?**

**A)** Repetir la baciloscopía del líquido en 3 muestras
**B)** Biopsia pleural percutánea con aguja
**C)** Citología del líquido pleural seriada
**D)** Pleurodesis con talco
**E)** Broncoscopía con lavado broncoalveolar

Respuesta B. Exudado linfocítico con ADA 58 U/L (≥ 40) en un joven febril: pleuritis tuberculosa. La baciloscopía del líquido es positiva en menos del 10 % porque el derrame es paucibacilar; repetirla no ayuda. La confirmación es la biopsia pleural con aguja (granulomas caseificantes y cultivo).

## 1.05.1.014 Edema pulmonar no cardiogénico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

### QUÉ HAY QUE SABER

- Edema pulmonar no cardiogénico (SDRA): edema por aumento de permeabilidad alvéolo-capilar, con shunt e hipoxemia refractaria al oxígeno.
- Causas directas (neumonía, aspiración, contusión, humo) e indirectas (sepsis —la más común—, politrauma, pancreatitis, quemados, transfusiones).
- Criterios de Berlín: inicio ≤7 días tras el insulto, opacidades bilaterales, no explicado por falla cardíaca ni sobrecarga (ecocardiograma) y PaFi ≤300 con PEEP ≥5.
- Gravedad por PaFi: leve 200-300, moderado 100-200, severo ≤100. Diferenciar del edema cardiogénico: cardiomegalia, redistribución y líneas de Kerley.
- Conducta inicial: oxígeno, tratar la causa y trasladar a UCI. Allí: ventilación protectora (Vt 6 mL/kg de peso ideal, plateau ≤30 cmH2O), prono ≥16 h/día si PaFi <150, balance hídrico neutro.
- Seguimiento: manejo por intensivista; derivar siempre.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Mujer de 38 años, al cuarto día de hospitalización por pancreatitis aguda necrotizante, presenta disnea intensa, FR 34 rpm y cianosis. Rx de tórax: infiltrados alveolares bilaterales difusos. Intubada, con FiO2 80% y PEEP 10 cmH2O, tiene PaO2 72 mmHg. El ecocardiograma muestra función biventricular normal. **¿Cuál es el diagnóstico y la estrategia ventilatoria más adecuada?**

**A)** SDRA moderado; Vt 10 mL/kg de peso real para mejorar la oxigenación
**B)** Edema pulmonar cardiogénico; furosemida y nitroglicerina
**C)** SDRA severo; Vt 6 mL/kg de peso ideal, plateau ≤ 30 cmH2O y prono precoz
**D)** SDRA leve; ventilación no invasiva y alta a sala
**E)** Neumonía aspirativa; antibióticos y supino estricto

Respuesta C. Insulto conocido (pancreatitis) hace < 7 días, opacidades bilaterales, eco normal y PaFi = 72/0,8 = 90 con PEEP ≥ 5: SDRA severo. Ventilación protectora (6 mL/kg de peso ideal, plateau ≤ 30) y, con PaFi < 150, prono ≥ 16 h/día.

**Pregunta de práctica**

Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de ventilación mecánica invasiva presenta empeoramiento del intercambio gaseoso. La radiografía de tórax revela opacidades alveolo-intersticiales difusas bilaterales que no estaban presentes al ingreso. Con ventilador en modalidad asistida, FiO2 70% y PEEP 8 cmH2O, sus gases arteriales reportan una PaO2 de 63 mmHg (PaFiO2 = 90). El ecocardiograma descarta insuficiencia cardíaca. **¿Cuál es el diagnóstico según los criterios de Berlín y cuál es la estrategia ventilatoria que ha demostrado reducir la mortalidad?**

**A)** SDRA leve; ventilar con volúmenes corrientes de 10 a 12 mL/kg peso real
**B)** SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbito prono precoz
**C)** Edema pulmonar cardiogénico; suspender sedación e indicar digoxina
**D)** Atelectasia masiva izquierda; realizar broncoscopía rígida desobstructiva
**E)** SDRA moderado; mantener al paciente en posición supina estricta y volumen corriente de 8 mL/kg

Respuesta B. Sepsis abdominal, < 7 días, opacidades bilaterales y eco sin falla cardíaca: SDRA. PaFi 90 con PEEP ≥ 5 lo clasifica como severo. Ventilación protectora (6 mL/kg de peso predicho) y prono precoz ≥ 16 h/día (PROSEVA) reducen la mortalidad.

## 1.05.1.015 Embolia pulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante disnea súbita inexplicable (>80%), dolor pleurítico, taquicardia, hemoptisis o síncope, con factores de Virchow: inmovilización, cirugía de cadera/rodilla, cáncer, estrógenos, TVP previa.
- ECG: lo más frecuente es taquicardia sinusal; S1Q3T3 y bloqueo de rama derecha son específicos pero poco frecuentes. Radiografía a menudo normal.
- Paciente estable: Wells ≤4 → dímero D (negativo descarta); Wells >4 → angioTAC directo (dímero D no sirve). Inestable: ecocardiograma en la cama.
- Estratificar con sPESI: 0 = bajo riesgo; ≥1 = ecocardiograma del VD y troponinas.
- Tratamiento inicial: anticoagular apenas se sospecha si no hay contraindicación: rivaroxabán 15 mg c/12 h ×21 días y luego 20 mg/día, o enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC (de elección en cáncer o embarazo).
- Seguimiento: derivar; anticoagulación mínimo 3 meses si es provocado. Filtro de vena cava solo si no se puede anticoagular.

### PREGUNTAS (10)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 121**

Un paciente de 56 años, diabético, hospitalizado en su quinto día, por un síndrome nefrótico, presenta un cuadro de disnea y dolor torácico, por lo que se realiza una radiografía de tórax, la que muestra un derrame pleural derecho. Se realiza la punción pleural, dado salida a un líquido pleural de aspecto hemorrágico, con LDH: 650 UI/L, células 80% de polimorfonucleares, 20% de mononucleares, ADA: 30 UI/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Derrame paraneumónico
**B)** Trasudado por hipoalbuminemia
**C)** Empiema
**D)** Tromboembolismo pulmonar
**E)** Derrame pleural canceroso

Respuesta D. Nefrótico hospitalizado con disnea y dolor torácico: TEP. El derrame del TEP suele ser un exudado hemorrágico. Un trasudado por hipoalbuminemia no sería hemorrágico ni tendría LDH de 650.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 5**

Un paciente de 68 años presenta una fractura de cadera, de la que es operado. Al segundo día, presenta un síncope, que se recupera al a los pocos segundos. Su presión arterial es de 100/60 mmHg y su frecuencia cardíaca es 110. Además satura 91% a FiO2 ambiental. Su examen físico muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados y un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?**

**A)** Ecocardiograma
**B)** Radiografía de tórax
**C)** AngioTAC de tórax
**D)** TILT test
**E)** Monitorización electrocardiográfica de 24 horas

Respuesta C. Postoperatorio de fractura de cadera con síncope, taquicardia e hipoxemia y examen pulmonar normal: sospecha de TEP. Con PA sistólica ≥ 90 mmHg puede ir al angioTAC de tórax. Por este riesgo la tromboprofilaxis con HBPM es obligatoria y se extiende 28–35 días.

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 148**

Un paciente de 72 años es hospitalizado por fractura de cadera, manejada con cirugía de prótesis parcial. Al quinto día presenta pérdida de conciencia, luego de ponerse de pie, con recuperación completa algunos minutos después. Luego de ello presenta lipotimias y episodios similares al incorporarse desde la cama. Al examen físico está con FC: 120x', presión arterial: 100/50 mmHg, extremidades inferiores frías y con cianosis distal y ritmo cardíaco regular, sin soplos y murmullo pulmonar presente. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

**A)** TAC de cerebro
**B)** Ecocardiograma
**C)** RMN de cerebro
**D)** Electrocardiograma
**E)** AngioTAC de tórax

Respuesta E. Postoperado de cadera con síncope y taquicardia: TEP. Con presión sistólica sobre 90 mmHg puede ir a la sala de imágenes, y el examen que confirma es el angioTAC. El ecocardiograma en la cama se reserva para el paciente demasiado inestable para trasladarlo.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 134**

Una paciente consulta al servicio de urgencias por disnea y malestar de 2 horas de evolución. Refiere un viaje reciente en avión desde Europa hace 12 horas y es usuaria de anticonceptivos orales. Al examen físico, tiene presión arterial: 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca: 100x' y saturación arterial de oxígeno: 90%, su auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que el resto de su examen físico. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto. **¿Cuál es el examen de elección para continuar con el estudio?**

**A)** Dímero D
**B)** Ecocardiograma
**C)** AngioTAC de tórax
**D)** Péptido natriurético cerebral
**E)** Electrocardiograma Holter de 24 horas

Respuesta C. Vuelo largo y anticonceptivos, disnea súbita, desaturación y taquicardia sinusal: TEP como diagnóstico más probable (3) + FC > 100 (1,5) = 4,5 puntos de Wells. Probabilidad alta en una paciente estable: angioTAC, no dímero D.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 167**

Un paciente de 75 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional II, presenta disnea más intensa de la habitual, desde hace 5 días, por lo que ha guardado reposo en cama recibiendo antibióticos y oxigenoterapia. El día de hoy presenta exacerbación súbita de su sintomatología con pérdida de conciencia, que se recupera algunos segundos después, y disnea de reposo. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca 125 latidos por minuto, presión arterial 160/100 mmHg, frecuencia respiratoria 30 por minuto y saturación de oxígeno 87%. El examen pulmonar muestra escasas sibilancias bilaterales y crépitos bibasales. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal sin alteraciones del segmento ST y la radiografía de tórax muestra campos pulmonares grandes, sin opacidades. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Infarto agudo de miocardio
**B)** Disección aórtica
**C)** Taponamiento cardíaco
**D)** Neumonía
**E)** Tromboembolismo pulmonar

Respuesta E. Reposo en cama (estasis) y empeoramiento súbito con síncope: TEP. La taquicardia sinusal es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente y la radiografía suele no mostrar alteraciones nuevas.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 54 años, operada de artroplastia total de cadera derecha hace 10 días, presenta súbitamente disnea intensa, dolor punzante en hemitórax derecho y taquicardia. FR 26/min, FC 112 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 91 % ambiental. Pantorrilla derecha aumentada de volumen y dolorosa. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

**A)** Dímero D ultrasensible y AngioTAC solo si es positivo
**B)** AngioTAC de arterias pulmonares
**C)** Trombólisis con alteplasa sin estudio previo
**D)** Electrocardiograma para buscar S1Q3T3
**E)** Radiografía de tórax y control en 24 horas

Respuesta B. Wells: signos de TVP (3) + TEP como diagnóstico más probable (3) + FC > 100 (1,5) + cirugía reciente (1,5) = 9 puntos, probabilidad alta. Paciente estable: AngioTAC directo, sin dímero D, e iniciar anticoagulación si no hay contraindicación. La trombólisis es solo para el TEP con shock.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 63 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 40 años, hospitalizado hace 3 días por un síndrome nefrótico, presenta disnea, de inicio súbito. Presenta desaturación arterial hasta 90%, con disminución del murmullo pulmonar a derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido hemorrágico, con LDH: 700, predominio de polimorfonucleares, pH: 7,3 y lactato de 4,0 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

**A)** Empiema
**B)** Derrame paraneumónico simple
**C)** Tromboembolismo pulmonar
**D)** Transudado pleural
**E)** Compromiso pleural maligno

Respuesta C. El exudado hemorrágico orienta a TEP. También el Sd. nefrótico, que se complica con TEP. También el inicio súbito.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 21 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 55 años, está hospitalizado por una pancreatitis aguda, de diez días de evolución. Presenta un cuadro de fiebre, malestar general y taquipnea de 1 día de evolución. ¿Qué conducta es más adecuada?

**A)** Solicitar radiografía de tórax
**B)** Solicitar TAC de abdomen y pelvis
**C)** Solicitar ecografía abdominal
**D)** Solicitar angioTAC de tórax
**E)** Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar angioTAC de tórax (opción D). La sospecha es un TEP.. Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 140 · texto original del banco, sin revisar**

Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos y satura 90% a FiO2 ambiental. El diagnóstico más probable es:

**A)** Tromboembolismo pulmonar
**B)** Neumonía adquirida en la comunidad
**C)** Neumonía intrahospitalaria
**D)** Tuberculosis pulmonar
**E)** VIH

Respuesta A. Diagnóstico: Tromboembolismo pulmonar (opción A). el antecedente de puerperio orienta muy fuertemente a TEP. La clínica es compatible.. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 97 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 68 años, con antecedente de cáncer de próstata, en tratamiento con hormonoterapia, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de dolor torácico, en el lado izquierdo, tipo puntada de costado, asociado a disnea, tos y fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

**A)** Metástasis pulmonares
**B)** Neumotórax
**C)** Infarto agudo al miocardio
**D)** Tromboembolismo pulmonar
**E)** Distrés respiratorio

Respuesta D. Diagnóstico: Tromboembolismo pulmonar (opción D). Es un TEP clásico.. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

## 1.05.1.016 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

### QUÉ HAY QUE SABER

- EPOC avanzada: VEF1 post-BD <50% (GOLD 3: 30-49%; GOLD 4: <30%), con disnea mMRC ≥2 y a menudo exacerbador (grupo E: ≥2 exacerbaciones moderadas o ≥1 hospitalización al año).
- Confirmación con espirometría (VEF1/CVF post-BD <0,70); evaluar gases arteriales, saturación, hematocrito y ecocardiograma (cor pulmonale).
- Tratamiento inicial: LAMA + LABA; triple terapia (+ CI) solo si es exacerbador con eosinófilos ≥300/μL (o ≥100 con exacerbaciones). Nunca CI en monoterapia.
- Lo que alarga la vida: dejar de fumar y oxígeno ≥15 h/día si PaO2 ≤55 mmHg (o SatO2 ≤88%), o 56-59 con cor pulmonale o hematocrito >55%.
- Rehabilitación pulmonar, vacunas influenza y neumococo, plan de manejo de exacerbaciones.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar (oxígeno domiciliario GES, VMNI domiciliaria, reducción de volumen o trasplante en casos seleccionados).

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 66 años, fumador de 35 paquetes-año, con EPOC GOLD 3. Refiere disnea al caminar en plano al ritmo de personas de su edad (mMRC 2). Sin exacerbaciones en el último año. Eosinófilos 90/μL. Gases basales: PaO2 64 mmHg, PaCO2 42 mmHg. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** LAMA + LABA (por ejemplo, tiotropio/olodaterol)
**B)** LAMA + LABA + corticoide inhalado
**C)** Fluticasona inhalada en monoterapia
**D)** LAMA + LABA y oxígeno domiciliario 15 horas al día
**E)** Salbutamol a demanda como única terapia

Respuesta A. Disnea mMRC ≥ 2 sin exacerbaciones: grupo B, que se trata con doble broncodilatación LAMA + LABA. No tiene indicación de CI (eosinófilos < 300, no exacerbador) ni de oxígeno domiciliario (PaO2 > 59 mmHg).

## 1.05.1.017 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: fumador >10-20 paquetes-año o expuesto a biomasa con tos, expectoración y disnea de esfuerzo progresiva. Confirmación solo con espirometría: VEF1/CVF post-BD <0,70.
- Fumador con espirometría normal no tiene EPOC. GOLD 1: VEF1 ≥80%; GOLD 2: 50-79%. El tratamiento lo decide el grupo clínico, no el GOLD.
- Grupo A (mMRC 0-1/CAT <10, sin exacerbaciones graves): un broncodilatador de acción larga (LAMA o LABA). Grupo B (mMRC ≥2/CAT ≥10): LAMA + LABA. Grupo E: LAMA + LABA, triple si eosinófilos ≥300.
- Corticoide inhalado en monoterapia contraindicado (más neumonías). SABA solo como rescate.
- Dejar de fumar es la única medida que normaliza la caída del VEF1: consejería + vareniclina o TRN. Vacuna influenza anual y antineumocócica; actividad física y rehabilitación.
- Seguimiento completo en APS (programa ERA): control de síntomas, técnica inhalatoria, exacerbaciones y espirometría anual.

### PREGUNTAS (3)

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 175**

Espirometría con VEF1/CVF 0.35, no mejora post broncodilatador, VEF1 50% **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Fibrosis pulmonar
**B)** Insuficiencia cardiaca derecha
**C)** EPOC
**D)** Asma
**E)** Bronquiectasias

Respuesta C. Relación VEF1/CVF muy baja que no mejora con broncodilatador: obstrucción fija, es decir, EPOC. Con VEF1 de 50%, la limitación es moderada (50–79%).

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 14**

Un paciente de 65 años, fumador de 40 paquetes año, consulta por disnea de algunos meses de evolución, progresiva, que actualmente le dificulta caminar más de 3 cuadras. Su examen físico demuestra espiración prolongada y algunas sibilancias en ambos campos pulmonares. Actualmente ya no fuma. Se solicita espirometría que muestra lo siguiente: Basal: CVF 2,68 L (90%); VEF1 1,35 L (50%); VEF1/CVF 55. Post SBT: CVF 2,96 L (102%); VEF1 1,38 L (51%); VEF1/CVF 57. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

**A)** Salbutamol inhalado
**B)** Budesonida inhalada
**C)** Ipatropio inhalado
**D)** Fluticasona inhalada
**E)** Tiotropio inhalado

Respuesta E. Obstrucción que no revierte con broncodilatador en un exfumador: EPOC. La base del tratamiento es dejar de fumar y los broncodilatadores de larga acción; de las opciones, el tiotropio (LAMA). Los corticoides inhalados solos están contraindicados.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 55 años, fumados de 30 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva. Su examen físico no muestra alteraciones. Se solicita una radiografía de tórax, que no muestra alteraciones y se realiza una espirometría, que muestra un VEF1 de 60%, que no mejora con broncodilatodor. El diagnóstico más proable es:

**A)** Bronquitis crónica
**B)** Hipertensión pulmonar
**C)** EPOC
**D)** Asma
**E)** Fibrosis pulmonar

Respuesta C. Si bien el Dg. de EPOC se hace con la relación VEF1/CVF (menor a 70%), el VEF1 bajo orienta mucho. Que no mejore con broncodilatador descarta asma y orienta a EPOC. La pregunta en sí está mala, pero probablemente será EPOC la respuesta correcta.

## 1.05.1.018 Enfermedades del intersticio pulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática · Tema 9.12 Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

## QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar EPID ante disnea de esfuerzo progresiva de meses-años, tos seca, crépitos secos tipo velcro bibasales y acropaquia.
- Examen de elección: TACAR sin contraste. Patrón NIU (panal de abejas subpleural basal, bronquiectasias por tracción) = fibrosis pulmonar idiopática, sin biopsia si es típico en >60 años.
- Patrón NINE (vidrio esmerilado, respeta zona subpleural): buscar conectivopatía (esclerodermia, AR, lupus, miopatías) o fármacos (amiodarona, metotrexato, nitrofurantoína, bleomicina).
- Antes de llamarla idiopática, buscar la causa: exposición laboral (sílice, asbesto), neumonitis por hipersensibilidad, fármacos (suspenderlos).
- FPI: corticoides (con o sin azatioprina) contraindicados, aumentan la mortalidad; se usan antifibróticos (pirfenidona, nintedanib). NINE sí responde a inmunosupresión.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar con TACAR, espirometría y DLCO.

## PREGUNTAS (5)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 38**

Una paciente de 58 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por un cuadro de 2 años de evolución de disnea progresiva, que ha aumentado en el último tiempo, volviéndose de pequeños esfuerzos. Además, refiere expectoración mucosa, que suele ser mayor en las mañanas. Evita realizar actividad física, transportar carga y subir escaleras, debido a la disnea. Como antecedente, fumó 4 cigarrillos al día, hasta hace un año. En el examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 86 lpm, presión arterial: 120/70 mmHg, frecuencia respiratoria basal: 15 rpm, saturación arterial de oxígeno: 93% a FiO2 ambiental. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular en dos tiempos, sin presencia de soplos y la auscultación pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, disminuido de manera global, con presencia de crepitaciones bilaterales. Además, tiene hipocratismo digital. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Asma alérgica
**B)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**C)** Bronquitis crónica por cigarrillo
**D)** Fibrosis pulmonar idiopática
**E)** Insuficiencia cardíaca congestiva

Respuesta D. Disnea progresiva de años, crepitaciones bilaterales e hipocratismo digital en una paciente con tabaquismo mínimo: fibrosis pulmonar idiopática. El EPOC y la bronquitis crónica no explican la acropaquia ni las crepitaciones, y el consumo de tabaco es muy bajo.

**Pregunta real · EUNACOM 2022 · Pregunta 39**

¿Cuál es la principal causa de muerte global en los pacientes con Esclerosis Sistémica Cutánea Difusa en la actualidad?

**A)** Crisis renal esclerodérmica hiperreninémica
**B)** Enfermedad pulmonar intersticial difusa (Fibrosis Pulmonar)
**C)** Rotura de aneurisma aórtico torácico
**D)** Hemorragia digestiva alta por esofagitis péptica
**E)** Amiloidosis renal secundaria

Respuesta B. Históricamente la crisis renal era la primera causa de muerte, pero tras la introducción de los IECA, la principal causa de muerte en la Esclerosis Sistémica Cutánea Difusa es la afectación pulmonar, específicamente la Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID / fibrosis pulmonar), seguida de la Hipertensión Arterial Pulmonar.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 68 años con disnea de esfuerzo lentamente progresiva desde hace 1 año y tos seca. SatO2 91 % ambiental, acropaquia y crépitos secos teleinspiratorios bibasales tipo velcro. La TACAR muestra reticulación subpleural y múltiples quistes en panal de abejas bibasales, sin vidrio esmerilado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Biopsia pulmonar quirúrgica para confirmar el diagnóstico
**B)** Prednisona 1 mg/kg/día
**C)** Prednisona más azatioprina
**D)** Iniciar antifibrótico (pirfenidona o nintedanib)
**E)** Broncodilatadores de acción prolongada

Respuesta D. Clínica típica y patrón NIU definitivo en mayor de 60 años: fibrosis pulmonar idiopática sin necesidad de biopsia. Los corticoides (solos o con azatioprina) están contraindicados porque aumentan la mortalidad; se indican antifibróticos.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 64 · texto original del banco, sin revisar**

Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca acropaquia y al examen pulmonar murmullo pulmonar disminuido bilateral con presencia de crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen en panal de abejas. El diagnóstico más probrable es:

**A)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**B)** Tuberculosis
**C)** Enfermedad pulmonar intersticial difusa
**D)** Cáncer pulmonar
**E)** Tromboembolismo pulmonar crónico

Respuesta C. Diagnóstico: Enfermedad pulmonar intersticial difusa (opción C). Es una fibrosis pulmonar.. Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 98 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida y fumador de 5 paquetes año, consulta por un cuadro de disnea de esfuerzos de 2 años de evolución, que ha progresado desde entonces. Por ello, en la actualidad, evita subir escaleras y cargar cosas pesadas. Al examen físico se aprecian acropaquías y su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar simétrico, con crepitaciones gruesas bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Foto 11 (https://radiopaedia.org/cases/XXXXXXXXXXXXX-2). El diagnóstico más probable es:

**A)** Neumoconiosis
**B)** Cáncer bronquioloalveolar
**C)** Bronquiectasias
**D)** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
**E)** Fibrosis pulmonar idiopática

Respuesta E. Diagnóstico: Fibrosis pulmonar idiopática (opción E). Tanto por la clínica, como por la radiografía es una fibrosis pulmonar clásica.. Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

## 1.05.1.019 Hemoptisis leve y mediana

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

### QUÉ HAY QUE SABER

- Hemoptisis: sangre roja y espumosa, alcalina, con tos y carraspeo; diferenciar de hematemesis (oscura, ácida, con restos alimentarios) y epistaxis posterior.
- Leve/mediana: no compromete vía aérea, oxigenación ni hemodinamia (masiva: >150-200 mL/h o >500-600 mL/24 h).
- Causas frecuentes: bronquiectasias, cáncer, TBC, bronquitis, aspergiloma. Estudio inicial: radiografía de tórax, hemograma, coagulación y baciloscopías.
- Mayor de 40 años y fumador: TAC de tórax y fibrobroncoscopía aunque la radiografía sea normal (descartar cáncer).

- Manejo inicial ambulatorio si es leve y estable; tratar la causa (antibiótico si hay infección). Seguimiento: derivar a broncopulmonar para completar estudio.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 58 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por 1 semana de expectoración con estrías de sangre, menos de 20 mL al día. Hemodinámicamente estable, SatO2 97 % ambiental, sin fiebre. Examen pulmonar normal. Radiografía de tórax normal. Pruebas de coagulación normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Estudio ambulatorio con TAC de tórax y fibrobroncoscopía
**B)** Alta sin estudio, porque la radiografía es normal
**C)** Hospitalizar en UCI y embolización de arterias bronquiales
**D)** Ácido tranexámico y control solo si se repite
**E)** Antibiótico por bronquitis y alta sin control

Respuesta A. Hemoptisis leve en un paciente estable se estudia en forma ambulatoria. Mayor de 40 años y gran fumador tiene alto riesgo de cáncer bronquial aun con radiografía normal: se completa con TAC de tórax y fibrobroncoscopía. La embolización se reserva para la hemoptisis masiva.

## 1.05.1.020 Hidatidosis pulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Hidatidosis (Echinococcus granulosus): el humano ingiere huevos de heces de perro; quistes en hígado (65-75%) y pulmón (15-25%, bases). Más frecuente en zonas rurales ganaderas del sur.
- Quiste pulmonar intacto suele ser asintomático o da tos y dolor torácico; en la radiografía: imagen redondeada de bordes nítidos.
- Rotura a bronquio: vómica de líquido salado con membranas («hollejos de uva»), a veces hemoptoica; eosinofilia. Signo del camalote (membrana desprendida).
- Estudio: radiografía de tórax primero, luego TAC de tórax y ecografía abdominal (buscar quiste hepático); serología IgG (ELISA, arco 5) como apoyo.
- Tratamiento: cirugía conservadora (quistectomía con capitonaje) + albendazol perioperatorio 10-15 mg/kg/día. La punción percutánea está contraindicada en el pulmón (anafilaxia, siembra).
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax; notificación y educación (no alimentar perros con vísceras crudas, desparasitarlos).

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 11**

Un paciente de 42 años presenta tos seca de 7 días de evolución que hace 3 días se volvió productiva, con secreción de sabor salado. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca 68 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y frecuencia respiratoria 16 rpm. El examen pulmonar muestra matidez en la zona inferior del campo pulmonar derecho, con disminución del murmullo pulmonar en dicha zona. Los exámenes de laboratorio revelan un hematocrito: 38%, plaquetas: 312.000 por mm³, y glóbulos blancos: 12.000 por mm³, con 10% de eosinófilos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Derrame pleural tuberculoso
**B)** Hidatidosis pulmonar
**C)** Absceso pulmonar
**D)** Neumonía
**E)** Carcinoma broncogénico

Respuesta B. Expectoración de sabor salado (vómica) en la base pulmonar con eosinofilia: quiste hidatídico pulmonar roto hacia el bronquio. El quiste pulmonar intacto suele ser asintomático.

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente con expectoración hemoptoica y eliminación de contenido 'en uvas'. Radiografía con imagen compatible. ¿Diagnóstico más probable?

**A)** Quiste hidatídico pulmonar
**B)** Absceso pulmonar
**C)** Bronquiectasias
**D)** Cáncer pulmonar cavitado
**E)** Aspergilosis pulmonar invasiva

Respuesta A. Diagnóstico: Quiste hidatídico pulmonar (opción A). Quiste hidatídico pulmonar. Esta clase revisa las infecciones oportunistas del VIH. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

## 1.05.1.021 Hipertensión pulmonar

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.12 Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

### QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión pulmonar: presión arterial pulmonar media >20 mmHg en cateterismo derecho. Grupos: HAP (grupo 1: idiopática, conectivopatías como CREST), cardiopatía izquierda, enfermedad pulmonar/hipoxemia (EPOC, EPID, SAHOS), tromboembólica crónica y miscelánea.
- Sospecha: disnea de esfuerzo progresiva sin otra explicación, fatiga, síncope de esfuerzo, R2 pulmonar aumentado, signos de falla derecha (edema, ingurgitación yugular, hepatomegalia).
- Estudio: ecocardiograma (PSAP elevada, VD dilatado) como tamizaje; ECG, radiografía, espirometría/DLCO, TAC y cintigrafía V/Q para buscar la causa. Confirmación con cateterismo cardíaco derecho.
- Esclerosis sistémica limitada (CREST, anticentrómero): HAP tardía aislada sin fibrosis en TAC; requiere ecocardiograma anual.
- Manejo inicial: tratar la causa de base, oxígeno si hay hipoxemia (PaO2 ≤55-59 mmHg), diuréticos para la congestión, anticoagulación en la tromboembólica crónica.
- Seguimiento: derivar a centro especializado para vasodilatadores específicos (sildenafil, bosentán, prostanoides).

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta real · EUNACOM 2023 · Pregunta 45**

Una mujer de 58 años con antecedente de esclerosis sistémica cutánea limitada (CREST) de 15 años de evolución consulta por disnea de esfuerzo rápidamente progresiva en los últimos 3 meses, sin tos ni ortopnea. El examen pulmonar es limpio sin estertores crepitantes. El ecocardiograma Doppler transtorácico revela dilatación severa de cavidades derechas y una presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP) estimada en 65 mmHg. La tomografía computarizada de tórax de alta resolución no muestra infiltrados intersticiales ni fibrosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

**A)** Neumonía intersticial no específica (NINE)
**B)** Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP Grupo 1)
**C)** Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada izquierda
**D)** Tromboembolismo pulmonar crónico recurrente
**E)** Estenosis mitral reumática severa

Respuesta B. En la esclerosis sistémica cutánea limitada (CREST), la complicación visceral tardía más temida es la Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP Grupo 1) por vasculopatía proliferativa obliterante de las arterias pulmonares pequeñas, que ocurre en ausencia de enfermedad pulmonar intersticial significativa. Se manifiesta típicamente tras más de 10-15 años de evolución con disnea de esfuerzo progresiva y sobrecarga de cavidades derechas.

## 1.05.1.022 Infecciones de las vías aéreas superiores

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

### QUÉ HAY QUE SABER

- IVAS: resfrío, faringitis, rinosinusitis, laringitis; >98% virales. Rinosinusitis aguda: ≥2 síntomas (obstrucción, rinorrea purulenta, dolor facial, hiposmia).

- Secreción verde no indica infección bacteriana y no se pide radiografía de senos: el diagnóstico es clínico.
- Rinosinusitis bacteriana si cumple uno: persistencia ≥10 días sin mejoría, doble caída (mejora y recae con fiebre) o inicio severo (fiebre ≥39 °C y pus por 3-4 días).
- Tratamiento: resfrío y gripe sintomáticos (paracetamol, hidratación, lavados con suero). Sinusitis bacteriana: amoxicilina 7-10 días (adultos 1 g c/12 h; niños 80-90 mg/kg/día); con clavulánico si hubo antibiótico reciente, comorbilidad o falla; macrólido en alérgicos.
- Banderas rojas: proptosis, oftalmoplejía dolorosa o baja visual (celulitis orbitaria): hospitalizar, TAC con contraste y antibiótico EV. Seguimiento: control si no mejora a las 48-72 h.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 10**

Un paciente de 38 años consulta por malestar general y fiebre de 3 días de evolución, asociada a mialgias, tos seca y rinorrea mucosa abundante. Al examen físico tiene secreción nasal y faringe congestiva y eritematosa. **¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de este paciente?**

**A)** Amoxicilina
**B)** Aciclovir
**C)** Acetaminofeno
**D)** Claritromicina
**E)** Prednisona

Respuesta C. Fiebre, mialgias, tos seca, rinorrea y faringe eritematosa sin exudado ni signos de gravedad corresponden a una infección viral de la vía aérea superior (resfrío o síndrome gripal). En un adulto sano el manejo es sintomático con paracetamol, hidratación y reposo. Los antibióticos no están indicados y el aciclovir no actúa sobre virus respiratorios.

## 1.05.1.023 Insuficiencia respiratoria crónica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg (SatO2 <90%) respirando aire ambiental a nivel del mar. Tipo 1 hipoxémica (PaCO2 ≤45) o tipo 2 hipercápnica (PaCO2 >45).
- Crónica: pH casi normal con bicarbonato elevado por compensación renal (ej. EPOC grave: pH 7,37, PaCO2 58, HCO3 33). Causas: EPOC, EPID, enfermedades neuromusculares, obesidad-hipoventilación, deformidades torácicas.
- Gradiente A-a = (150 – PaCO2/0,8) – PaO2: normal (5-15, hasta 20 en ancianos) indica hipoventilación o altura; elevado indica enfermedad pulmonar.
- En retenedores de CO2 titular el oxígeno a SatO2 88-92% (Venturi con FiO2 fija); el exceso de oxígeno empeora la hipercapnia.
- Oxígeno domiciliario ≥15 h/día si PaO2 ≤55 mmHg o 56-59 con cor pulmonale o poliglobulia (aumenta la sobrevida).
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar para oxigenoterapia domiciliaria (GES) o ventilación no invasiva domiciliaria en hipercápnicos.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 68 años con EPOC grave, estable y sin exacerbación reciente, tiene gases arteriales en reposo: pH 7,37, PaCO2 58 mmHg, PaO2 58 mmHg y HCO3 33 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

**A)** Insuficiencia respiratoria crónica global (hipoxémica e hipercápnica) con compensación metabólica
**B)** Acidosis respiratoria aguda descompensada
**C)** Alcalosis metabólica primaria
**D)** Gases arteriales normales
**E)** Acidosis metabólica

Respuesta A. PaO2 bajo 60 mmHg y PaCO2 sobre 45 mmHg definen insuficiencia respiratoria global. El pH casi normal con bicarbonato elevado refleja retención renal de bicarbonato, propia de un proceso crónico compensado; en una acidosis respiratoria aguda el pH estaría claramente bajo. En hipercápnicos crónicos el oxígeno se titula a saturación de 88 a 92%.

## 1.05.1.024 Intoxicación leve por CO y otros gases

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

### QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicación por CO: combustión incompleta (brasero, calefón, estufa a gas) en espacio cerrado, típicamente en invierno y con varios convivientes afectados.
- Leve: cefalea holocraneana pulsátil (síntoma más precoz), náuseas, mareo, sin compromiso de conciencia, isquemia ni embarazo. El color rojo cereza es raro y tardío.
- El oxímetro de pulso marca falsamente normal (98-100%): se confirma con carboxihemoglobina por co-oximetría (>3-5% en no fumador, >10% en fumador).
- Tratamiento: oxígeno al 100% con mascarilla de no recirculación a 15 L/min, al menos 6 horas o hasta que cedan los síntomas (vida media de la COHb: 320 min al aire, 80 min con O2 100%). La naricera no sirve.
- Cámara hiperbárica solo si COHb >25%, embarazada >15%, síncope, coma, convulsiones, déficit neurológico, isquemia miocárdica o pH <7,15.
- Evaluar a todos los expuestos, eliminar la fuente y educar en ventilación de la vivienda; control si reaparecen síntomas neurológicos.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 40 años, sano, consulta junto a su familia por cefalea leve y náuseas tras pasar la noche con un calefactor a gas en una pieza cerrada. Consciente, orientado, sin focalidad, sin dolor torácico. PA 125/80 mmHg, SatO2 98 % por oxímetro de pulso. ECG normal. Co-oximetría: COHb 9 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Alta inmediata, porque la saturación es normal
**B)** Derivar a cámara hiperbárica de inmediato
**C)** Oxígeno al 100 % normobárico con mascarilla con reservorio hasta resolver los síntomas, y evaluar a los convivientes
**D)** Oxígeno por naricera a 1 L/min por 1 hora
**E)** Azul de metileno endovenoso

Respuesta C. Intoxicación leve por CO: síntomas menores, sin compromiso de conciencia, sin isquemia ni embarazo, y COHb menor de 25 %. Se trata con oxígeno al 100 % normobárico (mascarilla con reservorio), que acorta la vida media de la COHb, hasta que cedan los síntomas. Se estudia a los expuestos y se elimina la fuente.

## 1.05.1.025 Metástasis pulmonares

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar metástasis ante nódulos pulmonares múltiples, redondeados, bien definidos, de distinto tamaño, periféricos y basales («suelta de globos») en paciente con cáncer previo.
- Primarios frecuentes: colon, mama, riñón, sarcomas, testículo, melanoma, cabeza y cuello. Suelen ser asintomáticas; pueden dar tos, hemoptisis o derrame pleural.
- Estudio: TAC de tórax con contraste (más sensible que la radiografía) y búsqueda del primario si no es conocido; confirmación histológica si cambia la conducta.
- Diferencial: TBC miliar (micronódulos uniformes de 1-3 mm con síntomas sistémicos), granulomatosis con poliangeítis, émbolos sépticos.
- Seguimiento: derivar a oncología; en casos seleccionados con primario controlado y pocas lesiones, metastasectomía.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 58 años, operada de un cáncer de colon hace 2 años, presenta en una TAC de control múltiples nódulos pulmonares bilaterales, redondeados, bien definidos, de distintos tamaños y de predominio periférico y basal. Está asintomática. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Tuberculosis miliar
**B)** Neumonía multifocal
**C)** Cáncer pulmonar primario múltiple
**D)** Granulomatosis con poliangeítis
**E)** Metástasis pulmonares hematógenas

Respuesta E. Nódulos múltiples, redondeados, bien definidos, de distintos tamaños, periféricos y basales en un paciente con cáncer previo son metástasis hematógenas hasta demostrar lo contrario (imagen en 'suelta de globos'). El pulmón es sitio frecuente de metástasis de colon, mama, riñón, sarcomas y testículo. La TBC miliar da micronódulos uniformes de 1 a 3 mm con síntomas sistémicos.

## 1.05.1.026 Neumoconiosis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

### QUÉ HAY QUE SABER

- Neumoconiosis: enfermedad pulmonar por inhalación de polvos inorgánicos; en Chile la principal es la silicosis (minería, canteras, arenado), además de asbestosis.
- Sospechar ante disnea progresiva y tos en trabajador expuesto por años, con compromiso intersticial nodular de predominio superior y central y adenopatías hiliares con calcificación «en cáscara de huevo».
- Asbesto: placas pleurales, fibrosis basal, mesotelioma y cáncer pulmonar. La silicosis predispone a tuberculosis y cáncer pulmonar.
- Estudio: anamnesis laboral detallada, radiografía (clasificación OIT), TACAR y espirometría (patrón restrictivo o mixto).
- No tiene tratamiento curativo: retirar de la exposición, dejar de fumar, vacunas, descartar TBC. Notificar como enfermedad profesional.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar y a la mutualidad (Ley 16.744).

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 137**

Un paciente de 67 años, fumador de 15 paquetes-año que dejó de fumar hace 10 años, jubilado de la minería, consulta por disnea de esfuerzos progresiva de 6 meses de evolución, asociada a tos. Al examen físico presenta murmullo pulmonar globalmente disminuido, sibilancias y roncus bilaterales, asociados a crepitaciones difusas. La radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales, mayores en las zonas centrales, con imágenes verticales onduladas de 1 a 2 cm en ambos campos pulmonares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Bronquitis crónica
**B)** Neumoconiosis
**C)** Cáncer de pulmón
**D)** Limitación crónica del flujo aéreo
**E)** Fibrosis pulmonar idiopática

Respuesta B. El antecedente laboral en la minería, con disnea progresiva y compromiso intersticial bilateral de predominio central y superior, orienta a neumoconiosis, en Chile principalmente silicosis. La fibrosis pulmonar idiopática compromete las bases y la periferia, y el tabaquismo leve y antiguo no explica el cuadro.

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 89 · texto original del banco, sin revisar**

Trabajador de la minería, fumador leve, con disnea, sibilancias, hiperinsuflación y espirometría obstructiva no reversible. ¿Diagnóstico más probable?

**A)** EPOC por tabaquismo
**B)** Asma ocupacional
**C)** Fibrosis pulmonar idiopática
**D)** Silicosis pulmonar
**E)** Neumoconiosis por carbón (antracosis)

Respuesta D. Diagnóstico: Silicosis pulmonar (opción D). Silicosis pulmonar. Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco de

## 1.05.1.027 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 · Tema 2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

### QUÉ HAY QUE SABER

- NAC tipo 4 (grave, de UCI): CURB-65 ≥3 (4-5: UCI inmediata) o criterios ATS/IDSA. Mayores: shock con vasopresores o necesidad de ventilación invasiva (basta uno).
- Criterios menores (≥3): FR ≥30, PaFi ≤250, infiltrado multilobar, confusión, BUN ≥20, leucocitos <4.000, plaquetas <100.000, T° <36 °C, hipotensión que requiere volumen.
- Confirmación con radiografía de tórax; hemocultivos, gases arteriales, lactato, función renal; GES en ≥65 años.
- Manejo inicial: oxígeno, reanimación con fluidos y antibiótico precoz (<1 h en sepsis): ceftriaxona 2 g/día + levofloxacino 750 mg/día EV (o + azitromicina EV).
- Riesgo de Pseudomonas (bronquiectasias, fibrosis quística, corticoides): piperacilina/tazobactam o cefepime + ciprofloxacino; riesgo de SAMR: agregar vancomicina.
- Seguimiento: derivar a UCI; manejo por especialista.

### PREGUNTAS (11)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 52**

Un paciente con antecedente de EPOC, fumador de 25 paquetes año, consulta por cuadro de tres días de evolución de exacerbación de su disnea basal y expectoración mucosa, asociado a sensación febril y hace un día se agrega dolor tipo puntada de costado. Al examen se aprecia frecuencia respiratoria de 21 por minuto, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, temperatura de 38,1°C. Al examen pulmonar presenta crepitaciones de la cara lateral del hemitórax derecho, asociado a matidez a la percusión. Se solicita una radiografía de tórax. **El diagnóstico más probable:**

**A)** Tuberculosis
**B)** Derrame pleural
**C)** Neumonía
**D)** Tromboembolismo pulmonar
**E)** Cáncer bronquial

Respuesta C. Cuadro agudo de fiebre, puntada de costado, crepitaciones localizadas y matidez: clínica de NAC, que la radiografía confirma. La matidez puede tentar hacia el derrame, pero las crepitaciones y la fiebre aguda apuntan a condensación.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 139**

Un paciente de 60 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos, asociada a expectoración mucopurulenta. Evoluciona con dificultad respiratoria, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen físico tiene FC: 113x', PA: 100/60 mmHg, FR: 33x' y al examen pulmonar presenta crepitaciones inspiratorias, en el hemicampo pulmonar derecho. La radiografía de tórax muestra condensación en los lóbulos medio e inferior derecho y satura 83%, con FiO2 ambiental, que sube a 90%, con oxígeno al 40%, por mascarilla de recirculación. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección para este paciente?**

**A)** Cefepime más amykacina
**B)** Ceftriaxona más clindamicina
**C)** Cloxacilina más metronidazol
**D)** Cefotaximo más moxifloxacino
**E)** Piperacilina más tazobactam

Respuesta D. NAC grave: FR 33, PA 100/60 (diastólica ≤ 60), dos lóbulos comprometidos e insuficiencia respiratoria grave. Es una NAC de UCI, y el esquema es una cefalosporina de tercera generación (cefotaximo o ceftriaxona) más una quinolona respiratoria o un macrólido.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 127**

Una paciente de 45 años, hipertensa, presenta un cuadro de 4 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,8°C, mialgias, cefalea y tos con expectoración mucopuruleta. Al examen físico tiene FR: 13 lpm, FC: 80x'. PA: 120/80 mmHg, examen pulmonar con crépitos en la base izquierda, matidez y aumento de la trasmisión de las vibraciones vocales en la zona. Examen cardíaco normal. Satura 98% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

**A)** Oseltamivir
**B)** Levofloxacino
**C)** Ceftriaxona
**D)** Amoxicilina
**E)** Claritromicina

Respuesta D. NAC típica (condensación del lóbulo inferior izquierdo), sin criterios de hospitalización, en una menor de 65 años sin comorbilidades relevantes (la hipertensión no agrava la neumonía): amoxicilina sola.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 15**

Un paciente de 21 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, FR: 17x' y en la auscultación pulmonar se escuchan crepitaciones en la mitad inferior del campo pulmonar derecho. Satura 93% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía de tórax, que muestra condensación del lóbulo inferior. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?**

**A)** Claritromicina
**B)** Cefadroxilo
**C)** Clindamicina
**D)** Cloxacilina
**E)** Ciprofloxacino

Respuesta A. NAC de bajo riesgo en un joven sano. Lo ideal sería amoxicilina, pero no está entre las opciones: el macrólido es la mejor alternativa. Cefadroxilo, cloxacilina y clindamicina no son esquemas de NAC, y el ciprofloxacino no cubre bien al neumococo.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 138**

Hombre de 75 años con neumonía adquirida en la comunidad. Sin hospitalización reciente ni antibióticos en los últimos 3 meses. Sin alergias. **¿Cuál es el antibiótico de primera línea más adecuado?**

**A)** Amoxicilina-clavulánico oral
**B)** Ciprofloxacino oral
**C)** Clindamicina oral
**D)** Cefalexina oral
**E)** Azitromicina oral

Respuesta A. NAC ambulatoria en mayor de 65 años: amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/12 h por 7 días, por la cobertura de H. influenzae y M. catarrhalis productores de betalactamasa.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 105**

Un paciente con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta un cuadro de 3 días de evolución, de fiebre hasta 38,9°C, asociada a malestar general, tos, expectoración mucopurulenta y aumento de la disnea. Al examen físico se observa con apremio respiratorio de reposo y se auscultan sibilancias difusas, más crepitaciones en la zona posterior del lóbulo inferior derecho. Se solicita una radiografía de tórax. **¿Qué antibiótico es el más adecuado para el tratamiento de este paciente?**

**A)** Amoxicilina
**B)** Claritromicina
**C)** Clindamicina
**D)** Cefotaximo
**E)** Azitromicina

Respuesta D. Neumonía en un paciente con EPOC y apremio respiratorio de reposo: se hospitaliza, y el esquema de sala es una cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona o cefotaximo, con la misma cobertura).

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 107**

Paciente de 23 años, sin antecedentes, con cuadro de 2 semanas de rinorrea y coriza, que durante los últimos dos días se asocia a compromiso del estado general, sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta signos vitales dentro de rangos normales, murmullo pulmonar presente en ambos campos pulmonares asociado a crepitaciones en base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra infiltrado intersticial en base derecha. **El tratamiento de elección de esta patología es:**

**A)** Claritromicina
**B)** Amoxicilina-ácido clavulánico
**C)** Clindamicina
**D)** Ceftriaxona
**E)** Moxifloxacino

Respuesta A. Joven, cuadro arrastrado de 2 semanas e infiltrado intersticial: sospechar Mycoplasma. Los macrólidos lo cubren bien y son de elección. El moxifloxacino también lo cubre, pero su espectro es innecesariamente amplio.

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 153**

Un adolescente de 17 años presenta un cuadro de 5 días de evolución de tos con expectoración mucosa, al que se le ha agregado fiebre hasta 37,6ºC. Al examen físico está en buenas condiciones, con FR: 15x', saturación oxígeno: 95% y examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, auscultándose crepitaciones y sibilancias bilaterales. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

**A)** Streptococcus pneumoniae
**B)** Mycoplasma pneumoniae
**C)** Chlamydia trachomatis
**D)** Virus influenza
**E)** Pneumocystis jiroveci

Respuesta B. Adolescente en buenas condiciones, con febrícula y compromiso bilateral (crépitos y sibilancias): neumonía atípica, por Mycoplasma pneumoniae, aunque lleve solo 5 días.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 72 años consulta en el CESFAM por 48 horas de fiebre hasta 38,8 °C y tos con expectoración herrumbrosa. Orientada, FR 24 rpm, FC 92 lpm, PA 130/80 mmHg, SatO2 95% ambiental. Crépitos en el tercio inferior derecho. BUN 14 mg/dL. Rx de tórax: condensación del lóbulo inferior derecho, sin derrame. Tiene buena red de apoyo familiar. **¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta más adecuada?**

**A)** CURB-65 de 0; tratamiento sintomático sin antibióticos
**B)** CURB-65 de 1; manejo ambulatorio con antibiótico oral y control en 48 horas
**C)** CURB-65 de 2; hospitalización en sala general
**D)** CURB-65 de 1; hospitalización obligatoria por ser mayor de 65 años
**E)** CURB-65 de 3; ingreso a UCI

Respuesta B. Confusión 0, BUN 14 (0), FR 24 (0), PA 130/80 (0), edad ≥ 65 (1): CURB-65 = 1, solo por edad. Estable, sin hipoxemia y con red de apoyo: manejo ambulatorio GES con amoxicilina/clavulánico 875/125 c/12 h por 7 días y control a las 48 horas.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 132 · texto original del banco, sin revisar**

IMAGEN: Paciente 66 años con neumonía (clínica e imágen de neumonía monolobar) saturando 94% ¿Cual es el tratamiento?:

**A)** Ceftriaxona b. Amoxicilina con Ac. clavulánico
**B)** Derrame pleural
**C)** Neumotórax
**D)** Neumonía
**E)** Atelectasia

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Ceftriaxona b. Amoxicilina con Ac. clavulánico (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 100 · texto original del banco, sin revisar**

Una mujer de 63 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril y amlodipino, consulta por tos, con expectoración mucopurulenta, de 3 días de evolución. Además, presenta fiebre, malestar general y dolor torácico con la inspiración máxima. Al examen físico, se constata T°: 38 °C, PA: 120/80 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 15 rpm, saturación de oxígeno: 97% y en el examen cardiopulmonar destacan crepitaciones localizados en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Foto 12 (http://elesfenoides.blogspot.com/2014/07/XXXXXXXXXX-imagenes-1.html) ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

**A)** Amoxicilina con ácido clavulánico
**B)** Ceftriaxona
**C)** Levofloxacino
**D)** Clindamicina
**E)** Azitromicina

Respuesta A. Tiene una neumonía del lóbulo superior derecho. En estricto rigor, se puede tratar con amoxicilina, ya que no tiene indicación de ácido clavulánico. Pero de las opciones, la mejor era la A.

## 1.05.1.028 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipos 1, 2 y 3 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

### QUÉ HAY QUE SABER

- NAC: infección aguda del parénquima adquirida fuera del hospital (o <48 h del ingreso); confirmación obligatoria con radiografía de tórax (infiltrado nuevo). GES en ≥65 años.
- Gravedad con CURB-65 (confusión, urea >42 mg/dL, FR ≥30, PAS <90 o PAD ≤60, edad ≥65): 0-1 ambulatorio (si el punto es la edad); 2 hospitalizar en sala. En APS se usa CRB-65.
- Tipo 1 (ambulatorio, <65 años sano): amoxicilina 1 g c/8 h VO 5-7 días; alergia: azitromicina 500 mg/día 3-5 días o claritromicina 500 mg c/12 h.
- Tipo 2 (ambulatorio, ≥65 o comórbido): amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/12 h por 7 días; alternativa cefuroximo 500 mg c/12 h. Atípicos (joven, infiltrado intersticial): macrólido.
- Tipo 3 (sala): ceftriaxona 1-2 g/día EV ± azitromicina; pasar a vía oral si afebril >48 h y estable, completando 7 días.
- Seguimiento completo: control a las 48-72 h; fiebre persistente a las 72 h obliga a buscar derrame complicado, absceso o germen resistente. No se requiere radiografía de control para el alta.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 42 años, previamente sano, no fumador, con 3 días de fiebre hasta 38,6 °C, tos con expectoración mucosa y puntada de costado derecha. SatO2 96%, PA 120/75 mmHg, FR 18 rpm, crépitos en base derecha. Rx de tórax: condensación del lóbulo inferior derecho. CURB-65 = 0. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** Ceftriaxona 1 g intramuscular al día
**B)** Levofloxacino 750 mg al día por vía oral
**C)** Amoxicilina 1 g cada 8 horas por vía oral por 5 a 7 días
**D)** Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
**E)** Hospitalizar y ceftriaxona más azitromicina endovenosas

Respuesta C. NAC de bajo riesgo (CURB-65 = 0) en un joven sin comorbilidades: manejo ambulatorio con amoxicilina 1 g c/8 h VO por 5–7 días. No se justifican cefalosporinas de tercera generación ni quinolonas de entrada; el clavulánico se reserva para ≥ 65 años o comórbidos.

## 1.05.1.029 Neumonías en inmunosuprimidos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

### QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en VIH avanzado, quimioterapia, trasplante o corticoides crónicos: gérmenes oportunistas según el grado de inmunosupresión.
- Pneumocystis jirovecii (CD4 <200): disnea subaguda de semanas, tos seca, desaturación al esfuerzo, LDH elevada e infiltrado intersticial bilateral perihiliar (la radiografía puede ser normal).
- Otros: TBC (cualquier CD4), neumococo, aspergilosis en neutropénicos (masa con halo en TAC), CMV. Siempre pedir VIH ante neumonía subaguda en joven enflaquecido.
- Manejo inicial de PCP: cotrimoxazol EV dosis altas (TMP 15-20 mg/kg/día por 21 días) + corticoides si PaO2 <70 mmHg o gradiente A-a ≥35, antes o junto con el antibiótico.
- Prevención: cotrimoxazol forte diario si CD4 <200; se suspende con CD4 >200 por ≥3 meses en TARV.
- Seguimiento: derivar a infectología/hospitalizar; iniciar o reiniciar TARV según especialista.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 34 años con VIH diagnosticado hace 4 años y abandono de TARV. Tos seca de 3 semanas, disnea progresiva, hoy a mínimos esfuerzos, y fiebre vespertina. T° 38,2 °C, FR 28, SatO2 86% ambiental. Rx: infiltrados intersticiales bilaterales perihiliares en vidrio esmerilado. GSA: PaO2 54 mmHg, gradiente A-a 52 mmHg. CD4: 68/mm³. **Además del cotrimoxazol EV en dosis altas, ¿qué medida es indispensable?**

**A)** Corticoides sistémicos antes o junto con el cotrimoxazol
**B)** Agregar azitromicina para cubrir atípicos
**C)** Iniciar corticoides solo si empeora a las 72 horas
**D)** Agregar ganciclovir por posible citomegalovirus
**E)** Iniciar diuréticos de asa para el edema alveolar

Respuesta A. Neumonía por Pneumocystis grave (CD4 < 200) con PaO2 54 mmHg (< 70) y gradiente A-a 52 mmHg (≥ 35): indicación formal de corticoides sistémicos (prednisona o metilprednisolona) antes o junto con el cotrimoxazol. Omitirlos aumenta la mortalidad por el deterioro ventilatorio que sigue a la lisis del hongo.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 38 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

**A)** Fibrosis pulmonar
**B)** Asma bronquial
**C)** Neumonitis viral
**D)** Neumonía por mycoplasma
**E)** Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta E. Es una pregunta difícil, pero que esté enflaquecido más el cuadro clínico, hace que se trate de una neumonía por P. jiroveci. Si hubiese venido sin mayores antecedentes y con un cuadro un poco más corto, sin baja de peso, habría que pensar en Mycoplasma, que puede ser igual. La fibrosis y el asma serían cuadros más crónicos, con radiografías distintas (panal de abejas en fibrosis y normal o hiperi

## 1.05.1.030 Neumonías nosocomiales

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

### QUÉ HAY QUE SABER

- Neumonía intrahospitalaria: aparece después de 48 h del ingreso y no estaba en incubación; asociada a ventilador si aparece >48 h tras la intubación.
- Diagnóstico: fiebre, secreciones purulentas, deterioro de la oxigenación e infiltrado nuevo en la radiografía; tomar hemocultivos y cultivo de secreción respiratoria antes del antibiótico.
- Gérmenes del hospital: Pseudomonas, Klebsiella BLEE, Acinetobacter y S. aureus resistente (SAMR).
- Tratamiento empírico: piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h o cefepime 2 g c/8 h EV, + vancomicina si sospecha de SAMR; ajustar según cultivos.
- Prevención: cabecera elevada 30-45°, higiene de manos, aseo oral, retiro precoz de la ventilación y sondas.
- Seguimiento: manejo por especialista e IAAS; derivar.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia fiebre de 38,6 °C, taquipnea, desaturación y estertores crepitantes en ambos hemitórax. La radiografía de tórax muestra infiltrados nuevos en la base pulmonar izquierda. **¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más apropiada?**

**A)** Diagnóstico de NAC atípica; tratar con eritromicina oral por 7 días
**B)** Diagnóstico de neumonía intrahospitalaria; hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam
**C)** Diagnóstico de embolia grasa; corticoides a altas dosis
**D)** Diagnóstico de bronquitis aguda viral; observación sin antimicrobianos
**E)** Diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico; suspender fluidos e indicar amoxicilina oral

Respuesta B. Infiltrado nuevo con fiebre después de 48 horas de hospitalización: neumonía intrahospitalaria. Flora del hospital (Pseudomonas, enterobacterias multirresistentes): cultivos y betalactámico antipseudomónico EV (piperacilina/tazobactam o cefepime).

## 1.05.1.031 Neumotórax moderado y grande

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

### QUÉ HAY QUE SABER

- Neumotórax: dolor pleurítico súbito y disnea con murmullo disminuido y timpanismo. Primario: varón joven, alto, delgado, fumador (blebs apicales). Secundario: EPOC, TBC, fibrosis, Pneumocystis.
- Confirmación con radiografía de tórax: línea de pleura visceral sin trama periférica. Moderado/grande: ≥2 cm a nivel del hilio (o ≥3 cm en el vértice).

- Primario grande o sintomático: aspiración con aguja o tubo pleural. Secundario: tubo pleural y hospitalización casi siempre, aunque sea pequeño.
- Si hay hipotensión, desviación traqueal o ingurgitación yugular, es a tensión: descompresión inmediata sin esperar radiografía.
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax. VATS con resección de blebs y pleurodesis si es recurrente (2.º episodio), bilateral, con fuga aérea >48-72 h o en profesiones de riesgo (pilotos, buzos).

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 80**
>
> Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. **El diagnóstico más probable es:**
>
> **A)** Angina inestable
> **B)** Tromboembolismo pulmonar
> **C)** Neumotorax espontáneo
> **D)** Perforación esofágica
> **E)** Contractura muscular
>
> Respuesta C. Joven sano, dolor torácico súbito con disnea leve, en buenas condiciones y con murmullo pulmonar disminuido en un hemitórax: neumotórax espontáneo (primario). La asimetría del murmullo es el dato que descarta la contractura muscular.

## 1.05.1.032 Neumotórax pequeño

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Neumotórax pequeño: separación <2 cm a nivel del hilio (o <3 cm en el vértice) en la radiografía de tórax, en paciente estable y eupneico.
- Primario pequeño y estable: oxígeno a alto flujo (acelera la reabsorción) y observación 4-6 horas; si la radiografía de control no progresa, alta con control.
- Secundario (EPOC, fibrosis, TBC) aunque sea pequeño: tubo pleural y hospitalización, por falta de reserva funcional.
- Educar: evitar viajes en avión y buceo hasta la resolución, consultar si aumenta la disnea; dejar de fumar (reduce la recurrencia).
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax o broncopulmonar; la recurrencia es ~30% tras el primero y >50% tras el segundo (indicación de VATS).

**PREGUNTAS (2)**

> **Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 93**
>
> Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico derecho, de 2 días de evolución, que aumenta con la inspiración y con la actividad física. Al examen físico está eupneico, con FR: 15x', saturación de oxígeno normal, se aprecia disminución del murmullo pulmonar mayor en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: [radiografía: neumotórax derecho pequeño, sin colapso pulmonar]. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Control radiológico en 24 horas
> **B)** Solicitar TAC de tórax
> **C)** Realizar cirugía abierta
> **D)** Drenaje con tubo pleural
> **E)** Realizar videotoracoscopía
>
> Respuesta A. Mismas alternativas que la pregunta anterior, pero ahora el neumotórax es pequeño, sin colapso pulmonar, en un paciente eupneico y con saturación normal que lleva 2 días sin agravarse: manejo conservador con control radiológico.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 68 años con EPOC con enfisema buloso consulta por disnea y dolor torácico derecho súbito. FR 26/min, SatO2 88 %, PA 130/80 mmHg. La radiografía de tórax muestra un neumotórax derecho con separación de 1,5 cm a nivel del hilio, sin desviación mediastínica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Oxígeno por mascarilla y observación por 4 a 6 horas
**B)** Alta con control radiológico en 24 horas
**C)** Instalar tubo de drenaje pleural y hospitalizar
**D)** Punción descompresiva en el 2.º espacio intercostal
**E)** Videotoracoscopía con pleurodesis de urgencia

Respuesta C. Neumotórax espontáneo secundario (EPOC con enfisema buloso). Aunque mide menos de 2 cm, el paciente no tiene reserva funcional: casi siempre requiere tubo de drenaje pleural y hospitalización. La observación con oxígeno es para el primario pequeño y estable; la punción es del neumotórax a tensión.

## 1.05.1.033 Síndrome de apnea del sueño

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

### QUÉ HAY QUE SABER

- SAHOS: colapso faríngeo durante el sueño con apneas (≥10 s) e hipopneas, microdespertares y descarga simpática.
- Sospechar con la tríada: ronquidos fuertes, apneas presenciadas y somnolencia diurna excesiva, en obeso (IMC >30), cuello >43 cm (hombre) o >40 cm (mujer), retrognatia.
- Otros: cefalea matinal, nicturia, alteración de memoria, HTA refractaria, accidentes de tránsito. Epworth >10 indica estudio.
- Confirmación con polisomnografía (o poligrafía en alta probabilidad): IAH leve 5-14, moderado 15-29, severo ≥30.
- Manejo inicial: baja de peso, evitar alcohol, benzodiacepinas e hipnóticos, decúbito lateral; advertir sobre conducción.
- Seguimiento: derivar para confirmación y CPAP nasal nocturno (IAH ≥15, o leve con somnolencia, HTA o chofer profesional).

### PREGUNTAS (6)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 13**

Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diurna. Refiere que ronca en la noche y se queda dormido en las luces rojas del semáforo. En su examen físico destaca PA: 140/90 mmHg, FC: 72x' y faringe normal. **¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?**

**A)** Poligrafía nocturna
**B)** Polisomnografía
**C)** Saturación arterial de oxígeno durante el sueño
**D)** Monitorización de presión arterial de 24 horas
**E)** Nasofibroscopía

Respuesta B. Obesidad, ronquidos y somnolencia diurna (se duerme en el semáforo): sospecha de SAHOS. El estándar de oro para confirmarlo y medir el IAH es la polisomnografía nocturna; la poligrafía es una alternativa, no el examen de elección.

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 86**

Un paciente de 78 años, con sobrepeso, presenta alteraciones de la memoria y dificultades para concentrarse, que iniciaron hace 2 años y que han progresado, asociado a hipersomnia y cansancio. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

**A)** Electrocardiograma
**B)** Ecocardiograma
**C)** Polisomnografía
**D)** RMN de cerebro
**E)** TAC de cerebro

Respuesta C. Sobrepeso con hipersomnia y cansancio orientan a SAHOS; el sueño fragmentado explica la falla de memoria y concentración. El examen de elección es la polisomnografía.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 81**

Un Paciente de 52 años con historia de ronquidos frecuentes, de larga data, que desde hace 5 años, se asocia a somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Al examen físico tiene frecuencia cardiaca de 75x' y presión arterial de 140/100 mmHg. Su IMC es de 35. Se realiza polisomnografía que evidencia índice de apneas de 50 eventos de apnea / hipopnea por hora, con predominio de los eventos obstructivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Oxígeno nocturno
**B)** C-PAP nocturno
**C)** Cirugía bariátrica
**D)** Uvulopalatoplastía
**E)** Dispositivo orofaríngeo

Respuesta B. IAH 50 (≥ 30): SAHOS severo, obstructivo, con somnolencia e HTA. El tratamiento de elección es el CPAP nasal nocturno. El oxígeno no evita el colapso faríngeo; la cirugía y los dispositivos no son primera línea en el SAHOS severo.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 146**

Paciente con apnea del sueño, tenía polisomnografía con 65 episodios por hora, hipertrofia de cornetes conducta: **¿Cuál es la conducta?**

**A)** CPAP
**B)** Cirugía de cornetes
**C)** Laparotomía exploratoria
**D)** Cirugía laparoscópica
**E)** Manejo conservador

Respuesta A. IAH 65: SAHOS severo. El CPAP es el tratamiento de elección aunque exista un hallazgo anatómico como la hipertrofia de cornetes; la cirugía de cornetes no resuelve el colapso faríngeo.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 50 años, conductor de camiones, IMC 36 kg/m², perímetro de cuello 46 cm, hipertenso con tres fármacos y mal control. Su esposa refiere ronquidos intensos y pausas respiratorias nocturnas. Epworth 15. La polisomnografía muestra un IAH de 42 eventos/hora, de predominio obstructivo. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** Oxigenoterapia nocturna por naricera a 2 L/min
**B)** Zopiclona nocturna para consolidar el sueño
**C)** CPAP nasal nocturno más baja de peso
**D)** Solo baja de peso y control en 6 meses
**E)** Modafinilo diurno en monoterapia

Respuesta C. IAH ≥ 30: SAHOS severo, con HTA refractaria y profesión de riesgo. El tratamiento de elección es CPAP nasal nocturno, siempre acompañado de baja de peso y sin sedantes. La baja de peso sola no basta en un SAHOS severo; los hipnóticos empeoran el colapso faríngeo.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 75 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 78 años, IMC: 32, presenta alteraciones de la memoria, desde hace 2 años, que han progresado, asociado a desconcentración e hipersomnia. ¿Cuál es el diagnóstico de elección para iniciar el estudio?

**A)** Electrocardiograma
**B)** Ecocardiograma
**C)** Polisomnografía
**D)** RMN de cerebro
**E)** TAC de cerebro

Respuesta C. Que tenga hipersomnia hace sospechar que haya un SAHOS, por lo que se debe estudiar con una polisomnografía.

## 1.05.1.034 Síndromes mediastínicos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

### QUÉ HAY QUE SABER

- Síndromes mediastínicos: compresión o invasión de estructuras del mediastino; causas según compartimento: anterior (timoma, teratoma, linfoma, tiroides «4 T»), medio (adenopatías, quistes), posterior (neurogénicos).
- Síndrome de vena cava superior: edema facial y de brazos que empeora al agacharse, plétora, ingurgitación yugular sin pulso, circulación colateral torácica; causa más frecuente: cáncer pulmonar microcítico y linfoma.

- Otros: disfonía por parálisis recurrencial, disfagia, Horner, estridor, parálisis frénica.
- Estudio: radiografía (ensanchamiento mediastínico), TAC de tórax con contraste y diagnóstico histológico antes de tratar; la radioterapia o corticoides empíricos pueden arruinar la biopsia.
- Estridor, edema cerebral o compromiso de conciencia: emergencia (stent endovascular). Seguimiento: derivar a especialista.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 63 años, fumador de 50 paquetes-año, con 3 semanas de edema facial y de ambos brazos que empeora al agacharse, disnea leve y cefalea matinal. Ingurgitación yugular sin pulso y circulación colateral en la pared torácica anterior. Sin estridor ni compromiso de conciencia. Radiografía: ensanchamiento mediastínico superior derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Radioterapia de urgencia antes de cualquier estudio
**B)** Esternotomía exploradora de urgencia
**C)** Corticoides en altas dosis y alta
**D)** Trombólisis sistémica
**E)** TAC de tórax con contraste y obtener diagnóstico histológico antes de tratar

Respuesta E. Síndrome de vena cava superior subagudo, sin estridor ni edema cerebral: no es una emergencia que impida estudiar. Se hace TAC con contraste y se obtiene histología (broncoscopía, biopsia de adenopatía) antes de tratar, porque linfoma y cáncer microcítico se tratan con quimioterapia. La radioterapia empírica arruina la biopsia.

## 1.05.1.035 Tos crónica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Tos crónica: duración >8 semanas en adultos. Lo primero: radiografía de tórax, preguntar por tabaco e IECA.
- Con radiografía normal en no fumador, las causas principales son goteo postnasal (rinosinusitis), asma (incluida la variante tos) y reflujo gastroesofágico.
- IECA (enalapril): tos seca en 5-20% por bradicinina; cambiar a ARA II (losartán) y la tos cede en 1-4 semanas.
- Estudio dirigido: espirometría con BD o metacolina si sospecha de asma; tratamiento empírico secuencial según la clínica (corticoide/antihistamínico nasal, CI, IBP).
- Banderas rojas: hemoptisis, baja de peso, fiebre, fumador >40 años o radiografía anormal: descartar cáncer y TBC (baciloscopías).
- Seguimiento completo en APS con reevaluación de la respuesta al tratamiento empírico; derivar si persiste pese al manejo.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 58 años, no fumadora, consulta por tos seca persistente de 3 meses. Hace 4 meses inició enalapril por hipertensión arterial. Su radiografía de tórax es normal y no tiene síntomas de reflujo, rinitis ni sibilancias. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Iniciar omeprazol empírico
**B)** Solicitar TAC de tórax
**C)** Iniciar un corticoide inhalado
**D)** Suspender el enalapril y cambiar a un ARA II (como losartán)
**E)** Iniciar codeína a permanencia

Respuesta D. La tos crónica (más de 8 semanas) en no fumadores con radiografía normal se debe principalmente a goteo postnasal, asma y reflujo, pero siempre debe descartarse el uso de IECA, que causa tos seca en 5 a 20% de los usuarios por acumulación de bradicinina. Se cambia a un ARA II y la tos cede en 1 a 4 semanas.

## 1.05.1.036 Tuberculosis pulmonar

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR · Tema 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Sintomático respiratorio: tos con expectoración ≥2 semanas (15 días); se estudia de inmediato con GeneXpert MTB/RIF (examen inicial), 2 baciloscopías (una inmediata y otra matinal) y cultivo de Koch en todas las muestras.
- Clínica: tos, hemoptisis, fiebre vespertina, sudoración nocturna, baja de peso; radiografía con infiltrados o cavidades en lóbulos superiores. La baciloscopía negativa no descarta.
- Esquema primario (GES, gratuito, tratamiento directamente observado): 2 RHZE diario (50 dosis) + 4 RH; 6 meses. Dosis: R 10 mg/kg (máx. 600), H 5 mg/kg (máx. 300), Z 25 mg/kg, E 15-20 mg/kg.
- Reacciones: R orina anaranjada (benigno, inductor CYP450); H neuropatía (piridoxina 25-50 mg/día); Z la más hepatotóxica e hiperuricemia; E neuritis óptica con alteración rojo-verde (suspender ya).
- Hepatotoxicidad: suspender si transaminasas >5× LSN o >3× con síntomas.
- Seguimiento completo: baciloscopía mensual, notificación obligatoria y estudio de contactos; terapia preventiva en contactos <5 años o VIH.

**PREGUNTAS (3)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 48 años, en su 5.ª semana de tratamiento 2RHZE, consulta por visión borrosa bilateral y dificultad para distinguir las luces del semáforo. Agudeza visual 20/60 bilateral, test de Ishihara muy alterado para verde y rojo. Fondo de ojo normal. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

**A)** Suspender de inmediato y en forma definitiva el etambutol
**B)** Agregar piridoxina y mantener el esquema
**C)** Suspender la rifampicina por su efecto sobre las secreciones
**D)** Mantener el esquema y controlar en un mes
**E)** Reducir la dosis de isoniazida a la mitad

Respuesta A. Neuritis óptica retrobulbar por etambutol: pérdida de agudeza visual y de la discriminación rojo-verde con fondo de ojo normal. Se suspende de inmediato y en forma definitiva; si se suspende precozmente suele ser reversible, y si se continúa la ceguera puede ser permanente.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 38 años con TBC pulmonar (baciloscopía +++, GeneXpert sin resistencia a rifampicina) en tratamiento observado con RHZE diario. A las 3 semanas consulta por orina de color anaranjado brillante y parestesias dolorosas en los dedos de ambos pies. Pruebas hepáticas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Suspender la rifampicina por nefrotoxicidad
**B)** Suspender todo el esquema hasta evaluar por neurología
**C)** Agregar piridoxina 25–50 mg/día y mantener el esquema
**D)** Suspender el etambutol de inmediato
**E)** Cambiar la isoniazida por ciprofloxacino

Respuesta C. La orina anaranjada es un efecto benigno y esperado de la rifampicina. Las parestesias distales son neuropatía por isoniazida (déficit de piridoxina): se agrega vitamina B6 25–50 mg/día y se mantiene el tratamiento, ya que las pruebas hepáticas son normales.

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 152 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 42 años consulta por tos de un mes de evolución, sin expectoración. Su esposa está en tratamiento antituberculoso. Su examen físico muestra crépitos escasos bilaterales. Se realizaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; quantiferón para tuberculosis, que resulta positivo; y radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): La conducta más adecuada es:

**A)** Iniciar profilaxis antituberculosa
**B)** Solicitar reacción de cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
**C)** Iniciar tratamiento antibiótico antituberculoso
**D)** Solicitar cultivo de Koch
**E)** Solicitar PPD

Respuesta C. Es un paciente contacto estrecho y sintomático, que, además, ya tiene una prueba positiva para tuberculosis (el quatiferón). Por tanto, aunque tenga las baciloscopías negativas se debe iniciar el tratamiento y no es necesario pedir la PCR.

## 1.05.1.037 Tuberculosis pulmonar (fracaso de tratamiento)

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

### QUÉ HAY QUE SABER

- Fracaso de tratamiento: baciloscopías que persisten positivas o se repositivizan desde el 4.º mes de tratamiento, habiéndose negativizado (ej. negativas mes 2-3, positivas mes 4-5).
- Diferenciar de recaída (reaparece tras terminar el tratamiento y quedar curado) y de abandono; revisar adherencia y absorción.
- Confirmar con cultivo y test de susceptibilidad, más prueba molecular de resistencia (GeneXpert: rifampicina).
- Nunca agregar un solo fármaco a un esquema que falla ni prolongar el mismo esquema: genera multirresistencia.
- Seguimiento: derivar al especialista del Programa de Control de TBC para esquema secundario según antibiograma; mantener aislamiento respiratorio y estudio de contactos.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Mujer de 40 años en tratamiento antituberculoso supervisado, con buena adherencia documentada. Sus baciloscopías de control fueron negativas en el 2.º y 3.º mes, pero vuelven a ser positivas en el 4.º y 5.º mes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Solicitar cultivo con estudio de susceptibilidad y prueba molecular de resistencia, y derivar al especialista del programa
**B)** Prolongar el mismo esquema por 3 meses más
**C)** Agregar levofloxacino al esquema actual
**D)** Suspender el tratamiento y repetir las baciloscopías en un mes
**E)** Cambiar a isoniazida en monoterapia

Respuesta A. Baciloscopías que se repositivizan después de negativizarse, desde el 4.º mes, definen fracaso de tratamiento y hacen sospechar resistencia. Se solicita cultivo con test de susceptibilidad y prueba molecular, y el caso lo maneja el especialista del Programa de Tuberculosis. Nunca se agrega un solo fármaco a un esquema que falla: genera más resistencia.

## 1.05.1.038 Nódulos pulmonares

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

### QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulo pulmonar: opacidad única, redonda u oval, ≤30 mm, rodeada de pulmón normal, sin atelectasia ni adenopatías; >3 cm es masa (maligna hasta demostrar lo contrario).
- Primer paso: buscar imágenes previas; si es estable ≥2 años, es benigno. Sin previas, TAC de tórax de cortes finos.
- Benignidad: <6 mm, bordes lisos, calcificación central, concéntrica, difusa o en «popcorn» (hamartoma). Malignidad: >8-10 mm, espiculado, vidrio esmerilado parcial, calcio excéntrico, lóbulo superior, fumador >50 años.
- Conducta (Fleischner): <6 mm bajo riesgo sin control; 6-8 mm TAC a los 6-12 y 18-24 meses; >8 mm según probabilidad: intermedia PET-CT, alta biopsia o resección por VATS.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar los nódulos >8 mm, en crecimiento o sospechosos.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 139**

Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente: [radiografía: nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho]. **La conducta más adecuada en este caso es:**

**A)** Solicitar TAC de tórax
**B)** Realizar punción transpleural
**C)** Instalar tubo pleural con trampa de agua
**D)** Realizar toracocentesis diagnóstica
**E)** Realizar broncoscopía rígida

Respuesta A. La radiografía mostraba un nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho. Sin radiografías previas que revisar, el primer examen es la TAC de tórax; la biopsia viene después. Si hubiese tenido radiografías previas, lo primero habría sido compararlas.

## Situaciones clínicas de urgencia 14 códigos

### 1.05.2.001 Asfixia por inmersión

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: resp-25

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Ahogamiento: deterioro respiratorio por inmersión en líquido; la hipoxia es el mecanismo central, por aspiración o laringoespasmo. Más frecuente en niños pequeños (piscinas) y adolescentes varones (alcohol, ríos, mar).
- Rescate y RCP: la prioridad es oxigenar; iniciar con 5 ventilaciones de rescate y luego RCP estándar 30:2. No intentar drenar el agua de los pulmones ni hacer Heimlich (retrasa la ventilación y favorece el vómito).
- Inmovilización cervical solo si hay sospecha de trauma (zambullida en aguas poco profundas, caída de altura, signos de lesión).
- Hipotermia asociada: retirar ropa mojada, recalentar y prolongar la reanimación; no se declara muerte hasta recalentar al paciente.
- Oxígeno al 100%, gases arteriales y radiografía de tórax; observar al menos 6-8 horas aun asintomático, por riesgo de edema pulmonar no cardiogénico (SDRA) tardío; hospitalizar si hay síntomas, desaturación o crépitos.
- Prevención: supervisión continua de niños, cercado de piscinas, chaleco salvavidas y evitar alcohol al bañarse.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un niño de 6 años es rescatado de una piscina tras estar sumergido unos 3 minutos. No responde, no respira y no se palpa pulso. Hay 2 rescatadores capacitados. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

**A)** Iniciar RCP comenzando con ventilaciones de rescate y continuar con compresiones, en relación 15:2
**B)** Realizar la maniobra de Heimlich para expulsar el agua
**C)** Colocar al niño boca abajo para drenar el agua
**D)** Esperar la llegada de la ambulancia sin intervenir
**E)** Realizar solo compresiones, sin ventilaciones

Respuesta A. En el ahogamiento el paro es por hipoxia, por lo que la ventilación es prioritaria: se inicia la RCP con ventilaciones de rescate y luego compresiones; con 2 rescatadores en niños la relación es 15:2. No se intenta drenar agua (Heimlich, posiciones), porque retrasa la RCP y aumenta el riesgo de aspiración.

### 1.05.2.002 Aspiración de cuerpo extraño con asfixia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Obstrucción completa por cuerpo extraño: atoro súbito comiendo o jugando, no puede toser, hablar ni llorar, con cianosis; signo universal de asfixia (manos al cuello). Típico niño de 1-3 años (frutos secos, uvas, salchicha) y adulto con carne.
- Si tose con fuerza (obstrucción parcial): no interferir, dejarlo toser y trasladar con oxígeno.
- Menor de 1 año: 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas, alternando. Heimlich contraindicado (lesión hepática o esplénica).
- Mayor de 1 año y adulto consciente: compresiones abdominales subdiafragmáticas (Heimlich) hasta expulsar el objeto o perder la conciencia; en embarazadas y obesos, compresiones torácicas.
- Si pierde la conciencia: activar emergencias e iniciar RCP con compresiones torácicas; mirar la boca antes de ventilar y retirar el objeto solo si es visible. Nunca barrido digital a ciegas.
- Tras la desobstrucción: evaluar complicaciones y descartar cuerpo extraño residual; broncoscopía si persisten síntomas.

**PREGUNTAS (1)**

Pregunta de práctica

Un hombre de 50 años se atraganta con un trozo de carne en un restaurante. Se toma el cuello, no puede hablar ni toser y está cianótico. Tras varias compresiones abdominales, pierde la conciencia y cae al suelo. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

**A)** Continuar las compresiones abdominales en el suelo
**B)** Darle agua para desatascar
**C)** Realizar barrido digital a ciegas
**D)** Esperar a que recupere la conciencia
**E)** Activar el sistema de emergencia e iniciar RCP con compresiones torácicas, revisando la boca antes de ventilar

Respuesta E. En la obstrucción completa de vía aérea con paciente consciente se hacen compresiones abdominales. Si pierde la conciencia, se activa la emergencia y se inicia RCP con compresiones torácicas, que también ayudan a expulsar el cuerpo extraño. Antes de ventilar se mira la boca y se retira el objeto solo si es visible; el barrido digital a ciegas está contraindicado.

## 1.05.2.003 Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

### QUÉ HAY QUE SABER

- Aspiración sin asfixia (obstrucción parcial): episodio súbito de tos y ahogo (síndrome de penetración) comiendo maní u otros, y luego el niño respira, tose en forma efectiva y llora.
- Conducta: no hacer maniobras de desobstrucción (pueden volverla completa); dejarlo toser en la posición que prefiera y trasladar con oxígeno.
- El objeto suele ir al bronquio derecho (más ancho y vertical): sibilancias o murmullo disminuido unilateral, atelectasia (lóbulo medio) o hiperinsuflación por efecto valvular.
- Radiografía en inspiración y espiración (atrapamiento aéreo); la mayoría de los objetos son radiolúcidos, una radiografía normal no descarta.
- Fase tardía: tos persistente o neumonía recurrente en el mismo sitio y sibilancias unilaterales que no ceden con salbutamol.
- Seguimiento: derivar para broncoscopía rígida bajo anestesia general, diagnóstica y terapéutica.

### PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 2 años, mientras comía maní, presentó un episodio súbito de tos intensa y ahogo. Ahora está consciente, rosado, tose en forma efectiva y llora. A la auscultación hay disminución del murmullo pulmonar y sibilancias en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Realizar la maniobra de Heimlich de inmediato
**B)** No interferir con su tos y derivar para broncoscopía rígida
**C)** Dar golpes interescapulares
**D)** Realizar barrido digital
**E)** Indicar salbutamol y control ambulatorio

Respuesta B. Si el niño respira y tose en forma efectiva, la obstrucción es parcial: no se hacen maniobras de desobstrucción, que podrían volverla completa. Se le deja toser, en la posición que prefiera, y se traslada con oxígeno. El síndrome de penetración con signos unilaterales obliga a broncoscopía rígida, diagnóstica y terapéutica. El salbutamol no resuelve un cuerpo extraño.

## 1.05.2.004 Crisis de asma bronquial

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Crisis Asmática en el Adulto

### QUÉ HAY QUE SABER

- Severidad: leve-moderada habla en oraciones, FC 100-120, FR <25, SatO2 90-95%, PEF 50-70%. Grave: habla en palabras, FC >120, FR >30, PEF <50%, musculatura accesoria (basta un criterio).
- Riesgo vital: tórax silente, bradicardia, confusión, cianosis, movimiento paradójico. PaCO2 «normal» (38-42) en crisis grave indica agotamiento inminente.

- Primera hora: oxígeno a SatO2 93-95%; salbutamol 4-8 puff con aerocámara c/20 min (+ ipratropio en moderada-grave); prednisona 40-50 mg VO precoz (hidrocortisona 200 mg EV si no tolera VO).
- Reevaluar a los 60 min con clínica y PEF: >70% y SatO2 >93% permite el alta; refractaria (PEF <50%): sulfato de magnesio 2 g EV en 20 min; sopor o PaCO2 >50: intubación (ketamina). No aminofilina ni antibióticos de rutina.
- Alta: prednisona 40 mg/día por 5-7 días sin descenso, iniciar o escalar corticoide inhalado, SABA de rescate, plan de acción escrito.
- Seguimiento: control en ≤7 días hábiles en APS para ajustar la terapia de mantención.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 179**

Un paciente de 25 años, con antecedente de asma en tratamiento con fluticasona, un puff cada 12 horas, y salbutamol SOS, consulta por un cuadro de disnea que inició hace 48 horas en relación a un cuadro respiratorio alto y que ha ido empeorando, presentando actualmente disnea de mínimos esfuerzos que no ha respondido al uso de salbutamol. Al examen físico se observa taquipneico, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, frecuencia respiratoria de 35 por minuto, saturación de oxígeno 95% y frases con palabras entrecortadas. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para precisar la severidad del cuadro?**

**A)** Radiografía de tórax
**B)** Test de metacolina
**C)** Flujo espiratorio máximo (PEF)
**D)** Hemograma y VHS
**E)** Gases en sangre venosa

Respuesta C. La severidad de la crisis se define con la clínica y el PEF, que objetiva la obstrucción y permite seguir la respuesta al tratamiento. Los gases útiles son los arteriales, no los venosos, y se piden en la crisis grave o sin respuesta. La metacolina provoca broncoespasmo: está contraindicada en crisis.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 22 años, asmática desde la infancia con tratamiento irregular, consulta en el SAPU por 4 horas de disnea intensa, tos y sibilancias. FR 32/min, FC 128/min, SatO2 89% ambiental. Habla solo con monosílabos entrecortados, tiraje intercostal y supraclavicular. PEF 160 L/min (38% del predicho). Sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

**A)** Oxígeno, salbutamol con ipratropio cada 20 min y prednisona 40–50 mg VO
**B)** Sulfato de magnesio 2 g EV como primera medida
**C)** Aminofilina EV en carga y mantención
**D)** Nebulizar con salbutamol y diferir el corticoide hasta evaluar respuesta
**E)** Amoxicilina-ácido clavulánico y salbutamol a demanda

Respuesta A. Crisis grave: habla en monosílabos, FC > 120, FR > 30, musculatura accesoria y PEF < 50%. Conducta: oxígeno a SatO2 93–95%, salbutamol 4–8 puff + ipratropio con aerocámara cada 20 minutos en la primera hora y corticoide sistémico precoz. Reevaluar a los 60 minutos; el magnesio es el rescate si no responde.

## 1.05.2.005 Embolia pulmonar masiva

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.5 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP) · Tema 4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

**QUÉ HAY QUE SABER**

- TEP masivo (alto riesgo): shock o PAS <90 mmHg por >15 min, síncope o paro, en paciente con factores de Virchow; mortalidad >15-30%.
- Clínica: disnea súbita intensa, hipoxemia, taquicardia, ingurgitación yugular por falla aguda del VD; ECG con taquicardia sinusal, S1Q3T3 o bloqueo de rama derecha.
- Paciente demasiado inestable para trasladar: ecocardiograma en la cama (VD dilatado e hipocinético); si se puede trasladar, angioTAC. El dímero D no tiene rol.
- Tratamiento inicial: oxígeno, heparina no fraccionada EV y trombólisis sistémica (alteplasa 100 mg EV en 2 h; en paro inminente 0,6 mg/kg en 15 min). Volumen cauteloso (el exceso agrava el VD); vasopresores si persiste hipotensión.
- Contraindicación absoluta de trombólisis (ACV hemorrágico, ACV isquémico <6 meses, sangrado activo, TEC reciente): embolectomía quirúrgica o por catéter.

- Seguimiento: derivar a UCI y luego anticoagulación por especialista.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 99**

Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral. Desde hace 2 meses está en quimioterapia por cáncer de colon. Hoy presenta un síncope luego de levantarse de la cama y se asocia a disnea y dolor torácico. Su FC: 120x', PA: 90/50 mmHg, FR: 32x' y saturación de oxígeno: 93%. Su examen pulmonar es inespecífico. Se solicita electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama derecha, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?**

**A)** Radiografía de tórax
**B)** TAC de tórax
**C)** Dímero D
**D)** Ecocardiograma
**E)** AngioTAC de tórax

Respuesta D. Cáncer en quimioterapia, síncope, taquicardia, hipotensión y bloqueo de rama derecha: TEP con compromiso hemodinámico. En el paciente inestable, el ecocardiograma en la cama demuestra la disfunción del ventrículo derecho sin trasladarlo; el angioTAC es de elección en el TEP estable.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 8**

Un paciente de 60 años, fumador de 20 paquetes-año y con antecedente de trombosis venosa profunda hace 10 años, presenta un cuadro de disnea y malestar general de 7 días de evolución, que empeoró súbitamente hace unas horas, presentando un síncope con recuperación posterior. Al examen físico destaca presión arterial 70/40 mmHg, frecuencia cardíaca 150 lpm, frecuencia respiratoria 40 rpm y saturación de oxígeno de 86%. Se observa ingurgitación yugular y se constata que está desorientado. Se solicita un electrocardiograma, que muestra una taquicardia sinusal y se realiza un AngioTAC, que muestra defectos de llenado en ambas arterias pulmonares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Trombólisis con tenecteplase
**B)** Trombólisis con estreptoquinasa
**C)** Heparina endovenosa
**D)** Trombectomía abierta quirúrgica
**E)** Trombectomía intraarterial con catéter

Respuesta A. TEP bilateral con PA 70/40, síncope y compromiso de conciencia: TEP de alto riesgo. El tratamiento de elección es la trombólisis sistémica con un trombolítico moderno. La heparina sola no basta y la trombectomía queda para cuando la trombólisis está contraindicada.

## 1.05.2.006 Enfermedad bronquial obstructiva crónica descompensada

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Exacerbación de EPOC: empeoramiento agudo de síntomas en <14 días; 75-80% infecciosa (H. influenzae, neumococo, Moraxella). Anthonisen: más disnea, más volumen y esputo purulento.
- Antibiótico si tiene los 3 criterios, o 2 incluyendo purulencia, o requiere ventilación: amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/12 h por 5-7 días (alternativas azitromicina o cefuroximo).
- Broncodilatación: salbutamol + ipratropio 4-8 puff con aerocámara c/20-30 min por 2 h, luego c/2-4 h; prednisona 40 mg/día por 5 días exactos, sin descenso.
- Oxígeno controlado: meta SatO2 88-92% con cánula 1-2 L/min o Venturi 24-28%; nunca reservorio a alto flujo (narcosis hipercápnica).
- Gases arteriales en la exacerbación moderada-grave: pH <7,35 con PaCO2 >45 indica VMNI (BiPAP); intubar si Glasgow <8, shock, vómitos o falla de la VMNI.
- Seguimiento completo: leve ambulatoria; al alta revisar técnica inhalatoria, escalar terapia de mantención (LAMA + LABA), vacunas, rehabilitación y control precoz.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 159**

Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x', PA: 110/76 mmHg, FC: 110x' y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesoria, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo antibióticos y nebulizaciones con broncodilatadores por una hora, sin mejoría clínica. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaCO2: 62 mmHg, PaO2: 56 mmHg, pH: 7,29 y HCO3: 27 mEq/L. **La conducta más adecuada, a continuación, es:**

**A)** Ventilación mecánica invasiva
**B)** Aminofilina endovenosa
**C)** Oxígeno por cánula nasal de alto flujo
**D)** Ventilación no invasiva
**E)** Bicarbonato de sodio endovenoso

Respuesta D. EPOC descompensado con acidosis respiratoria hipercápnica (pH 7,29, PaCO2 62) pese al tratamiento inicial. Está vigil y orientado, sin contraindicaciones: ventilación no invasiva. La invasiva se reserva para el compromiso de conciencia o el fracaso de la VMNI.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 70 años, EPOC por tabaquismo (40 paq/año), con 48 horas de aumento de disnea hasta mínimos esfuerzos, más volumen de esputo y secreciones verdes y espesas. FR 28 rpm, FC 102 lpm, PA 135/85 mmHg, SatO2 86% ambiental. Murmullo pulmonar disminuido, espiración prolongada, roncus y sibilancias difusas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

**A)** O2 por mascarilla con reservorio, salbutamol y prednisona 40 mg por 14 días con descenso
**B)** O2 por cánula con meta 88–92%, salbutamol + ipratropio, prednisona 40 mg por 5 días y amoxicilina/clavulánico
**C)** O2 por cánula con meta 88–92%, salbutamol + ipratropio y prednisona 40 mg por 5 días, sin antibiótico
**D)** Intubación orotraqueal inmediata y ventilación mecánica invasiva
**E)** Aminofilina endovenosa y ciprofloxacino oral

Respuesta B. Tiene los 3 criterios de Anthonisen (disnea, volumen y purulencia): tipo 1, lleva antibiótico (amoxicilina/clavulánico 875/125 c/12 h por 5–7 días). Además: O2 controlado con meta 88–92%, SABA + SAMA y prednisona 40 mg por 5 días. Se piden gases para buscar acidosis e indicar VMNI si corresponde.

## 1.05.2.007 Hemoptisis moderada,severa y masiva

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

### QUÉ HAY QUE SABER

- Hemoptisis amenazante (masiva): >150-200 mL en 1 h o >500-600 mL en 24 h, o cualquier volumen que comprometa vía aérea, oxigenación o hemodinamia.
- Se muere por asfixia, no por shock: 90% proviene de arterias bronquiales (alta presión). Causas: bronquiectasias, TBC y secuelas, cáncer, aspergiloma.
- Primera medida: decúbito lateral sobre el lado que sangra (protege el pulmón sano), oxígeno, vía venosa, hemograma, coagulación y grupo; nunca Trendelenburg ni lado sano abajo.
- Si compromete la vía aérea: intubación con tubo grueso ≥8,0-8,5 mm para aspirar y permitir broncoscopía.
- Seguimiento: derivar urgente; angioTAC y broncoscopía localizan el sitio; embolización de arterias bronquiales (éxito >90%) y cirugía de resección si falla y es unilateral.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Mujer de 48 años con tos diaria y expectoración purulenta abundante desde la juventud y neumonías a repetición. Consulta por 200 mL de sangre roja rutilante con coágulos en 30 minutos. FR 28/min, FC 110 lpm, SatO2 89 % ambiental. Abundantes estertores húmedos y gorgoteo en el hemitórax izquierdo. **¿Cuál es la primera medida?**

**A)** Decúbito lateral izquierdo y oxígeno de alto flujo
**B)** Decúbito lateral derecho y oxígeno de alto flujo
**C)** Reposición con 2 litros de cristaloides
**D)** TACAR de tórax urgente
**E)** Cirugía de resección del lóbulo afectado

Respuesta A. Hemoptisis amenazante en bronquiectasias: la prioridad es evitar la asfixia. Decúbito lateral izquierdo (lado que sangra abajo) para proteger el pulmón derecho, oxígeno, reserva de hemoderivados y coordinar broncoscopía y embolización bronquial urgente.

**Pregunta de práctica**

Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. **¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?**

**A)** Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados
**B)** Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo
**C)** Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje
**D)** Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual
**E)** Posición genupectoral

Respuesta B. La causa principal de muerte es la asfixia. El decúbito lateral hacia el lado de la lesión (aquí, el derecho) mantiene la sangre en el pulmón afectado y evita que atraviese la carina e inunde el pulmón sano.

## 1.05.2.008 Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada que requiere ventilación mecánica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

### QUÉ HAY QUE SABER

- IRA o crónica reagudizada que requiere ventilación mecánica: Glasgow ≤8 o incapacidad de proteger la vía aérea, paro respiratorio o inminente, shock, agotamiento, hipoxemia refractaria o fracaso de la VMNI en 1-2 h.
- Diagnóstico gasométrico: PaO2 <60 mmHg; tipo 2 si PaCO2 >45. Fracaso de VMNI: empeoran pH y PaCO2, compromiso de conciencia, secreciones abundantes o vómitos.
- Manejo inicial: oxígeno, ventilación con bolsa-mascarilla (1 ventilación c/6 s si hay pulso), tratar causas reversibles (naloxona en opioides).
- Intubación con secuencia rápida; confirmar la posición con capnografía de onda continua y luego radiografía.
- Seguimiento: derivar a UCI para ventilación mecánica invasiva (en SDRA: Vt 6 mL/kg de peso ideal y plateau ≤30 cmH2O).

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 95**

Paciente de 55 años, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, es derivado desde servicio de urgencia rural por aumento de su disnea basal, asociado a sensación febril y luego confusión, al ingreso en nuestro centro se solicitan gases arteriales que muestran pH 7.3, PaCO2 80, PaO2 86 con FiO2 al 100%. En su examen físico destaca sopor superficial, murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, con sibilancias difusas y crepitaciones en base pulmonar izquierda. **La medida más adecuada en este momento es:**

**A)** Administrar hidrocortisona en bolo
**B)** Nebulizar con salbutamol
**C)** Administrar ceftriaxona
**D)** Intubar e iniciar ventilación mecánica
**E)** Disminuir el aporte de oxígeno a 24%

Respuesta D. EPOC exacerbado con hipercapnia severa (PaCO2 80) y encefalopatía hipercápnica (confusión, sopor). El compromiso de conciencia es criterio de escalar a intubación y ventilación mecánica invasiva: el paciente no protege su vía aérea y la VMNI no es segura. Bajar el oxígeno no revierte una narcosis ya instalada.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 30 años es traído a urgencias tras ser encontrado en su casa con compromiso de conciencia, junto a blísteres vacíos de un opioide. Glasgow 7, FR 6 rpm, pupilas mióticas puntiformes, murmullo pulmonar normal. Gases con aire ambiental: pH 7,24, PaO2 58 mmHg, PaCO2 64 mmHg, HCO3 26 mEq/L. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

**A)** Ventilación mecánica no invasiva con BiPAP
**B)** Ventilar con bolsa-mascarilla y administrar naloxona endovenosa
**C)** Oxígeno por cánula nasal a 2 L/min y observar
**D)** Bicarbonato de sodio endovenoso para corregir el pH
**E)** Solicitar angio-TAC de tórax por sospecha de TEP

Respuesta B. PAO2 = 150 – 64/0,8 = 70; gradiente = 70 – 58 = 12 mmHg (normal). IRA tipo 2 con gradiente normal: hipoventilación alveolar pura por opioides, con pulmón sano. Se ventila con bolsa-mascarilla y se revierte con naloxona. La VMNI no sirve en un paciente con Glasgow ≤ 8 que no protege su vía aérea.

## 1.05.2.009 Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada, que no requiere ventilación mecánica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

### QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg; tipo 1 hipoxémica (PaCO2 ≤45, gradiente A-a alto) o tipo 2 hipercápnica (PaCO2 >45; pH <7,35 si es aguda). Gradiente A-a = (150 – PaCO2/0,8) – PaO2.
- Mecanismos: alteración V/Q (NAC, EPOC, asma, TEP, el más frecuente), shunt (SDRA, edema; refractario al O2 100%), difusión, hipoventilación (opioides, neuromusculares; gradiente normal) y baja PiO2 (altura).
- Tipo 1: oxígeno a SatO2 92-96% con cánula 1-5 L/min (FiO2 24-40%), mascarilla o cánula nasal de alto flujo si PaFi <200.
- Retenedor de CO2 (EPOC): Venturi con FiO2 fija y meta 88-92%; el exceso de oxígeno empeora la hipercapnia.
- Acidosis hipercápnica (pH 7,25-7,35, PaCO2 >45) en EPOC exacerbado o edema pulmonar cardiogénico con paciente vigil: VMNI BiPAP (IPAP 10-15, EPAP 4-6 cmH2O) y reevaluar gases en 1-2 h.
- Tratar la causa (broncodilatadores, corticoides, antibióticos, diuréticos) y controlar con gases hasta la estabilización; al alta, controles en APS o con especialista según la causa.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una mujer de 72 años con EPOC grave presenta una exacerbación con disnea intensa, FR 30 por minuto y uso de musculatura accesoria. Está vigil y cooperadora. Gases arteriales: pH 7,28, PaCO2 68 mmHg, PaO2 50 mmHg, HCO3 31 mEq/L. **Además de broncodilatadores, corticoides y oxígeno controlado, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Intubación inmediata en todos los casos
**B)** Oxígeno con mascarilla de reservorio al 100%
**C)** Ventilación mecánica no invasiva (BiPAP)
**D)** Bicarbonato endovenoso
**E)** Sedación con benzodiacepinas

Respuesta C. La insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda sobre crónica con acidosis (pH bajo 7,35, PaCO2 sobre 45 mmHg) en una exacerbación de EPOC, con paciente vigil y cooperador, es la principal indicación de ventilación no invasiva: reduce intubación y mortalidad. El oxígeno se titula a 88-92%, porque al 100% empeora la hipercapnia. Se intuba si fracasa.

## 1.05.2.010 Intoxicación por monóxido de carbono

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

### QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicación por CO: brasero, calefón o incendio en espacio cerrado; varios afectados. Cefalea (lo más precoz), náuseas, mareo; en grave síncope, convulsiones, coma, arritmias o angina.
- El oxímetro de pulso marca falsamente normal: confirmar con carboxihemoglobina por co-oximetría (>3-5% no fumador, >10% fumador). El rojo cereza es raro y tardío.

- Tratamiento inmediato en todos: O2 al 100% con mascarilla de no recirculación a 15 L/min, ≥6 h (vida media de COHb: 320 min al aire → 80 min con O2 100% → 20-25 min hiperbárico).
- Cámara hiperbárica si COHb >25%, embarazada con COHb >15%, pérdida de conciencia o síncope, coma, convulsiones, déficit neurológico, isquemia miocárdica o pH <7,15.
- ECG y troponinas si hay síntomas cardíacos o factores de riesgo; evaluar a todos los expuestos y eliminar la fuente.
- Seguimiento: control por riesgo de síndrome neurológico tardío (semanas después: alteraciones cognitivas, parkinsonismo) y educación preventiva.

**PREGUNTAS (6)**

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 10**

Paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y opresión precordial, 3 horas después de estar expuesto a humo en un incendio en su casa. Frecuencia cardíaca 100 por minuto, presión arterial 130/85, frecuencia respiratoria 35, saturación de oxígeno 96 %. Sin cianosis, examen cardiopulmonar normal. **¿Qué examen confirma la sospecha diagnóstica?**

**A)** Radiografía de tórax
**B)** TAC de tórax
**C)** Niveles de carboxihemoglobina
**D)** Gases en sangre arterial
**E)** Monitorización transcutánea de anhídrido carbónico

Respuesta C. El cuadro corresponde a intoxicación por monóxido de carbono. La saturación de pulso es falsamente normal porque no distingue oxihemoglobina de carboxihemoglobina, y los gases arteriales tampoco alteran la presión de oxígeno. El examen que confirma el diagnóstico es la medición directa de carboxihemoglobina.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 41**

Paciente de 25 años, encontrada inconsciente en el baño de su casa. Glasgow 15, presión arterial 110/60, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 12, saturación de oxígeno 98 %. Examen cardiopulmonar normal. Carboxihemoglobina de 20 por ciento. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

**A)** Administrar oxígeno por naricera de alto flujo
**B)** Solicitar una TAC de cerebro
**C)** Realizar terapia hiperbárica
**D)** Administrar broncodilatadores por vía inhalada
**E)** Administrar oxígeno por mascarilla de no recirculación

Respuesta E. Confirmada la intoxicación por monóxido de carbono, el tratamiento inicial es oxígeno al cien por ciento con mascarilla de no recirculación, que acelera la eliminación del monóxido de la hemoglobina. La terapia hiperbárica se reserva para carboxihemoglobina sobre veinticinco por ciento o compromiso de conciencia importante, criterios que este caso no cumple.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 10**

Un paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y sensación de opresión precordial, 3 horas después de haber estado expuesto a humo durante un incendio en su casa. Al examen físico registra frecuencia cardíaca 100 lpm, presión arterial 130/85 mmHg, frecuencia respiratoria 35 rpm y saturación de oxígeno de 96%. No presenta cianosis ni uso de musculatura accesoria, y su examen cardiopulmonar es normal. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

**A)** Radiografía de tórax
**B)** TAC de tórax
**C)** Niveles de carboxihemoglobina
**D)** Gases en sangre arterial
**E)** Monitorización transcutánea de niveles de anhídrido carbónico

Respuesta C. Exposición a humo con cefalea, disnea y opresión precordial y saturación normal: sospecha de intoxicación por CO. El oxímetro de pulso marca falsamente normal y los gases convencionales suelen ser normales. El examen de elección es la carboxihemoglobina por co-oximetría.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 41**

Una paciente de 25 años fue encontrada inconsciente por su pareja en el baño de su casa, por lo que es llevada de inmediato al servicio de urgencias. Al examen físico, presenta escala de Glasgow: 15 puntos, tiene presión arterial: 110/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 115 lpm, frecuencia respiratoria: 12 rpm y saturación de oxígeno: 98%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 98 mg/dl y carboxihemoglobina: 20%. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

**A)** Administrar oxígeno por naricera de alto flujo
**B)** Solicitar una TAC de cerebro
**C)** Realizar terapia hiperbárica
**D)** Administrar broncodilatadores por vía inhalada
**E)** Administrar oxígeno por mascarilla de no recirculación

Respuesta E. Intoxicación por CO confirmada (COHb 20%) con saturación falsamente normal. La conducta inicial en todo paciente es O2 al 100% por mascarilla de no recirculación, que acelera la eliminación del CO. La pérdida de conciencia agrega indicación de oxígeno hiperbárico, pero eso viene después del oxígeno inmediato.

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 144**

Paciente encontrada en el baño, tenía carboxiHb de 12% tto de elección: **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

**A)** O2 mascarilla
**B)** Cámara hiperbarica
**C)** Ninguna de las anteriores es correcta
**D)** Todas las anteriores son correctas
**E)** No se dispone de información suficiente

Respuesta A. COHb 12%, bajo el corte de 25% y sin otra indicación descrita: el tratamiento es oxígeno al 100% por mascarilla con reservorio (normobárico). La cámara hiperbárica se reserva para sus indicaciones estrictas.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 29 años, embarazada de 26 semanas, es traída desde su casa donde tenía un brasero encendido en el dormitorio. Refiere cefalea intensa, náuseas y mareo. Consciente, sin focalidad neurológica. PA 118/72 mmHg, FC 96 lpm, SatO2 99% con oxímetro de pulso. Co-oximetría: COHb 17%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Alta con paracetamol, dado que la saturación es normal
**B)** O2 por naricera a 3 L/min y control de COHb en 24 horas
**C)** O2 al 100% con mascarilla con reservorio y derivar a oxígeno hiperbárico
**D)** O2 al 100% normobárico solamente, porque la COHb es menor de 25%
**E)** TAC de cerebro sin contraste antes de iniciar oxígeno

Respuesta C. Intoxicación por CO confirmada (COHb 17%) con saturación falsamente normal. En la embarazada el corte para oxígeno hiperbárico es COHb > 15%, porque la hemoglobina fetal concentra más CO. Se inicia O2 al 100% con reservorio de inmediato y se deriva a cámara hiperbárica.

## 1.05.2.011 Neumotórax hipertensivo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante · Tema 6.4 Trauma Abdominal y Torácico · Tema 3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

### QUÉ HAY QUE SABER

- Neumotórax a tensión: mecanismo de válvula; el aire entra y no sale, desplaza el mediastino, comprime las cavas y produce shock obstructivo y paro en AESP. Trauma o ventilación con presión positiva.
- Diagnóstico clínico, sin radiografía: shock, yugulares ingurgitadas, tráquea desviada al lado contrario, hemitórax timpánico con murmullo abolido.
- Descompresión inmediata con aguja 14-16 G en el 2.º EIC línea medioclavicular (alternativa ATLS: 5.º EIC línea axilar anterior), por el borde superior de la costilla inferior.
- Luego tubo pleural 28-32 Fr en el 5.º EIC entre líneas axilares anterior y media (triángulo de seguridad) a trampa de agua.
- Nunca intubar ni ventilar con presión positiva antes de descomprimir (precipita el paro).
- Diferenciar: hemotórax masivo (matidez, yugulares planas) y taponamiento (tríada de Beck, murmullo conservado). Seguimiento completo con control radiológico del tubo hasta reexpansión.

### PREGUNTAS (3)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 27 años recibe una patada en el hemitórax izquierdo durante una riña. Llega con disnea marcada, pálido y sudoroso. Presión arterial de 78/44, frecuencia cardíaca de 128. Al examen, el murmullo pulmonar está abolido a izquierda, con timpanismo a la percusión, ingurgitación yugular y la tráquea desviada hacia la derecha. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

**A)** Solicitar radiografía de tórax portátil antes de actuar
**B)** Descomprimir con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal izquierdo
**C)** Realizar ventana pericárdica subxifoidea
**D)** Iniciar transfusión de hemoderivados y observar
**E)** Solicitar TAC de tórax con contraste

Respuesta B. Timpanismo, murmullo abolido, ingurgitación yugular y desviación traqueal contralateral son el cuadro clínico completo del neumotórax a tensión. El diagnóstico es clínico y la conducta es descomprimir de inmediato, sin esperar ninguna imagen.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 25 años, motorista, tras un choque presenta disnea intensa. FR 36 por minuto, SatO2 82 %, PA 75/40 mmHg, FC 140 por minuto, ingurgitación yugular, tráquea desviada a la derecha, murmullo pulmonar abolido e hipersonoridad en el hemitórax izquierdo. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

**A)** Radiografía de tórax urgente para confirmar
**B)** TAC de tórax
**C)** Intubación y ventilación a presión positiva antes de descomprimir
**D)** Pericardiocentesis
**E)** Descompresión inmediata del hemitórax izquierdo con aguja o toracostomía digital, seguida de tubo pleural

Respuesta E. El neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico: shock, ingurgitación yugular, desviación traqueal contralateral, murmullo abolido e hipersonoridad. Se descomprime de inmediato, sin esperar imágenes, con aguja o toracostomía digital, y luego se instala tubo pleural. Ventilar a presión positiva antes de descomprimir lo agrava.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 25 años, motociclista, traído tras una caída a alta velocidad. Agitado, FR 36/min, SatO2 82 %, PA 70/40 mmHg, FC 140 lpm. Yugulares ingurgitadas, tráquea desviada a la izquierda, hemitórax derecho hiperinsuflado, timpánico y sin murmullo pulmonar. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

**A)** Radiografía de tórax portátil para confirmar el diagnóstico
**B)** Intubación orotraqueal y ventilación con presión positiva antes de cualquier otra medida
**C)** Pericardiocentesis subxifoidea
**D)** Descompresión inmediata con aguja en el hemitórax derecho y luego tubo pleural
**E)** Tubo pleural en el hemitórax izquierdo

Respuesta D. Shock obstructivo con yugulares ingurgitadas, tráquea desviada al lado contrario y hemitórax timpánico sin murmullo: neumotórax a tensión. Es un diagnóstico clínico y se descomprime de inmediato con aguja (2.º espacio intercostal en la línea medioclavicular, o 5.º en la axilar), seguido de tubo pleural. La radiografía no debe retrasarlo.

## 1.05.2.012 Paro cardiorespiratorio

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

### QUÉ HAY QUE SABER

- Paro cardiorrespiratorio: paciente que no responde, sin respiración normal (o solo jadeos) y sin pulso palpable en ≤10 s; activar el sistema de emergencia y pedir el DEA.
- RCP de alta calidad: compresiones a 100-120/min, 5-6 cm de profundidad, permitir reexpansión completa, mínimas interrupciones; 30:2 sin vía aérea avanzada (con ella, 1 ventilación c/6 s continua).
- Ritmos desfibrilables (FV y TV sin pulso): descarga inmediata (bifásico 120-200 J), retomar compresiones 2 min; adrenalina 1 mg EV/IO tras la 2.ª descarga y c/3-5 min; amiodarona 300 mg tras la 3.ª (luego 150 mg).
- No desfibrilables (asistolia, AESP): RCP + adrenalina 1 mg lo antes posible y c/3-5 min; no desfibrilar.
- Buscar y tratar causas reversibles (5 H y 5 T): hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis coronaria y pulmonar.
- Tras recuperar la circulación: vía aérea, SatO2 92-98%, PAS >90, ECG de 12 derivaciones, control de temperatura; derivar a UCI.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 58 años colapsa en la sala de espera. No responde y no respira normalmente. Se activa el código de paro y se inicia RCP. Al conectar el monitor desfibrilador se observa fibrilación ventricular. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

**A)** Administrar adrenalina 1 mg antes de cualquier descarga
**B)** Verificar el pulso durante 1 minuto
**C)** Intubar antes de desfibrilar
**D)** Administrar amiodarona y esperar su efecto
**E)** Desfibrilar de inmediato y reanudar las compresiones por 2 minutos sin verificar pulso

Respuesta E. La fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable: se desfibrila lo antes posible y se reanudan de inmediato las compresiones de alta calidad por 2 minutos antes de reevaluar el ritmo. La adrenalina se administra después de la segunda descarga y la amiodarona después de la tercera. Intubar o buscar pulso por mucho tiempo retrasa la descarga y reduce la sobrevida.

## 1.05.2.013 Traumatismo torácico grave

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

### QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones torácicas que matan primero (revisión primaria ATLS): neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax volante con contusión pulmonar y taponamiento cardíaco.
- Shock + yugulares ingurgitadas + timpanismo + tráquea desviada: neumotórax a tensión, descomprimir con aguja sin radiografía. Neumotórax abierto: parche fijado en 3 lados y luego tubo pleural.
- Hemotórax masivo (≥1.500 mL): shock con yugulares planas y matidez; tubo pleural 28-32 Fr + hemoderivados 1:1:1. Toracotomía si débito inicial ≥1.500 mL o >200 mL/h por 2-4 h.
- Tórax volante (≥3 costillas fracturadas en 2 segmentos): movimiento paradójico; la hipoxia es por la contusión pulmonar: oxígeno, analgesia potente y restricción de fluidos.
- Taponamiento: tríada de Beck con murmullo conservado; eco-FAST y pericardiocentesis o ventana pericárdica.
- Nunca ventilar con presión positiva sin descomprimir un neumotórax a tensión. Seguimiento: derivar a cirugía/UCI.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Mujer de 30 años, conductora sin cinturón, ingresa tras colisión frontal. Pálida, sudorosa, confusa. PA 78/48 mmHg, FC 124/min, FR 28/min. Yugulares colapsadas. Dolor a la palpación de arcos costales izquierdos, matidez en los dos tercios inferiores del hemitórax izquierdo y ausencia de ruidos respiratorios. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial?**

**A)** Neumotórax a tensión; punción con aguja en el 2.º espacio intercostal
**B)** Taponamiento cardíaco; pericardiocentesis subxifoidea
**C)** Hemotórax masivo; tubo pleural grueso y hemoderivados
**D)** Contusión pulmonar; nebulización y analgesia oral
**E)** Radiografía de tórax antes de decidir

Respuesta C. Shock con yugulares planas + matidez + murmullo abolido en el hemitórax traumatizado: hemotórax masivo. Conducta: tubo pleural 28–32 Fr y resucitación con hemoderivados 1:1:1. El neumotórax a tensión tendría timpanismo y yugulares ingurgitadas; el taponamiento, yugulares ingurgitadas y percusión normal.

## 1.05.2.014 Traumatismo torácico simple

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

### QUÉ HAY QUE SABER

- Traumatismo torácico simple: contusión o fractura costal única sin neumotórax, hemotórax, tórax volante ni compromiso hemodinámico o respiratorio.
- Evaluación: signos vitales, SatO2, murmullo simétrico; radiografía de tórax para descartar neumotórax, hemotórax y fracturas múltiples.

- Tratamiento ambulatorio: analgesia efectiva (paracetamol, AINE, opioide débil si es necesario) y ejercicios respiratorios para toser y respirar profundo, evitando atelectasia y neumonía.
- El vendaje torácico compresivo está contraindicado: restringe la ventilación.
- Riesgo mayor en ancianos y fracturas múltiples (≥3), de 1.ª-2.ª costilla (trauma de alta energía) o bajas (lesión hepática o esplénica): observar u hospitalizar.
- Seguimiento completo: control ambulatorio y signos de alarma (disnea, fiebre, dolor que aumenta, hemoptisis); el dolor cede en 3-6 semanas.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 45 años cae de su altura y se golpea el hemitórax derecho. Consulta por dolor al respirar. Está hemodinámicamente estable, con saturación de 97% y murmullo pulmonar simétrico. La radiografía muestra fractura no desplazada del 7° arco costal derecho, sin neumotórax ni hemotórax. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

**A)** Instalación de tubo pleural
**B)** Vendaje torácico compresivo
**C)** Analgesia adecuada, ejercicios respiratorios y control ambulatorio con signos de alarma
**D)** Fijación quirúrgica de la costilla
**E)** Hospitalización en UCI

Respuesta C. Una fractura costal única sin complicaciones (neumotórax, hemotórax, tórax volante) en un paciente estable es un traumatismo torácico simple. Se maneja en forma ambulatoria con analgesia efectiva, que permite respirar profundo y toser, previniendo atelectasias y neumonía. El vendaje compresivo está contraindicado porque restringe la ventilación.

## Conocimientos generales 5 códigos

### 1.05.3.001 Contaminación ambiental

Dónde se enseña: Tema 5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Contaminantes principales: material particulado fino (MP2,5) y grueso (MP10), ozono, NO2, SO2 y CO; en el centro-sur de Chile la principal fuente invernal es la combustión residencial de leña.
- Efectos: aumento de consultas y hospitalizaciones por IRA, crisis de asma y exacerbaciones de EPOC, mortalidad cardiovascular y respiratoria; mayor riesgo en niños, adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos.
- Gestión de episodios críticos (alerta, preemergencia, emergencia) según MP2,5: restricción vehicular, prohibición de calefactores a leña y de quemas, suspensión de actividad física al aire libre.
- Planes de descontaminación atmosférica: recambio de calefactores, leña seca certificada, aislación térmica de viviendas, transporte limpio.
- Consejería individual: evitar ejercicio al aire libre en episodios críticos, ventilar la vivienda, no fumar intradomiciliario, adherir a la terapia de mantención en asma/EPOC y vacunarse contra influenza y neumococo.
- Contaminación intradomiciliaria: humo de leña o biomasa (EPOC en mujeres no fumadoras), tabaco ambiental y CO por braseros y calefones mal ventilados.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Durante el invierno se decreta preemergencia ambiental en Santiago por niveles elevados de material particulado fino (MP2,5). La madre de un niño asmático de 8 años consulta qué medidas tomar. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

**A)** Evitar la actividad física intensa al aire libre, no usar leña ni braseros en el hogar y mantener el tratamiento controlador
**B)** Realizar ejercicio intenso al aire libre para fortalecer los pulmones
**C)** Suspender los inhaladores para evitar dependencia
**D)** Ventilar la casa con las ventanas abiertas todo el día
**E)** Calefaccionar con brasero

Respuesta A. El material particulado fino (MP2,5), de la combustión de leña, vehículos e industria, llega hasta los alvéolos y aumenta las exacerbaciones de asma y EPOC, las consultas respiratorias y los eventos cardiovasculares. En episodios críticos se evita el ejercicio intenso al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y enfermos crónicos, no se usa leña y se mantiene el tratamiento.

## 1.05.3.002 Prevención de daño pulmonar por inhalantes domésticos y laborales

Dónde se enseña: Tema 4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

### QUÉ HAY QUE SABER

- Exposiciones laborales: sílice cristalina (minería, canteras, arenado, construcción) causa silicosis; asbesto, asbestosis, placas pleurales, mesotelioma y cáncer; polvos orgánicos, neumonitis por hipersensibilidad; agentes irritantes o sensibilizantes, asma ocupacional.
- La silicosis no tiene tratamiento curativo y predispone a TBC y cáncer pulmonar: la prevención es la única medida eficaz.
- Jerarquía de control: eliminar o sustituir el agente, controles de ingeniería (técnicas húmedas, ventilación, encierro de procesos), controles administrativos y protección respiratoria certificada como última barrera.
- Vigilancia médica ocupacional con radiografía de tórax periódica (OIT) y espirometría; notificación como enfermedad profesional (Ley 16.744) y derivación a la mutualidad.
- Domésticas: evitar humo de leña o biomasa sin salida al exterior, braseros en dormitorios (CO) y tabaco intradomiciliario; ventilación adecuada al usar productos de limpieza y no mezclar cloro con amoníaco.
- Cesación tabáquica en todo trabajador expuesto: potencia el daño (asbesto + tabaco multiplica el riesgo de cáncer).

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 50 años trabaja hace 20 años en una mina subterránea perforando roca sin protección respiratoria. Presenta disnea progresiva. La radiografía muestra múltiples nódulos pequeños en lóbulos superiores y adenopatías hiliares con calcificación 'en cáscara de huevo'. **¿Cuál es la medida más importante para prevenir esta enfermedad en los demás trabajadores?**

**A)** Antibióticos profilácticos
**B)** Corticoides inhalados preventivos
**C)** Vacunación BCG anual
**D)** Control de la exposición (técnicas húmedas y ventilación), protección respiratoria certificada y vigilancia médica con radiografía periódica
**E)** Suplementos de vitamina D

Respuesta D. La silicosis es una neumoconiosis por inhalación de sílice cristalina, sin tratamiento curativo, que predispone a tuberculosis y cáncer pulmonar. Se previene controlando la exposición (técnicas húmedas, ventilación, encierro de procesos), con protección respiratoria adecuada y vigilancia ocupacional con radiografía periódica. Debe notificarse como enfermedad profesional.

## 1.05.3.003 Programa Nacional de Control de TBC

Dónde se enseña: Tema 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

### QUÉ HAY QUE SABER

- La TBC está en GES: diagnóstico, tratamiento y seguimiento gratuitos para todos los habitantes, independientemente de la previsión; notificación obligatoria.
- Pesquisa activa del sintomático respiratorio (tos con expectoración ≥2 semanas): GeneXpert MTB/RIF como examen inicial, baciloscopías y cultivo en todas las muestras. Grupos de riesgo: VIH, contactos, personas privadas de libertad, situación de calle, migrantes, diabéticos.
- Tratamiento directamente observado (TAES/DOTS) en el centro de salud: esquema primario 2 RHZE + 4 RH; asegura adherencia y previene resistencias.
- Estudio de contactos: anamnesis, examen y radiografía para descartar enfermedad activa; terapia preventiva con isoniazida en menores de 5 años o VIH sin esperar el PPD, y en adultos con infección latente.
- BCG al recién nacido (PNI): protege contra formas graves infantiles (meningitis y miliar).
- Seguimiento: baciloscopía mensual, manejo de reacciones adversas, derivación de fracasos, recaídas y multirresistencia al nivel secundario del programa.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 21**

Un paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con pacientes bacilíferos, se encuentra asintomático y su radiografía de tórax no muestra alteraciones, se solicita un PPD que resulta en 23 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Realizar tratamiento atibiótico con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol por 6 meses
**B)** Repetir PPD en un mes
**C)** Dar de alta y control en caso de síntomas
**D)** Solicitar reacción en cadena de polimerasa para mycobacterium tuberculosis en lavado bronquioloalveolar
**E)** Indicar isoniazida por 6 meses

Respuesta E. Contacto asintomático, con radiografía normal (sin enfermedad activa) y PPD muy positivo: infección latente. Se indica terapia preventiva con isoniazida por 6 meses.

## 1.05.3.004 Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud

Dónde se enseña: Tema 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

### QUÉ HAY QUE SABER

- El tabaco causa EPOC, cáncer de pulmón y de otros órganos, cardiopatía coronaria, ACV, enfermedad arterial periférica y complicaciones del embarazo; el tabaquismo pasivo también daña (asma infantil, muerte súbita del lactante).
- Dejar de fumar es la única medida que normaliza la caída anual del VEF1 en la EPOC y reduce la mortalidad a cualquier edad.
- En cada control: preguntar, aconsejar, evaluar disposición, ayudar y seguir (5A); consejería breve aun si no quiere dejarlo (entrevista motivacional).
- Si está preparado: fijar fecha de cese + farmacoterapia (vareniclina, terapia de reemplazo de nicotina o bupropión); combinar consejería y fármacos multiplica la abstinencia. Alta dependencia: primer cigarrillo <30 min tras despertar.
- Reducir el número de cigarrillos no es cesación; el cigarrillo electrónico no es una terapia de cesación recomendada.
- Prevención poblacional: ambientes cerrados libres de humo, prohibición de publicidad, advertencias en envases, impuestos y prevención del inicio en adolescentes.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 62 años, fumador activo de 20 cigarrillos al día (40 paquetes-año), con EPOC GOLD 2 recién diagnosticada. Pregunta qué puede hacer para que su enfermedad avance más lento. **¿Cuál de las siguientes intervenciones ha demostrado enlentecer la caída anual del VEF1?**

**A)** Tiotropio inhalado
**B)** Corticoide inhalado en dosis alta
**C)** Dejar de fumar
**D)** Vacuna antineumocócica
**E)** Rehabilitación pulmonar

Respuesta C. La cesación tabáquica es la única intervención que normaliza la velocidad de caída del VEF1 y, junto al oxígeno domiciliario en hipoxémicos, la que reduce mortalidad. Broncodilatadores y corticoides mejoran síntomas y exacerbaciones, pero no cambian la historia natural. Se debe ofrecer consejería más fármacos.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente fuma 5 a 7 cigarrillos al día y consulta porque quiere dejar de fumar. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

**A)** Terapia cognitivo conductual
**B)** Terapia de sustitución con nicotina
**C)** Sertralina
**D)** Bupropión
**E)** Cigarrillo electrónico

Respuesta A. Fuma muy poco, como para que requiera burpopión o nicotina. Además la terapia cognitivo conductual siempre es la más efectiva para dejar de fumar.

## 1.05.3.005 Vacunación (tuberculosis, influenza, Coronavirus SARS-CoV-2 y neumococo)

Dónde se enseña: Tema 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

**QUÉ HAY QUE SABER**

- BCG (PNI) al recién nacido: protege contra formas graves de TBC infantil (meningitis y miliar); protección limitada contra la TBC pulmonar del adulto. Vacuna viva: contraindicada en inmunodeficiencias; se posterga si el RN recibe isoniazida por madre bacilífera.
- Influenza: campaña anual previa al invierno para grupos de riesgo: adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y escolares de los primeros cursos, enfermos crónicos (asma, EPOC, cardiopatía, diabetes, inmunosuprimidos) y personal de salud.
- Neumococo: conjugada en lactantes según calendario PNI; en adultos mayores y en enfermos crónicos e inmunosuprimidos según PNI (asplenia, EPOC, cardiopatía, diabetes, VIH).
- SARS-CoV-2: refuerzos periódicos en grupos de riesgo (adultos mayores, inmunocomprometidos, embarazadas, enfermos crónicos y personal de salud).
- Indicar influenza y neumococo a todo paciente con asma, EPOC, bronquiectasias o insuficiencia respiratoria crónica; las vacunas inactivadas son seguras en inmunosuprimidos.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Una madre consulta en el control de su hijo de 1 mes por la vacuna BCG que este recibió antes del alta de la maternidad.

**¿Cuál es el principal beneficio de la vacuna BCG?**

**A)** Previene totalmente la tuberculosis pulmonar del adulto
**B)** Protege contra las formas graves de tuberculosis en la infancia, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar
**C)** Previene la infección por micobacterias atípicas
**D)** Reemplaza el estudio y tratamiento de los contactos
**E)** Protege contra la influenza

Respuesta B. La BCG, incluida en el PNI chileno, se administra al recién nacido. Su principal beneficio demostrado es la protección contra las formas graves y diseminadas de tuberculosis en niños (meningitis tuberculosa y miliar); su protección contra la tuberculosis pulmonar del adulto es variable y limitada. Por ser de bacterias vivas atenuadas, se contraindica en inmunodeficiencias.

## Exámenes e imagenología 14 códigos

### 1.05.4.001 Radiografía de tórax

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Técnica: PA y lateral de pie en inspiración; revisar identificación, penetración, rotación e inspiración antes de leer.
- Signo de la silueta: opacidad que borra el borde cardíaco derecho está en el lóbulo medio; el izquierdo, en la língula; el hemidiafragma, en el lóbulo inferior.
- Patrones: consolidación alveolar con broncograma aéreo (neumonía), intersticial, nódulo (≤3 cm) o masa, cavidad con nivel hidroaéreo (absceso), atelectasia (pérdida de volumen, desplazamiento de cisuras), hiperinsuflación con diafragmas aplanados (EPOC).
- Derrame: borra el ángulo costofrénico desde 150-200 mL, curva de Damoiseau; neumotórax: línea de pleura visceral sin trama periférica; a tensión es diagnóstico clínico, no radiológico.
- Insuficiencia cardíaca: índice cardiotorácico >0,5, redistribución de flujo a vértices, líneas B de Kerley, derrame bilateral; el SDRA tiene corazón normal e infiltrados periféricos.
- Indicaciones: confirmar NAC, estudio de tos crónica, hemoptisis, disnea, sospecha de TBC o cáncer; una radiografía normal no descarta TBC, cáncer ni TEP.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Mujer de 66 años con 3 días de fiebre y tos productiva. En la radiografía de tórax posteroanterior se observa una opacidad de tipo alveolar con broncograma aéreo que borra el contorno del borde derecho de la silueta cardíaca; el hemidiafragma derecho se ve nítido. **¿Cuál es la localización más probable de la condensación?**

**A)** Lóbulo medio
**B)** Lóbulo superior derecho
**C)** Segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho
**D)** Língula
**E)** Segmento apical del lóbulo inferior derecho

Respuesta A. Signo de la silueta: una opacidad que borra un borde indica que está en contacto anatómico con él. El borde cardíaco derecho (aurícula derecha) limita con el lóbulo medio; si se borrara el hemidiafragma, sería el lóbulo inferior. Borrar el borde cardíaco izquierdo orienta a la língula.

## 1.05.4.002 TAC de tórax

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

### QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de tórax con contraste: caracteriza nódulos y masas, evalúa mediastino y adenopatías, etapifica el cáncer pulmonar (incluir abdomen superior) y guía biopsias.
- AngioTAC de arterias pulmonares: examen de elección para confirmar TEP en el paciente estable con Wells >4 o dímero D positivo (defecto de llenado arterial).
- TACAR sin contraste: EPID (patrón NIU con panal de abejas, NINE con vidrio esmerilado) y bronquiectasias (anillo de sello).
- Otras indicaciones: hemoptisis en fumador >40 años aun con radiografía normal, absceso o empiema tabicado, neumonía que no resuelve, trauma torácico, nódulo pulmonar (cortes finos).
- Interpretar el informe: nódulo con calcificación benigna o estable ≥2 años = benigno; espiculado, >8 mm o en crecimiento = estudio. Precauciones con contraste: alergia previa, insuficiencia renal y uso de metformina.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 165**

Un paciente de 67 años, fumador de 40 paquetes/año presenta tos desde hace 4 meses, con expectoración mucosa y ocasionalmente hemoptoica. Además, ha presentado pérdida de 5 kilogramos peso. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 120/80 mmHg y se observa hipocratismo digital. Al examen pulmonar disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho y crépitos en la misma zona. **¿Cuál es el examen diagnóstico más adecuado para comenzar el manejo?**

**A)** PET-TC
**B)** Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para tuberculosis y cultivo para micobacterias
**C)** Fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar
**D)** TAC de tórax
**E)** Resonancia magnética de tórax

Respuesta D. Fumador con tos, hemoptisis, baja de peso y acropaquia: sospecha de cáncer pulmonar. Se parte por la imagen (radiografía y TAC de tórax), que localiza la lesión y orienta la biopsia. El PET-CT se usa después, para etapificar.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 58**

Hombre de 60 años con tos de 3 meses de evolución y baja de peso. La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha. **¿Cuál es el siguiente examen a solicitar?**

**A)** Resonancia magnética de tórax
**B)** Radiografía de tórax lateral
**C)** TAC de tórax con contraste
**D)** Cintigrafía ósea
**E)** Ecografía de tórax

Respuesta C. Ante una masa pulmonar sospechosa en la radiografía, el siguiente paso es la TAC de tórax con contraste (idealmente incluyendo abdomen superior): caracteriza la lesión, evalúa adenopatías mediastínicas y metástasis suprarrenales o hepáticas, y guía la biopsia. La resonancia no es el estudio de elección del pulmón.

## 1.05.4.003 Ecografía pleural

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Más sensible que la radiografía: detecta derrames desde ~20 mL (la radiografía necesita 150-200 mL) y estima su volumen.
- Permite detectar tabiques, loculaciones o engrosamiento pleural, que sugieren derrame complicado o empiema y orientan a drenaje.
- Guía la toracocentesis y la instalación de tubos: reduce neumotórax y punciones fallidas; marca el sitio y la profundidad.
- Diferencia derrame de condensación o engrosamiento pleural; útil en pacientes críticos en la cama. La ausencia de deslizamiento pleural orienta a neumotórax.
- No reemplaza el análisis del líquido: no dice si es exudado, trasudado ni si está infectado.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 65 años hospitalizado por neumonía presenta en la radiografía un leve velamiento del seno costofrénico derecho. Se planea una toracocentesis diagnóstica. **¿Cuál es la principal utilidad de la ecografía pleural en este caso?**

**A)** Medir el pH del líquido
**B)** Confirmar y cuantificar el derrame, detectar tabiques y guiar la punción para reducir complicaciones
**C)** Reemplazar el análisis del líquido pleural
**D)** Diagnosticar cáncer pulmonar
**E)** Ninguna, porque la radiografía es superior

Respuesta B. La ecografía pleural es más sensible que la radiografía para detectar derrames pequeños, permite estimar su volumen, detectar tabiques o loculaciones (sugerentes de derrame complicado) y elegir el sitio de punción. La toracocentesis guiada por ecografía reduce neumotórax y punciones fallidas. No reemplaza el estudio citoquímico y microbiológico del líquido.

## 1.05.4.004 Baciloscopia y cultivo de Koch de expectoración

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: todo sintomático respiratorio (tos con expectoración ≥2 semanas), sospecha clínica o radiológica de TBC y control del tratamiento.
- Baciloscopía (Ziehl-Neelsen o auramina): 2 muestras de expectoración (una inmediata y otra matinal); requiere >5.000 bacilos/mL, por lo que una negativa no descarta TBC. Cuantifica la baciliferia y el contagio.
- Cultivo de Koch (Löwenstein-Jensen o MGIT): estándar de oro, obligatorio en todas las muestras; único que permite identificar especie y antibiograma, pero tarda semanas. Un cultivo positivo confirma TBC aunque la baciloscopía sea negativa.
- GeneXpert MTB/RIF: PCR en <2 h que detecta el bacilo y resistencia a rifampicina; examen inicial de elección, sobre todo en VIH, niños y contactos de resistentes.
- Control del tratamiento: baciloscopía mensual; positividad desde el 4.º mes (o repositivización) sugiere fracaso: pedir cultivo y susceptibilidad y derivar. El cultivo corriente de expectoración no detecta M. tuberculosis.

**PREGUNTAS (3)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 152**

Un paciente de 42 años, fumador de 2,6 paquetes-año, presenta un cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, astenia y baja de peso de 3 kilogramos, asociado a tos y expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra zonas de relleno alveolar en el lóbulo superior derecho. **¿Con qué examen(es) se debe proseguir el estudio?**

**A)** Baciloscopías de expectoración y cultivo para micobacterias
**B)** ELISA para VIH
**C)** Biopsia pulmonar por videotoracoscopía
**D)** Lavado broncoalveolar por broncoscopía
**E)** TAC de tórax

Respuesta A. Tos productiva de más de 2 semanas, baja de peso y hemoptoicos con compromiso del lóbulo superior: sospecha de tuberculosis pulmonar. El estudio inicial es la baciloscopía seriada de expectoración más cultivo de Koch (hoy junto a prueba molecular). Los estudios invasivos se reservan si la expectoración no es diagnóstica.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 49 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos ocasiones hemoptóica. Al examen físico destaca sudoroso, frecuencia cardiaca de 60 por minuto, presión arterial de 120/70, examen cardiaco normal y pulmonar con murmullo presente, crepitaciones y sibilancias difusas mayores en ápice izquierdo. El examen más adecuado para el diagnóstico en este caso es:

**A)** Baciloscopías seriadas
**B)** Prueba cutánea de tuberculina
**C)** Radiografía de tórax
**D)** TAC de tórax multicorte
**E)** Hemocultivo

Respuesta A. Diagnóstico: Baciloscopías seriadas (opción A). Sospechar una TBC. Se estudia con BK. La Rx hay que pedirla igual, pero BK es la respuesta.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 99 · texto original del banco, sin revisar**

Un paciente de 70 años, consulta por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por tos con expectoración mucosa que en ocasiones es purulenta y baja de peso, asocia- do a compromiso del estado general, sensación febril ocasional y fatigabilidad. Se le so- licita perfil hemático que muestra hematocrito de 32%, leucocitos 12.000/mm3. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO La conducta más adecuada para proseguir con el estudio es:

**A)** Realizar broncoscopía
**B)** Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch
**C)** Solicitar TAC de tórax
**D)** Solicitar angioTAC de tórax
**E)** Solicitar cultivo de expectoración

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch (opción B). La sospecha es una tuberculosis, por el tiempo de evolución y por la clínica.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

## 1.05.4.005 Espirometría

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar · Tema 1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES · Tema 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

### QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba válida: al menos 3 maniobras reproducibles con esfuerzo máximo y espiración ≥6 segundos. Variables: VEF1, CVF y relación VEF1/CVF.
- Obstrucción: VEF1/CVF <0,70 (o bajo el límite inferior de normalidad); la severidad se gradúa por el VEF1 post-BD: ≥80% leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.
- Prueba broncodilatadora (salbutamol 400 mcg, repetir a los 15 min): positiva si VEF1 o CVF aumentan ≥12% y ≥200 mL. Reversible orienta a asma; obstrucción fija (VEF1/CVF post-BD <0,70) en fumador confirma EPOC.
- Una espirometría normal no descarta asma (metacolina o variabilidad del PEF).

- Relación normal con CVF <80% sugiere restricción, que se confirma con pletismografía (CPT <80%); la espirometría sola no diagnostica fibrosis.
- Usos: diagnóstico y seguimiento de asma y EPOC (anual en programa ERA), evaluación preoperatoria, enfermedades ocupacionales.

**PREGUNTAS (3)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 54 años, fumador de 25 paquetes-año, con disnea de esfuerzo progresiva. Espirometría basal: VEF1/CVF 0,58; VEF1 1,60 L (52% del predicho); CVF 2,76 L (78%). Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1 1,72 L (aumento de 120 mL y 7,5%), VEF1/CVF 0,60. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

**A)** Asma bronquial con respuesta broncodilatadora positiva
**B)** EPOC con limitación moderada al flujo aéreo
**C)** Restricción pulmonar confirmada por CVF bajo 80%
**D)** EPOC con limitación muy grave al flujo aéreo
**E)** Espirometría normal para la edad

Respuesta B. VEF1/CVF post-BD < 0,70 con cambio < 12% y < 200 mL: obstrucción no reversible, que en un fumador confirma EPOC. La severidad se gradúa por el VEF1 post-BD: 52% es moderada (50–79%). La CVF baja no confirma restricción.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 24 años con episodios de tos nocturna, sibilancias y disnea con el ejercicio desde hace 1 año. Espirometría: VEF1/CVF 0,68; VEF1 2,10 L (74 % del predicho). Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1 2,46 L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

**A)** Espirometría normal
**B)** Patrón restrictivo
**C)** Obstrucción con respuesta broncodilatadora significativa, compatible con asma
**D)** EPOC por VEF1/CVF menor de 0,70
**E)** Obstrucción fija sin respuesta broncodilatadora

Respuesta C. Hay obstrucción (VEF1/CVF bajo 0,70) y el VEF1 sube 360 mL, un 17 %: supera el umbral de respuesta broncodilatadora significativa (12 % y 200 mL). En una joven con síntomas variables, confirma asma. En la EPOC la obstrucción persiste tras el broncodilatador.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 58 años, fumador de 30 paquetes-año, con tos matinal y disnea de grandes esfuerzos. Espirometría basal: VEF1/CVF 0,66; VEF1 82 % del predicho. Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1/CVF 0,74; VEF1 91 % del predicho. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

**A)** EPOC GOLD 1 confirmada
**B)** Patrón restrictivo
**C)** EPOC GOLD 2 por VEF1 basal bajo 85 %
**D)** No se confirma EPOC: la relación VEF1/CVF posbroncodilatador es mayor de 0,70
**E)** Asma grave

Respuesta D. El diagnóstico de EPOC exige obstrucción persistente: VEF1/CVF menor de 0,70 después del broncodilatador. Aquí la obstrucción revierte (0,74), así que no se confirma EPOC. Igual corresponde indicar cesación tabáquica y reevaluar, porque tiene síntomas y factor de riesgo.

## 1.05.4.006 Examen microbiológico de expectoración

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Gram y cultivo de expectoración: útiles en neumonía hospitalizada, grave o que no responde, bronquiectasias y exacerbaciones con riesgo de Pseudomonas; no se requiere en la NAC ambulatoria.
- Calidad de la muestra (Murray-Washington): útil si tiene >25 polimorfonucleares y <10 células epiteliales por campo de bajo aumento; muchas células epiteliales indica saliva: no cultivar, repetir.
- Gram: diplococos grampositivos lanceolados = neumococo; cocos grampositivos en racimos = S. aureus; cocobacilos gramnegativos = H. influenzae.
- Tomar antes de iniciar antibióticos; el cultivo orienta el ajuste según antibiograma (evitar tratar contaminantes de la flora oral).

- El cultivo corriente no detecta M. tuberculosis: para TBC se piden baciloscopía, cultivo de Koch y GeneXpert.

**PREGUNTAS (1)**

Pregunta de práctica

Se envía una muestra de expectoración de un paciente hospitalizado por neumonía para Gram y cultivo. El informe señala más de 25 células epiteliales y menos de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo de bajo aumento. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

**A)** Muestra de buena calidad: se debe tratar el germen que crezca
**B)** Confirma neumonía neumocócica
**C)** Muestra no representativa (saliva), no apta para cultivo: se debe repetir
**D)** Indica tuberculosis
**E)** Indica infección viral

Respuesta C. La calidad de la expectoración se evalúa con el criterio de Murray-Washington: una muestra útil tiene más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo de bajo aumento. Muchas células epiteliales indican contaminación con saliva y flora orofaríngea, por lo que el cultivo no es interpretable y la muestra debe repetirse.

## 1.05.4.007 Citoquímico de líquido pleural

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light · Tema 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Criterios de Light (basta uno para exudado): proteínas pleura/suero >0,5, LDH pleura/suero >0,6, o LDH pleural >2/3 del límite superior sérico. Medir siempre en líquido y suero al mismo tiempo.
- Trasudado (IC, cirrosis, síndrome nefrótico): tratar la causa, sin estudio invasivo. Exudado (paraneumónico, cáncer, TBC, TEP): estudio de segunda línea.
- Segunda línea: recuento celular (neutrófilos = bacteriano; linfocitos >50% = TBC o cáncer), glucosa, pH (en jeringa de gases), ADA, citología.
- Paraneumónico complicado: pH <7,20 (mejor predictor), glucosa <40-60 mg/dL o LDH >1.000 U/L: tubo pleural.
- Linfocítico con ADA ≥40 U/L: TBC pleural; ADA bajo en fumador o mayor con baja de peso: cáncer (citología, biopsia). El TEP puede dar exudado o trasudado, a menudo serohemático.

**PREGUNTAS (2)**

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 94

Paciente con derrame pleural unilateral. Se realiza toracocentesis. **¿Cuál es el examen del líquido pleural que permite clasificarlo como exudado o trasudado según los criterios de Light?**

**A)** Proteínas y LDH en líquido pleural y suero
**B)** Glucosa en líquido pleural
**C)** ADA en líquido pleural
**D)** pH del líquido pleural
**E)** Recuento celular diferencial

Respuesta A. Criterios de Light: proteínas LP/suero > 0,5, LDH LP/suero > 0,6, LDH LP > 2/3 del límite normal. Uno o más criterios clasifican como exudado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 171

Un paciente de 40 años, consulta por disnea desde hace 2 semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia matidez a la percusión y disminución del murmullo pulmonar en base izquierda. Se realiza radiografía que se muestra a continuación: **El examen más adecuado para seguir con el estudio es:**

**A)** TAC
**B)** AngioTAC
**C)** Ecocardiografía
**D)** Análisis citoquímico del líquido pleural
**E)** Ecografía pleural

Respuesta D. Derrame pleural de causa no clara: se punciona y se analiza el líquido (criterios de Light y estudio de segunda línea).

## 1.05.4.008 Examen microbiológico de líquido pleural

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

### QUÉ HAY QUE SABER

- Gram y cultivo (aerobios y anaerobios) del líquido pleural en todo derrame paraneumónico o exudado de causa no clara; idealmente antes de antibióticos.
- Gram o cultivo positivos (aunque el líquido se vea claro) definen empiema: indican tubo pleural además del antibiótico. Pus macroscópico también.
- El cultivo positivo orienta el antibiótico; los anaerobios son frecuentes y a menudo no crecen, por eso siempre se cubren.
- TBC pleural: baciloscopía del líquido positiva en <10% y cultivo de bajo rendimiento (paucibacilar); el diagnóstico se apoya en ADA ≥40 y biopsia pleural con granulomas.
- Un cultivo negativo no descarta derrame complicado si el pH o la glucosa son bajos.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 55 años con neumonía basal derecha persiste febril al 4° día de tratamiento. La toracocentesis obtiene líquido turbio, no purulento, con pH 7,10, glucosa 35 mg/dL y LDH 1.500 U/L. El Gram del líquido muestra diplococos grampositivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Mantener los antibióticos sin otra intervención
**B)** Suspender los antibióticos y observar
**C)** Repetir la toracocentesis en 1 semana
**D)** Instalar drenaje pleural (tubo pleural) además de los antibióticos
**E)** Iniciar corticoides

Respuesta D. Un Gram o cultivo positivo del líquido pleural, o pH bajo 7,20, glucosa bajo 60 mg/dL o pus, definen un derrame paraneumónico complicado o empiema, que requiere drenaje pleural además de antibióticos. Si hay loculaciones que impiden el drenaje, se consideran fibrinolíticos intrapleurales o videotoracoscopía.

## 1.05.4.009 Flujo espiratorio máximo (PEF: Peak Expiratory Flow)

Nivel: **Realiza, interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Crisis Asmática en el Adulto

### QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: de pie, inspiración máxima, boquilla sellada, soplido corto, rápido y lo más fuerte posible; 3 intentos y se registra el mejor.
- Se expresa como % del mejor valor personal (o del teórico): en crisis asmática 50-70% moderada, <50% grave; objetiva la severidad junto con la clínica.
- Reevaluación a la hora del tratamiento de la crisis: PEF >70% con clínica estable y SatO2 >93% permite el alta; <50% tras tratamiento obliga a hospitalizar.
- Diagnóstico de asma: variabilidad diurna del PEF >10% demuestra limitación variable del flujo cuando la espirometría es normal.
- Monitoreo domiciliario en el plan de acción escrito: zonas verde (>80%), amarilla (50-80%) y roja (<50%) guían el uso de rescate y la consulta.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Mujer de 26 años con crisis asmática en el SAPU. Ingresó con PEF de 45 % del predicho. Recibió oxígeno, 3 nebulizaciones de salbutamol con ipratropio y prednisona 40 mg oral. Una hora después: habla frases completas, FR 18/min, SatO2 96 % ambiental, sibilancias escasas y PEF 78 % del predicho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Hospitalizar en sala para tratamiento endovenoso
**B)** Alta sin tratamiento, ya que el PEF es normal
**C)** Sulfato de magnesio endovenoso antes del alta
**D)** Mantener en observación 24 horas aunque esté estable
**E)** Alta con prednisona por 5 a 7 días, corticoide inhalado y control precoz

Respuesta E. El PEF objetiva la respuesta: sobre 70 % del predicho a la hora, con clínica estable y SatO2 normal, permite el alta. Debe irse con corticoide oral 5 a 7 días, inicio o ajuste del corticoide inhalado, plan de acción y control precoz. Bajo 50 % tras tratamiento obliga a hospitalizar.

## 1.05.4.010 Gases en sangre arterial

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos · Tema 1.2 Crisis Asmática en el Adulto · Tema 1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) · Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

### QUÉ HAY QUE SABER

- Lectura sistemática: pH (acidemia <7,35, alcalemia >7,45), PaCO2 (respiratorio) y HCO3 (metabólico); verificar si la compensación es la esperada (Winter en acidosis metabólica; 0,7 × ΔHCO3 en alcalosis); fuera de lo esperado = trastorno mixto.
- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg; tipo 2 si PaCO2 >45. Gradiente A-a = (150 – PaCO2/0,8) – PaO2: normal (5-15) en hipoventilación pura, elevado en enfermedad pulmonar.
- Aguda vs crónica: en la hipercapnia crónica el HCO3 sube y el pH queda casi normal; pH <7,35 con PaCO2 >45 en EPOC exacerbado indica VMNI.
- Crisis asmática: lo esperable es PaCO2 baja (hiperventilación); PaCO2 normal o alta con somnolencia indica agotamiento y paro inminente.
- PaFi (PaO2/FiO2): ≤300 con PEEP ≥5 define SDRA (≤200 moderado, ≤100 severo).
- Los gases venosos no sirven para oxigenación; la PaO2 convencional no detecta CO: pedir co-oximetría.

### PREGUNTAS (4)

**Pregunta de práctica**

Mujer de 40 años, sin enfermedad pulmonar, con 4 días de vómitos por gastroenteritis. Gases arteriales: pH 7,50, pCO2 48 mmHg, HCO3 36 mEq/L. Na 137 mEq/L, Cl 90 mEq/L, K 3,1 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de los gases?**

**A)** Acidosis respiratoria crónica compensada
**B)** Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria agregada
**C)** Alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria agregada
**D)** Alcalosis metabólica con compensación respiratoria adecuada
**E)** Alcalosis respiratoria aguda

Respuesta D. pH alto y bicarbonato alto: alcalosis metabólica primaria. La pCO2 esperada es 0,7 × (36 – 24) + 40 = 48 mmHg (± 2). La medida es 48: compensación adecuada, trastorno simple. Una pCO2 mayor de 50 indicaría acidosis respiratoria agregada.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 19 años con crisis asmática de 6 horas. Tras 1 hora de salbutamol con ipratropio está somnoliento, con FR 30/min, uso de musculatura accesoria y murmullo pulmonar muy disminuido, casi sin sibilancias. Gases con oxígeno: pH 7,35, PaCO2 45 mmHg, PaO2 62 mmHg, HCO3 24 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de los gases?**

**A)** Signo de agotamiento respiratorio inminente; manejo en UCI y preparar intubación
**B)** Gases tranquilizadores: la PaCO2 es normal
**C)** Alcalosis respiratoria esperable en la crisis
**D)** Acidosis metabólica por uso de salbutamol
**E)** Hipoxemia leve que solo requiere más oxígeno

Respuesta A. En la crisis asmática el paciente hiperventila y la PaCO2 debe estar baja. Una PaCO2 normal o alta, con somnolencia y tórax silencioso, indica fatiga muscular y paro respiratorio inminente: crisis de riesgo vital que requiere UCI y preparar intubación.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 69 años con EPOC GOLD 3 consulta por exacerbación de 3 días. Somnoliento pero obedece órdenes, FR 30/min, SatO2 87 % con oxígeno por cánula a 2 L/min. Gases: pH 7,31, PaCO2 62 mmHg, PaO2 56 mmHg, HCO3 30 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación de los gases y la conducta más adecuada?**

**A)** Acidosis respiratoria crónica compensada; aumentar el oxígeno a 6 L/min
**B)** Acidosis respiratoria crónica compensada; alta con broncodilatadores
**C)** Acidosis metabólica; bicarbonato endovenoso
**D)** Alcalosis metabólica; suspender los corticoides
**E)** Acidosis respiratoria aguda sobre crónica; iniciar ventilación mecánica no invasiva

Respuesta E. El HCO3 alto indica retención crónica de CO2, pero el pH bajo 7,35 muestra que la compensación no alcanza: hay un componente agudo. Acidosis respiratoria aguda sobre crónica con pH entre 7,25 y 7,35 es la indicación clásica de ventilación no invasiva en la exacerbación de EPOC.

**Pregunta de práctica**

Hombre de 35 años con síndrome de Guillain-Barré en progresión, con debilidad de extremidades y tos débil. Murmullo pulmonar normal, radiografía de tórax normal. Gases arteriales con aire ambiental (FiO2 21 %, a nivel del mar): pH 7,32, PaCO2 58 mmHg, PaO2 66 mmHg, HCO3 29 mEq/L. **¿Cuál es el mecanismo de la hipoxemia?**

**A)** Alteración ventilación/perfusión por neumonía
**B)** Disminución de la FiO2 por altura
**C)** Cortocircuito intrapulmonar por SDRA
**D)** Trastorno de difusión por fibrosis
**E)** Hipoventilación alveolar pura, con gradiente alvéolo-arterial normal

Respuesta E. PAO2 = 150 – (58 / 0,8) ≈ 77 mmHg; gradiente A-a = 77 – 66 ≈ 11 mmHg, normal. Hipercapnia con gradiente normal y pulmón sano indica hipoventilación pura, aquí por debilidad neuromuscular. El tratamiento es ventilatorio; el oxígeno solo no corrige la causa.

## 1.05.4.011 PPD

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

### QUÉ HAY QUE SABER

- PPD (tuberculina): 0,1 mL intradérmico en el antebrazo; se lee la induración (no el eritema) en milímetros a las 48-72 horas.
- Positivo: ≥10 mm en inmunocompetentes; ≥5 mm en VIH, inmunosuprimidos (corticoides, biológicos) y contactos de riesgo.
- Indica infección por M. tuberculosis (o BCG), pero no distingue infección latente de enfermedad activa: siempre descartar TBC activa con clínica, radiografía y baciloscopías.
- Falsos negativos: inmunosupresión, desnutrición, TBC grave, lectura incorrecta; falsos positivos: BCG, micobacterias atípicas. Alternativa: IGRA (QuantiFERON).
- Uso: contactos adultos e inmunosuprimidos antes de biológicos; positivo sin enfermedad activa = terapia preventiva (isoniazida 6-9 meses). En contactos <5 años o VIH no se espera el PPD para iniciarla.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 35 años con VIH, en terapia antirretroviral y con CD4 de 350 células/mm³, es contacto intradomiciliario de un caso de tuberculosis pulmonar bacilífera. Está asintomático y su radiografía de tórax es normal. El PPD resulta de 7 mm. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

**A)** PPD negativo: no requiere intervención
**B)** El PPD no es interpretable en personas con VIH
**C)** PPD dudoso: repetirlo en 1 año
**D)** PPD positivo: iniciar tratamiento con 4 fármacos
**E)** PPD positivo (≥5 mm en VIH): iniciar terapia preventiva de tuberculosis

Respuesta E. En personas con VIH u otra inmunosupresión, un PPD de 5 mm o más se considera positivo (en inmunocompetentes, 10 mm o más). Con radiografía normal y sin síntomas se descarta tuberculosis activa y se indica terapia preventiva (isoniacida o esquemas cortos con rifamicinas). El tratamiento con 4 fármacos se reserva para la enfermedad activa.

## 1.05.4.012 Prueba de provocación bronquial con fármacos

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: síntomas sugerentes de asma (tos, sibilancias, disnea nocturna o con gatillantes) con espirometría y prueba broncodilatadora normales.
- Demuestra hiperreactividad bronquial: positiva si el VEF1 cae ≥20% con dosis bajas de metacolina (PC20 baja); apoya el diagnóstico de asma.
- Alto valor predictivo negativo: una prueba negativa prácticamente descarta asma activa.
- Contraindicada en crisis asmática u obstrucción significativa (provoca broncoespasmo), IAM o ACV recientes y aneurisma; se realiza en laboratorio con broncodilatador disponible.

- No confundir con pruebas cutáneas: el prick demuestra sensibilización alérgica, no asma.

**PREGUNTAS (4)**

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 163**

Una paciente de 19 años presenta disnea, asociada a tos y ocasionalmente sibilancias. Refiere que sus síntomas suelen ser más frecuentes e intensos durante la noche. Ha notado aumento en la intensidad y frecuencia de estos síntomas, desde que adoptó un gato hace un mes. Sus signos vitales son normales, satura 98% a FiO2 ambientas y su examen cardiopulmonar es normal. Se solicita una radiografía de tórax, que resulta normal. Se realiza una espirometría basal y postbroncodilatador, que muestra parámetros dentro de la normalidad. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

**A)** IgE sérica total
**B)** TAC de tórax
**C)** Prueba de provocación bronquial con metacolina
**D)** Prueba cutánea para alérgenos inhalados
**E)** Serología para Mycoplasma pneumoniae

Respuesta C. Síntomas compatibles con asma pero sin obstrucción en el examen ni en la espirometría: la variabilidad se demuestra con la provocación bronquial con metacolina (caída del VEF1 > 20%). El prick test demuestra atopia, no asma.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 163**

Una paciente de 19 años presenta disnea asociada a tos y ocasionalmente sibilancias. Refiere que sus síntomas suelen ser más frecuentes e intensos durante la noche, y ha notado aumento de su intensidad y frecuencia desde que adoptó un gato hace un mes. Sus signos vitales son normales, satura 98% con FiO2 ambiental y su examen cardiopulmonar es normal. La radiografía de tórax es normal. Se realiza una espirometría basal y post broncodilatador que muestra parámetros dentro de la normalidad. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

**A)** IgE sérica total
**B)** TAC de tórax
**C)** Prueba de provocación bronquial con metacolina
**D)** Prueba cutánea para alérgenos inhalados
**E)** Serología para Mycoplasma pneumoniae

Respuesta C. Ante síntomas sugerentes de asma con espirometría normal, se busca hiperreactividad bronquial con la prueba de provocación con metacolina: una caída del VEF1 de 20% con dosis bajas apoya el asma, y una prueba negativa prácticamente lo descarta. El prick test demuestra sensibilización al gato, pero no confirma asma.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 24 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente de 20 años, con antecedente de rinitis alérgica y usuaria de anticonceptivos orales, con historia de disnea y tos seca al realizar ejercicios, no asociado a otros síntomas. Actualmente asintomática y su examen físico es normal. El examen de elección para el diagnóstico de esta paciente es:

**A)** Test de esfuerzo
**B)** Test de metacolina
**C)** Prick test
**D)** Espirometría
**E)** PEF

Respuesta B. Por ser un asma sin clínica actual, no servirá ni el PEF ni la espirometría. Esta pregunta también es muy discutible, ya que el diagnóstico de asma es clínico y los demás exámenes solo son de apoyo diagnóstico. Además en la mayoría de los libros, guías y recomendaciones se prefiere hacer espirometría y solo solicitar las demás pruebas ante la duda diagnóstica. Sin embargo, el eunacom ha preguntado

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 64 · texto original del banco, sin revisar**

Una paciente de 21 años presenta rinorrea, congestión nasal, disnea, tos, con expectoración mucosa y sibilancias, que aparecen luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias, siendo mayores en primavera. Su examen físico tiene frecuencia respiratoria 12x', frecuencia cardíaca 73x', PA: 120/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal. Se solicitar un PEF, que resulta 580 L/min, que equivale al 100% del valor esperado. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en esta paciente?

**A)** Prick test
**B)** TAC de tórax
**C)** Espirometría basal y postbroncodilatador
**D)** Prueba de eosinófilos nasales
**E)** Prueba de provocación bronquial

Respuesta E. Aunque el diagnóstico de asma es principalmente clínico, tanto la espirometría como la prueba de provocación con metacolina son útiles para apoyar el diagnóstico. La espirometría es de elección en los pacientes con obstrucción clínica y la provocación con metacolina es de elección en los pacientes sin nada de obstrucción basal, como en esta paciente.

## 1.05.4.013 Pruebas cutáneas de alergia

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

### QUÉ HAY QUE SABER

- Prick test: detecta sensibilización mediada por IgE a aeroalérgenos (ácaros, pólenes, epitelios, hongos) o alimentos; se lee la roncha a los 15-20 minutos.
- Requiere control positivo (histamina) y negativo (suero) para validar la respuesta y descartar dermografismo.
- Suspender antihistamínicos orales 5-7 días antes (también tricíclicos) por falsos negativos; los corticoides intranasales no interfieren.
- Un positivo indica sensibilización, no enfermedad: debe correlacionarse con la clínica. Alternativa si no se puede suspender antihistamínicos o hay dermatitis extensa: IgE específica sérica.
- Indicaciones: rinitis o asma persistente para identificar alérgenos y orientar el control ambiental (fundas antiácaros, lavado con agua caliente) o la inmunoterapia.

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 28 años con rinorrea acuosa, estornudos y prurito nasal estacionales será sometido a un prick test para identificar alérgenos. Usa loratadina diaria y mometasona intranasal. **¿Cuál es la indicación más adecuada antes del examen?**

**A)** Suspender la loratadina al menos 5 a 7 días antes del test
**B)** Aumentar la dosis de loratadina el día del examen
**C)** Suspender el corticoide intranasal 1 mes antes
**D)** Realizar el test durante una anafilaxia
**E)** No requiere preparación

Respuesta A. Los antihistamínicos orales inhiben la roncha y causan falsos negativos, por lo que se suspenden 5 a 7 días antes del prick test. El control positivo con histamina verifica que la piel responda y el control negativo con suero descarta dermografismo. Los corticoides intranasales no alteran la prueba. Un positivo indica sensibilización, que debe correlacionarse con la clínica.

**Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 126 · texto original del banco, sin revisar**

Un hombre de 30 años, con rinorrea frecuente, se realiza prueba cutánea (prick test), que muestra reacción de 5mm a pólenes y de 0 mm al control histamina. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de esta prueba?

**A)** Es alérgico
**B)** Está sensibilizado a pólenes
**C)** Tiene rinitis vasomotora
**D)** Tiene sinusitis crónica
**E)** Anergia cutánea

Respuesta B. En mi opinión, es una pregunta con error, ya que el control positivo (con histamina) resulta 0 mm, lo que habitualmente significa que está usando antihistamínicos y el examen no sirve, por la anergia cutánea farmacológica, sin embargo, también resulta negativo para todo lo demás. En cambio, en este caso, resultó positivo para pólenes (>3 mm), lo que es imposible según lo anterior, pero da cuenta q

### 1.05.4.014 Saturometría arterial

Nivel: **Realiza, interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

#### QUÉ HAY QUE SABER

- Oxímetro de pulso: SatO2 normal ≥95% a nivel del mar; SatO2 90% equivale aproximadamente a PaO2 60 mmHg (inflexión de la curva).
- Metas: 92-96% en la mayoría; 88-92% en retenedores de CO2 (EPOC); 93-95% en crisis asmática (≥95% en embarazadas o cardiópatas).
- Falsamente normal en intoxicación por CO (no distingue carboxihemoglobina) y en metahemoglobinemia; pedir co-oximetría.
- Lecturas poco confiables con hipoperfusión o shock, hipotermia, movimiento, uñas pintadas, anemia severa; verificar la curva de pulso.
- No mide ventilación: puede ser normal con hipercapnia grave (sobre todo con oxígeno), por eso en IR se complementa con gases arteriales.

#### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Una familia de 4 personas consulta en invierno por cefalea, náuseas y mareos que comenzaron en la noche, en una casa calefaccionada con brasero. Una mujer de 40 años está somnolienta y tiene saturometría de pulso de 99% ambiental.
**¿Cuál es la interpretación más adecuada de la saturometría?**

**A)** Puede estar falsamente normal, porque el oxímetro convencional no distingue carboxihemoglobina de oxihemoglobina: se debe medir carboxihemoglobina
**B)** Descarta una intoxicación por monóxido de carbono
**C)** Indica que no requiere oxígeno
**D)** Indica hiperventilación
**E)** Indica anemia

Respuesta A. El oxímetro de pulso convencional usa 2 longitudes de onda y lee la carboxihemoglobina como oxihemoglobina, por lo que la saturación aparece falsamente normal en la intoxicación por CO. Se mide carboxihemoglobina por cooximetría en gases arteriales o venosos y se inicia de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de alto flujo, sin esperar el resultado.

## Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 12 códigos

### 1.05.5.001 Aspiración traqueal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

#### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: secreciones visibles o audibles (roncus, gorgoteo), desaturación o aumento de presiones en paciente intubado o traqueostomizado, o que no puede toser eficazmente; obtener muestras para cultivo.

- Preparación: técnica aséptica (guantes estériles, sonda estéril), preoxigenar con O2 100% por 30-60 s, monitorizar SatO2 y frecuencia cardíaca.
- Sonda de calibre no mayor que la mitad del diámetro interno del tubo; introducir sin aspirar hasta encontrar resistencia, retirar 1 cm y aspirar mientras se retira con rotación.
- Cada aspiración ≤10-15 segundos con presión moderada (aprox. 80-150 mmHg en adultos); reoxigenar entre pasadas y no instilar suero de rutina.
- Complicaciones: hipoxemia, bradicardia vagal y arritmias, broncoespasmo, trauma de mucosa y sangrado, atelectasia e infección; suspender si hay desaturación o bradicardia.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Un paciente de 70 años, intubado en UCI, presenta secreciones abundantes, roncus y caída de la saturación a 89%. Se decide aspirar las secreciones por el tubo endotraqueal. **¿Cuál es la técnica más adecuada?**

**A)** Aspirar en forma continua durante 1 minuto mientras se introduce la sonda
**B)** Preoxigenar, usar técnica estéril y aspirar en forma intermitente al retirar la sonda, por no más de 10 a 15 segundos
**C)** Instilar suero fisiológico de rutina antes de cada aspiración
**D)** Aspirar cada 1 hora aunque no haya secreciones
**E)** Usar la misma sonda para aspirar primero la boca y luego la tráquea

Respuesta B. La aspiración traqueal se realiza solo cuando es necesaria, con técnica estéril, preoxigenación y sonda de calibre adecuado, aplicando aspiración solo al retirar y por no más de 10 a 15 segundos, para evitar hipoxemia, bradicardia y trauma de mucosa. No se recomienda instilar suero de rutina, y la tráquea se aspira antes que la boca.

## 1.05.5.002 Biopsia pleural

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: exudado linfocítico sin diagnóstico tras el análisis del líquido (sospecha de TBC o cáncer), especialmente con citologías negativas o engrosamiento pleural nodular.
- Biopsia percutánea con aguja: rinde >80% en TBC pleural (granulomas caseificantes) cuando el ADA es limítrofe o dudoso.
- Toracoscopía o videotoracoscopía (VATS): de elección ante sospecha de neoplasia con 2 citologías negativas o mesotelioma (asbesto); rendimiento >90% y permite pleurodesis en el mismo acto.
- La biopsia es pleural, no pulmonar: no repetir citologías indefinidamente ni iniciar tratamiento antituberculoso empírico con ADA bajo.
- Nivel del médico general: plantear la indicación y derivar a broncopulmonar o cirugía de tórax con radiografía, TAC y estudio del líquido.

**PREGUNTAS (1)**

**Pregunta de práctica**

Mujer de 68 años, exfumadora, con baja de peso y derrame pleural derecho recidivante. Dos toracocentesis muestran exudado linfocitario con ADA 18 U/L y citología negativa para células neoplásicas en ambas muestras. TAC de tórax: engrosamiento pleural nodular derecho. **¿Cuál es el procedimiento más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

**A)** Toracoscopía (pleuroscopía) con biopsia pleural dirigida
**B)** Pleurodesis con talco sin diagnóstico histológico
**C)** Tercera citología del líquido pleural
**D)** Tratamiento antituberculoso empírico
**E)** Marcadores tumorales en sangre

Respuesta A. Ante sospecha de derrame neoplásico con 2 citologías negativas, una tercera rinde poco. La toracoscopía permite ver la pleura y biopsiar los nódulos bajo visión directa, con rendimiento superior a 90 % para neoplasia, y en el mismo acto hacer pleurodesis. El ADA bajo hace improbable la tuberculosis.

## 1.05.5.003 Cricoidostomía

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: escenario «no puedo intubar, no puedo oxigenar» (trauma maxilofacial grave, edema de glotis, obstrucción supraglótica) cuando fallan la intubación y la ventilación con bolsa-mascarilla o dispositivo supraglótico.
- Reparos: membrana cricotiroidea, entre el cartílago tiroides y el cricoides; vía rápida y con pocas estructuras vasculares.
- Técnica quirúrgica: hiperextensión si no hay lesión cervical, fijar la laringe, incisión de piel y de la membrana, dilatar e insertar tubo con balón de pequeño calibre (6,0); confirmar con capnografía.
- Menores de 12 años: cricotiroidotomía por punción con aguja 12-14 G y ventilación en jet (la quirúrgica arriesga estenosis subglótica).
- Es temporal: convertir a traqueostomía. Contraindicaciones relativas: fractura o sección laríngea y edad <12 años (quirúrgica).

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Un hombre de 30 años ingresa tras un accidente de tránsito con trauma facial grave, fractura mandibular y sangrado orofaríngeo masivo. Está desaturando a 75%, no se logra ventilar con bolsa-mascarilla y fracasan 2 intentos de intubación orotraqueal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Nuevo intento de intubación con un laringoscopio de otro tamaño
**B)** Traqueostomía reglada en pabellón
**C)** Cricotiroidotomía quirúrgica de urgencia
**D)** Intubación nasotraqueal a ciegas
**E)** Ventilación no invasiva

Respuesta C. La situación de 'no puedo intubar, no puedo oxigenar' indica una vía aérea quirúrgica de urgencia: cricotiroidotomía a través de la membrana cricotiroidea, rápida y con pocas estructuras vasculares. La traqueostomía es más lenta y compleja en urgencia, y la intubación nasotraqueal se evita en trauma facial grave. En menores de 12 años se prefiere la cricotiroidotomía por punción.

## 1.05.5.004 Drenaje pleural

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural · Tema 3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: neumotórax grande, secundario o tras descompresión de uno a tensión; hemotórax; derrame paraneumónico complicado o empiema; quilotórax; derrame maligno para pleurodesis.
- Sitio: triángulo de seguridad, 4.º-5.º EIC entre líneas axilares anterior y media, sobre el borde superior de la costilla inferior (el paquete vasculonervioso corre por el borde inferior).
- Calibre: 24-28 Fr en empiema, 28-32 Fr en hemotórax; conexión a trampa de agua (succión suave −10 a −20 cmH2O si se requiere).
- En hemotórax, toracotomía si el débito inicial es ≥1.500 mL o >200 mL/h por 2-4 h; nunca pinzar un tubo que sangra.
- Nivel del médico general: indicar y derivar a especialista; reconocer complicaciones (mala posición, lesión de hígado/bazo si es bajo, edema de reexpansión, infección).

### PREGUNTAS (2)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 45 años con empiema pleural izquierdo confirmado. Se decide instalar un tubo de drenaje pleural en decúbito supino con el brazo en abducción. **¿Cuál es el sitio de inserción recomendado?**

**A)** 2.º espacio intercostal, línea medioclavicular
**B)** 8.º espacio intercostal, línea escapular
**C)** 4.º o 5.º espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media (triángulo de seguridad)
**D)** Región subxifoidea
**E)** Borde inferior de la 5.ª costilla, línea axilar posterior

Respuesta C. El tubo se instala en el triángulo de seguridad: borde lateral del pectoral mayor, borde anterior del dorsal ancho y línea del pezón (4.º a 5.º espacio), sobre el borde superior de la costilla inferior. Evita la arteria mamaria, el diafragma y las vísceras abdominales, y se conecta a trampa de agua.

**Pregunta de práctica**

Paciente traumatizado ingresa con un hemotórax masivo derecho. Se instala un tubo de drenaje torácico 32 Fr, con salida inmediata de 1.700 mL de sangre fresca. Pese a la reposición con fluidos y glóbulos rojos, en las 2 horas siguientes el débito es de 250 mL/hora continuo. **¿Cuál es la indicación de manejo definitivo?**

**A)** Instalar un segundo tubo pleural en el mismo hemitórax
**B)** Pinzar el tubo para favorecer el coágulo intratorácico
**C)** Toracotomía de urgencia en pabellón
**D)** Embolización selectiva por angiografía en 24 horas
**E)** Ácido tranexámico y observación en sala

Respuesta C. Cumple los dos criterios de toracotomía de urgencia: drenaje inicial ≥ 1.500 mL (1.700 mL) y débito > 200 mL/h por 2 a 4 horas (250 mL/h). Pinzar el tubo provocaría un hemotórax a tensión.

## 1.05.5.005 Fibrobroncoscopia

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones diagnósticas: sospecha de cáncer central (biopsia), hemoptisis en mayor de 40 años o fumador aun con radiografía normal, atelectasia persistente, neumonía que no resuelve o recurrente en el mismo sitio.
- Absceso pulmonar en mayor de 50 años, fumador o desdentado sin factores de aspiración: descartar carcinoma obstructivo o cuerpo extraño.
- Lavado broncoalveolar en inmunosuprimidos (Pneumocystis, hongos) y en sospecha de TBC con baciloscopías y GeneXpert negativos.
- Terapéutica: aspiración de secreciones o tapones mucosos, localización y control de hemoptisis; en cuerpo extraño (sobre todo en niños) se usa la broncoscopía rígida.
- Nivel del médico general: plantear la indicación y derivar a broncopulmonar; idealmente con TAC previa para orientar el sitio.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 67 años, fumador de 50 paquetes-año, desdentado total, sin alcoholismo ni trastornos de conciencia ni de deglución. Consulta por 4 semanas de fiebre y tos purulenta. Radiografía: cavidad de 5 cm con nivel hidroaéreo en el lóbulo superior derecho. Baciloscopías negativas. **Además de iniciar antibióticos, ¿cuál es el estudio más adecuado?**

**A)** Ninguno: es un absceso por aspiración típico
**B)** Fibrobroncoscopía para descartar una neoplasia endobronquial obstructiva
**C)** Cintigrafía pulmonar
**D)** Ecocardiograma transesofágico
**E)** Prueba de tuberculina

Respuesta B. Un absceso sin factores de aspiración, en un desdentado (sin dientes no hay flora anaerobia gingival abundante), en un gran fumador mayor, obliga a descartar un cáncer bronquial que obstruye y abscede el pulmón distal, o un carcinoma cavitado. La fibrobroncoscopía visualiza la vía aérea y permite biopsia.

## 1.05.5.006 Inhalación de aerosoles presurizados

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

### QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica con inhalador presurizado: retirar la tapa, agitar, exhalar fuera del inhalador, disparar 1 puff al inicio de una inspiración lenta y profunda, mantener apnea ~10 segundos; esperar 30-60 s entre puffs.
- Aerocámara (espaciador): recomendada en niños, adultos mayores, crisis y en quien no coordina; 1 puff a la vez y 5-6 respiraciones por puff (con mascarilla en lactantes y preescolares).
- La aerocámara aumenta el depósito pulmonar, reduce el depósito orofaríngeo y es tan eficaz como la nebulización en la crisis leve-moderada.
- Tras el corticoide inhalado, enjuagar la boca (previene candidiasis oral y disfonía).

- Revisar la técnica en cada control: la mala técnica es la causa más frecuente de mal control del asma antes de subir de escalón.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 6 años con asma usa salbutamol en inhalador presurizado de dosis medida. La madre refiere que no mejora durante las crisis. Al observar la técnica, el niño dispara el inhalador directamente en la boca y respira rápidamente. **¿Cuál es la indicación más adecuada para mejorar la técnica?**
> **A)** Cambiar a salbutamol en jarabe
> **B)** Indicar nebulizaciones diarias permanentes
> **C)** Aumentar el número de puffs sin cambiar la técnica
> **D)** Usar aerocámara (espaciador), con mascarilla o boquilla según la edad, y realizar varias respiraciones tras cada puff
> **E)** Disparar el inhalador hacia la nariz
> Respuesta D. La mayoría de los pacientes, especialmente los niños, no coordina el disparo con la inspiración, y gran parte del fármaco queda en la orofaringe. La aerocámara mejora el depósito pulmonar y reduce efectos locales: se agita el inhalador, se dispara un puff en la aerocámara y se respira 5 a 6 veces por puff. Los jarabes no se recomiendan.

## 1.05.5.007 Intubación traqueal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicaciones: Glasgow ≤8 o incapacidad de proteger la vía aérea, paro, insuficiencia respiratoria refractaria o fracaso de la VMNI, shock grave, obstrucción inminente de vía aérea.
- Secuencia rápida: preparar equipo y aspiración, preoxigenar con O2 100% 3-5 min, inductor (ketamina —también broncodilata en asma—, etomidato o propofol) y relajante (succinilcolina o rocuronio); en trauma, restricción cervical en línea.
- Tubo 7,0-7,5 en mujeres y 7,5-8,0 en hombres (≥8,0 si se requiere broncoscopía o hemoptisis masiva); laringoscopía directa o video.
- Confirmar posición con capnografía de onda continua (el método más confiable); luego auscultación y radiografía (punta 2-4 cm sobre la carina).
- Nunca intubar ni ventilar con presión positiva un neumotórax a tensión sin descomprimir. Si falla: dispositivo supraglótico y, si no se oxigena, cricotiroidotomía.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Se intuba a un paciente de 60 años por insuficiencia respiratoria aguda. Tras pasar el tubo se ausculta murmullo pulmonar bilateral, pero se requiere confirmar en forma objetiva que el tubo está en la tráquea. **¿Cuál es el método más confiable para confirmar de inmediato la intubación traqueal?**
> **A)** Empañamiento del tubo
> **B)** Ausencia de ruidos en el epigastrio
> **C)** Expansión torácica
> **D)** Saturometría a los 5 minutos
> **E)** Capnografía con curva de CO2 espirado persistente
> Respuesta E. La capnografía de onda continua, que muestra CO2 espirado en ciclos sucesivos, es el método más confiable para confirmar la posición traqueal del tubo y detectar desplazamientos. Los signos clínicos pueden engañar y la saturación cae tardíamente en una intubación esofágica. Luego se verifica la altura del tubo con radiografía de tórax.

## 1.05.5.008 Nebulizaciones

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Crisis Asmática en el Adulto

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicación: crisis asmática grave con hipoxemia o paciente que no coordina ni puede usar aerocámara; en la crisis leve-moderada la aerocámara es igual de eficaz.

- Dosis habituales adulto: salbutamol 2,5-5 mg + ipratropio 500 mcg diluidos en 3-4 mL de suero fisiológico, c/20 min en la primera hora.
- En asma grave hipoxémica nebulizar con oxígeno a 6-8 L/min (corrige la hipoxemia); con aire comprimido puede empeorar la desaturación.
- En EPOC retenedor de CO2 preferir nebulizar con aire comprimido y oxígeno por cánula, para no exceder la meta de 88-92%.
- Técnica: paciente sentado, mascarilla bien ajustada o boquilla, respiración a volumen corriente hasta terminar la solución (~10 min); vigilar taquicardia, temblor e hipokalemia.

**PREGUNTAS (1)**

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 32 años, asmática, consulta en urgencia por disnea progresiva de 6 horas. Habla en palabras sueltas, FR 32/min, FC 124/min, SatO2 87% con aire ambiental, uso de musculatura accesoria y sibilancias difusas. Está muy ansiosa y no logra coordinar la inhalación. **¿Cuál es la forma más adecuada de administrar el broncodilatador inicial?**
> **A)** Salbutamol más bromuro de ipratropio nebulizados con oxígeno a 6-8 L/min
> **B)** Salbutamol en polvo seco inhalado
> **C)** Salbutamol en inhalador de dosis medida sin aerocámara
> **D)** Salbutamol nebulizado con aire comprimido, agregando oxígeno solo si persiste la hipoxemia
> **E)** Salbutamol endovenoso como primera línea
> Respuesta A. Crisis asmática grave con hipoxemia en una paciente que no coordina: la nebulización impulsada por oxígeno a 6-8 L/min entrega el broncodilatador y corrige la hipoxemia a la vez, y en crisis grave se asocia ipratropio. Nebulizar con aire comprimido en una paciente hipoxémica empeora la desaturación. La vía endovenosa no es primera línea.

## 1.05.5.009 Punción pleural

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicaciones: diagnóstica en derrame >10 mm de causa no clara o paraneumónico; evacuadora en derrame que causa disnea.
- Técnica: paciente sentado inclinado hacia adelante, línea axilar posterior o escapular, 1-2 espacios bajo el nivel del derrame, idealmente guiada por ecografía; aguja sobre el borde superior de la costilla inferior.
- Muestras: proteínas y LDH (con suero simultáneo), glucosa, pH en jeringa de gases, recuento celular, ADA, citología, Gram y cultivos.
- Evacuadora: no extraer más de 1-1,5 L por sesión (edema pulmonar de reexpansión); suspender si aparece tos intensa, dolor o disnea.
- Complicaciones: neumotórax (radiografía si hay síntomas), hemotórax, reacción vasovagal, punción de hígado o bazo si se punciona muy bajo. Precaución con coagulopatía o anticoagulación.

**PREGUNTAS (2)**

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 124**
> Un paciente de 43 años, con antecedentes de tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, consulta por un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y en ocasiones hemoptoica. Al examen físico, se observa delgado, con T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca: 100x', PA: 118/76 mmHg, saturación arterial de 95% y frecuencia respiratoria: 17x'. Su examen pulmonar muestra crepitaciones y algunos estertores bilaterales y su examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Realizar una prueba de quantiferón para tuberculosis
> **B)** Realizar una broncoscopia
> **C)** Solicitar una prueba de elisa de cuarta generación para VIH
> **D)** Realizar una toracocentesis diagnóstica y evacuadora
> **E)** Solicitar una tomografía axial computarizada (TAC) de tórax
> Respuesta D. La radiografía mostraba un derrame pleural izquierdo en un cuadro de neumonía o tuberculosis. Lo más importante es puncionar: toracocentesis diagnóstica y evacuadora. El quantiferón solo sirve para la tuberculosis latente.

**Pregunta de práctica**

Mujer de 70 años con derrame pleural derecho de causa no aclarada que ocupa un tercio del hemitórax. Se planifica toracocentesis diagnóstica con la paciente sentada, guiada por ecografía. **¿Cuál es el sitio y la técnica correctos de punción?**

**A)** Borde inferior de la costilla superior, en la línea medioclavicular
**B)** Borde superior de la costilla inferior, en la línea axilar posterior o escapular, un espacio bajo el nivel del derrame
**C)** 2.º espacio intercostal en la línea medioclavicular
**D)** Bajo el 10.º espacio intercostal para asegurar el máximo de líquido
**E)** Sitio indistinto si se usa aguja fina

Respuesta B. El paquete vasculonervioso intercostal corre por el borde inferior de cada costilla; por eso se punciona sobre el borde superior de la costilla inferior. Con la paciente sentada, en la línea axilar posterior o escapular, idealmente guiado por ecografía, y sin bajar demasiado para no puncionar hígado o bazo.

## 1.05.5.010 Resucitación cardiorespiratoria

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

### QUÉ HAY QUE SABER

- Soporte vital básico: asegurar la escena, comprobar respuesta, pedir ayuda, llamar a emergencias y pedir DEA; verificar respiración y pulso en ≤10 s (jadeo = paro).
- Compresiones de alta calidad en el centro del tórax: 100-120/min, 5-6 cm en adultos, reexpansión completa, interrupciones <10 s y cambio de reanimador cada 2 min.
- Relación 30:2 en adultos (un reanimador en todas las edades); en niños y lactantes con 2 reanimadores, 15:2. Lactante: 2 dedos o dos pulgares, profundidad ~4 cm; niño ~5 cm.
- DEA lo antes posible: encender, seguir instrucciones, descarga si es ritmo desfibrilable y reanudar compresiones de inmediato.
- Con vía aérea avanzada: compresiones continuas y 1 ventilación c/6 s. Paro respiratorio con pulso: 1 ventilación c/6 s sin compresiones.
- Evitar hiperventilar (aumenta la presión intratorácica y la distensión gástrica); continuar hasta que llegue soporte avanzado o se recupere la circulación.

### PREGUNTAS (1)

**Pregunta de práctica**

Hombre de 58 años colapsa en la sala de espera. No responde, no respira normalmente y no se palpa pulso carotídeo. Se activa el sistema de emergencia y se pide el desfibrilador. **Mientras llega el desfibrilador, ¿cuál es la técnica correcta de compresiones torácicas?**

**A)** 60-80 compresiones por minuto, profundidad de 2-3 cm, relación 15:2
**B)** Más de 140 compresiones por minuto, profundidad de 7 cm, relación 30:2
**C)** 100-120 compresiones por minuto, profundidad de 3-4 cm, relación 15:1
**D)** 100-120 compresiones por minuto, profundidad de 5-6 cm, relación 30:2
**E)** Ventilar durante 2 minutos antes de iniciar compresiones

Respuesta D. La RCP de alta calidad en el adulto consiste en compresiones a 100-120 por minuto, con 5-6 cm de profundidad, reexpansión completa del tórax y mínimas interrupciones, con relación 30:2 sin vía aérea avanzada. Se prioriza iniciar compresiones antes que ventilar (secuencia C-A-B) y desfibrilar apenas se disponga del equipo.

## 1.05.5.011 Ventilación mecánica invasiva

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) · Tema 5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

### QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: Glasgow ≤8, paro o paro inminente, fracaso de la VMNI (empeoran pH y PaCO2 en 1-2 h, sopor, secreciones, vómitos), shock, hipoxemia refractaria (SDRA).
- SDRA: ventilación protectora con Vt 6 mL/kg de peso ideal, presión plateau ≤30 cmH2O, PEEP optimizada y prono ≥16 h/día si PaFi <150.

- Parámetro de seguridad: la presión plateau refleja la presión alveolar; la peak incluye la resistencia de la vía aérea.
- Ventilación prolongada (>10-14 días o destete fallido): traqueostomía electiva.
- Complicaciones: neumonía asociada al ventilador, barotrauma (neumotórax), volutrauma, inestabilidad hemodinámica. Nivel del médico general: indicar, intubar si es necesario y derivar a UCI.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta de práctica**

Hombre de 72 años con exacerbación de EPOC, en ventilación mecánica no invasiva desde hace 2 horas. Ahora está en sopor, Glasgow 8, con abundantes secreciones que no logra expectorar y vómitos. FR 36/min. Gases: pH 7,17, PaCO2 88 mmHg (al ingreso pH 7,28 y PaCO2 68 mmHg). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

**A)** Mantener la ventilación no invasiva y aumentar la presión inspiratoria
**B)** Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva
**C)** Bicarbonato de sodio endovenoso
**D)** Cambiar a oxígeno con mascarilla de alto flujo al 100 %
**E)** Naloxona endovenosa

Respuesta B. Fracaso de la ventilación no invasiva: empeoramiento del pH y la PaCO2 tras 1 a 2 horas, compromiso de conciencia, incapacidad de manejar secreciones y vómitos. Son contraindicaciones para continuarla y obligan a intubar y conectar a ventilación invasiva. Insistir con la máscara retrasa la intubación y aumenta la mortalidad.

**Pregunta de práctica**

¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse rigurosamente por debajo de 30 cmH2O para prevenir el barotrauma alveolar en un paciente con SDRA? **¿Cuál es el parámetro?**

**A)** Presión inspiratoria peak (Ppeak)
**B)** Presión meseta o plateau (Pplateau)
**C)** Nivel de presión positiva al final de la espiración (PEEP)
**D)** Presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP)
**E)** Presión venosa central (PVC)

Respuesta B. La presión plateau, medida con una pausa al final de la inspiración, refleja la presión estática sobre el alvéolo. Mantenerla ≤ 30 cmH2O previene la sobredistensión y el barotrauma. La presión peak incluye la resistencia de la vía aérea y puede subir sin sobredistender el alvéolo.

## 1.05.5.012 Ventilación mecánica no invasiva

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) · Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

**QUÉ HAY QUE SABER**

- Indicaciones de primera línea: exacerbación de EPOC con acidosis hipercápnica (pH 7,25-7,35 y PaCO2 >45) en paciente vigil y cooperador, y edema pulmonar cardiogénico (CPAP o BiPAP).
- Beneficio: reduce la intubación en >50% y la mortalidad intrahospitalaria en EPOC exacerbado; descansa el músculo y lava el CO2.
- Parámetros iniciales BiPAP: IPAP 10-15 cmH2O, EPAP 4-6 cmH2O, con O2 titulado a SatO2 88-92%; reevaluar gases en 1-2 h.
- Contraindicaciones (intubar): paro o paro inminente, Glasgow <8 o no protege la vía aérea, shock con drogas vasoactivas, vómitos incoercibles, trauma facial grave, secreciones abundantes.
- Si fracasa (empeora pH/PaCO2, compromiso de conciencia): intubación sin demora. Nivel del médico general: reconocer la indicación y derivar a unidad de cuidados intermedios o intensivos.

**PREGUNTAS (2)**

**Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 163**

Un paciente de 72 años, con antecedente de tabaquismo de 50 paquetes/año, complicado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa en tratamiento con salmeterol y fluticasona inhalados, presenta aumento de su tos y disnea desde hace 3 días, agregándose expectoración mucopurulenta y fiebre hasta 38,4 °C. Luego evoluciona con marcado aumento de su disnea, la que se vuelve de reposo. Al examen físico se observa agitado, orientado en tiempo y espacio, disneico, con uso de musculatura accesoria, frecuencia respiratoria: 40 rpm, saturación de oxígeno: 84%, frecuencia cardíaca: 108 lpm y presión arterial: 146/92 mmHg. El examen pulmonar muestra aumento del diámetro torácico, hipersonoridad a la percusión, sibilancias y roncus bilaterales difusos, con algunos crépitos más intensos en el lado derecho. Los gases arteriales muestran: $PaO_2$: 65 mmHg, $PaCO_2$: 55 mmHg, $HCO_3^-$: 28 mEq/L, pH: 7,29. Su hemograma muestra hematocrito: 50%, hemoglobina: 17 g/dL, plaquetas: 380.000/mm³ y glóbulos blancos: 14.500/mm³. Se inicia nebulización con broncodilatadores y se administran antibióticos y corticoides por vía endovenosa. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo respiratorio?**

**A)** Oxígeno por mascarilla Venturi al 50%
**B)** Oxígeno por mascarilla de no recirculación
**C)** Oxígeno por naricera al 24%
**D)** Oxígeno por cánula nasal de alto flujo a 15 L/min
**E)** Ventilación mecánica no invasiva

Respuesta E. Acidosis respiratoria hipercápnica (pH 7,29, PaCO2 55): el problema es ventilatorio, no de oxigenación. Subir el oxígeno no corrige el CO2 y puede empeorarlo. Paciente orientado, sin contraindicaciones: VMNI.

**Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar**

Paciente con EPOC exacerbado con pH <7,30 y pCO2 >49 mmHg tras O2, broncodilatadores, antibióticos y corticoides. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

**A)** Intubación orotraqueal e inicio de VMI
**B)** Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP)
**C)** Aumentar FiO2 a 60%
**D)** Heliox y magnesio endovenoso
**E)** Traslado a UCI sin cambiar manejo

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP) (opción B). Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.